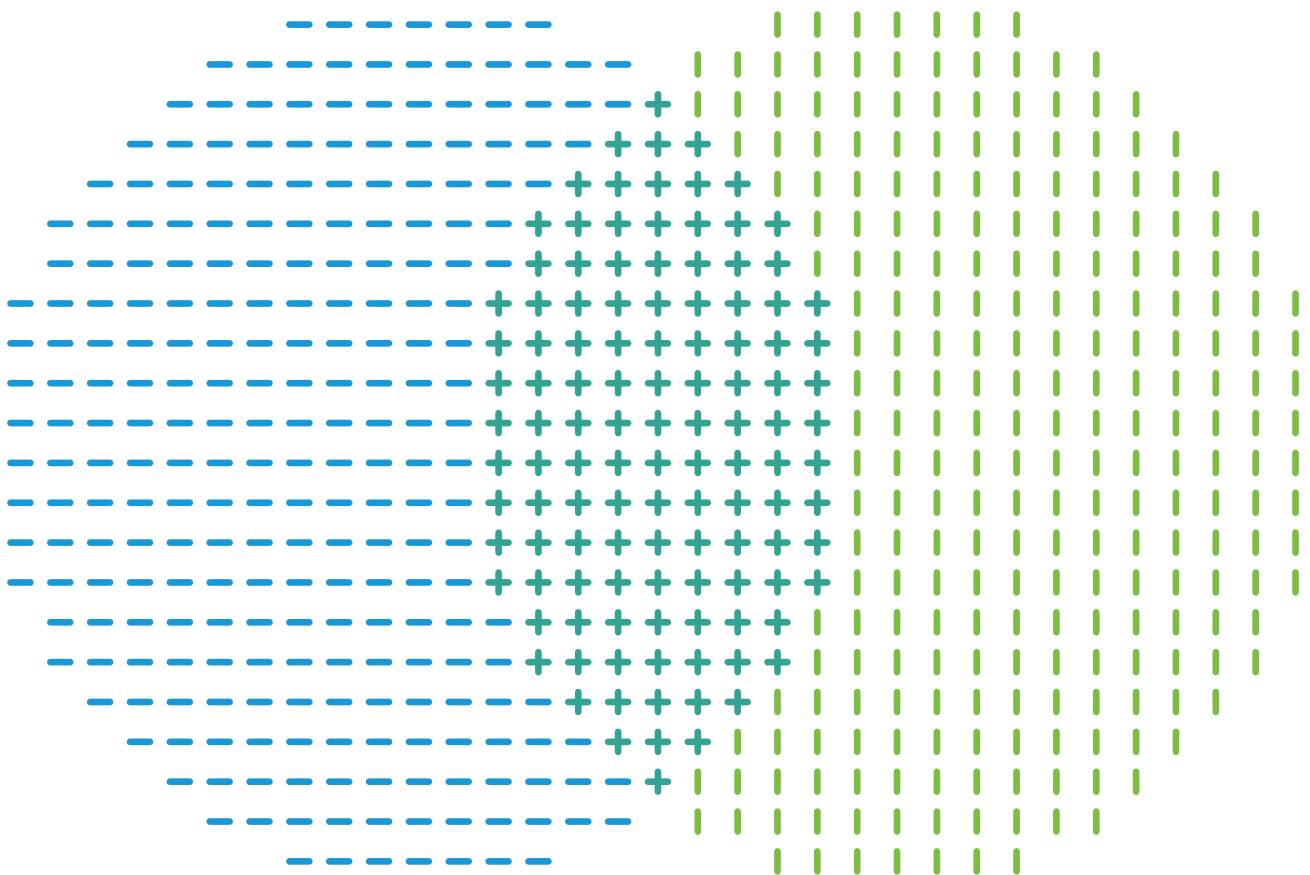

Acuerdos bilaterales sobre la migración y movilidad de los trabajadores de salud

Maximizar los beneficios para los sistemas de salud y salvaguardar los derechos y el bienestar del personal de salud mediante una contratación internacional justa y ética



Acuerdos bilaterales sobre la migración y movilidad de los trabajadores de salud

Maximizar los beneficios para los sistemas de salud y salvaguardar los derechos y el bienestar del personal de salud mediante una contratación internacional justa y ética

Washington, D.C., 2025

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

Versión oficial en español de la obra original en inglés

Bilateral agreements on health worker migration and mobility: maximizing health system benefits and safeguarding health workforce rights and welfare through fair and ethical international recruitment

© Organización Mundial de la Salud, 2024

ISBN: 978-92-4-007305-0 (versión electrónica)

Acuerdos bilaterales sobre la migración y movilidad de los trabajadores de salud: maximizar los beneficios para los sistemas de salud y salvaguardar los derechos y el bienestar del personal sanitario mediante una contratación internacional justa y ética

ISBN: 978-92-75-32972-6 (PDF)

ISBN: 978-92-75-12972-2 (versión impresa)

© Organización Panamericana de la Salud, 2025

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales de Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente, como se indica más abajo. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

Adaptaciones: si se hace una adaptación de la obra, debe añadirse, junto con la forma de cita propuesta, la siguiente nota de descargo: “Esta publicación es una adaptación de una obra original de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las opiniones expresadas en esta adaptación son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente los criterios de la OPS”.

Traducciones: si se hace una traducción de la obra, debe añadirse, junto con la forma de cita propuesta, la siguiente nota de descargo: “La presente traducción no es obra de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción”.

Cita propuesta: Organización Panamericana de la Salud. Acuerdos bilaterales sobre la migración y movilidad de los trabajadores de salud: maximizar los beneficios para los sistemas de salud y salvaguardar los derechos y el bienestar del personal sanitario mediante una contratación internacional justa y ética. Washington, D.C. OPS, 2025.

Disponible en: <https://doi.org/10.37774/9789275329726>.

Datos de catalogación: pueden consultarse en <http://iris.paho.org>.

Ventas, derechos y licencias: para adquirir publicaciones de la OPS, diríjase a sales@paho.org. Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase www.paho.org/es/publicaciones/permisos-licencias.

Materiales de terceros: si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros —como cuadros, figuras o imágenes—, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales: las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OPS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OPS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

HSS/HR/2025

Índice

Prólogo	iv
Prefacio	v
Agradecimientos	vi
Abreviaciones	vii
Resumen	viii
1. Antecedentes	1
1.1 Justificación	3
2. Objetivos	5
2.1 Público destinatario, alcance, aplicabilidad	6
3. Métodos	7
4. Principales conclusiones	8
4.1 Conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica	8
4.2 Conclusiones extraídas del análisis textual y de las entrevistas con las partes interesadas clave	9
5. Consideraciones de política y buenas prácticas clave	17
6. Consideraciones relativas a la aplicación	22
7. Función de la Secretaría de la OMS	33
Referencias	34
Anexo 1	Revisión bibliográfica rápida acerca de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud 38
Anexo 2	Gestión ética de la movilidad internacional de los trabajadores de salud: análisis textual de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud 54
Anexo 3	Entrevistas con partes interesadas clave: acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud 71
Anexo 4	Otros instrumentos internacionales: principales disposiciones relativas a la migración y a la movilidad internacional de los trabajadores de salud 78

Prólogo

A mitad de camino hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible para el 2030 relativo a la cobertura universal de salud, más de la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a servicios de salud esenciales y 2000 millones de personas tienen dificultades financieras debido a los gastos en salud. Para corregir estas inequidades, es fundamental abordar las brechas existentes en el número y la distribución de los trabajadores asistenciales y de salud a nivel mundial. Todos los países afrontaban importantes retos en cuanto al personal de salud incluso antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus del 2019 (COVID-19), y se prevé una brecha mundial estimada de 10 millones de trabajadores asistenciales y de salud para el 2030, principalmente en los países de ingresos bajos y medianos.

La pandemia de COVID-19 expuso y agravó los puntos débiles y las desigualdades en materia de salud de los sistemas de salud que han surgido como resultado de décadas de inversión insuficiente. El aceleramiento de la migración internacional de trabajadores asistenciales y de salud desde la pandemia entraña el riesgo de exacerbar la escasez de personal de salud en los países de origen y de hacer perder los logros en materia de salud que tanto les ha costado conseguir, a menos que las contrataciones internacionales se gestionen de forma ética y se aumente la producción de trabajadores en todas partes. El *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud* (“el Código”) tiene como objetivo precisamente eso: vincular la contratación ética de trabajadores de salud a las inversiones en los sistemas de salud.



Dr. Bruce Aylward

Subdirector General

Cobertura Sanitaria Universal y Curso
de la Vida

Organización Mundial de la Salud

El incremento significativo de la demanda de trabajadores de salud y de su migración internacional a nivel mundial ha hecho aumentar el uso de acuerdos bilaterales entre los países de destino y origen para facilitar la contratación internacional de estos trabajadores.

El presente documento relativo a acuerdos bilaterales sobre la migración y movilidad de los trabajadores de salud ha sido elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como parte del programa “Trabajar en pro de la salud”. En él se abordan las lagunas críticas que existen en las orientaciones para la elaboración de acuerdos bilaterales mutuamente beneficiosos tanto sobre la movilidad de los trabajadores de salud como sobre las inversiones necesarias para fortalecer los sistemas de salud en los países de ingresos bajos y medianos. Se proporcionan orientaciones prácticas sobre la preparación, negociación, aplicación y evaluación de una nueva generación de acuerdos bilaterales de ese tipo.

Alentamos a las autoridades nacionales a que utilicen estas orientaciones cuando elaboren políticas y acuerdos bilaterales que abarquen la movilidad y la migración del personal de salud. Al aprovechar el potencial del Código, podemos acelerar el progreso hacia la cobertura universal de salud, la seguridad de la salud y los objetivos de desarrollo más amplios respecto de la salud, la educación, la igualdad de género y el crecimiento económico.



Sr. Stefano Scarpetta

Director de Empleo, Trabajo y Asuntos
Sociales

Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos

Prefacio

El *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud*, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en el 2010, proporciona un marco mundial general para mejorar la gobernanza mundial y reducir al mínimo las consecuencias negativas de la migración de trabajadores de salud, en particular de los países en desarrollo.

Trece años después de la adopción del Código, con sus disposiciones explícitas sobre el intercambio de información y el seguimiento, la OMS ha consolidado más datos que nunca sobre las tendencias y características mundiales de la migración internacional de los trabajadores de salud. Esta base de evidencia confirma que la gestión ética de las prácticas de contratación internacional sigue siendo un reto importante para los gobiernos de todo el mundo, lo que suscita preocupación en cuanto a la sostenibilidad del personal de salud y la equidad en materia de salud.

La pandemia de COVID-19 ha sido un duro recordatorio de que la seguridad de la salud mundial y la economía mundial están estrechamente vinculadas. La escasez de trabajadores de salud antes de la pandemia en prácticamente todos los entornos de salud, junto con el aumento de la demanda de trabajadores de salud durante la pandemia, ha acelerado aún más el ritmo de la migración internacional de estos trabajadores.

En este contexto, tanto los países de origen como los de destino deben asumir la carga de las repercusiones, los retos y las oportunidades de la movilidad internacional de los trabajadores de salud en sus sistemas de salud y en la economía en general, incluso en relación con

las disposiciones normativas consagradas en los instrumentos de políticas mundiales y el papel de la diplomacia internacional y el compromiso multilateral.

La elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de acuerdos entre gobiernos que aborden específicamente el fortalecimiento de los sistemas de salud tienen un potencial que no se ha aprovechado, por ejemplo, cuando tales acuerdos aprovechan los beneficios mutuos de la migración internacional de los trabajadores de salud tanto en los países de origen como de destino, y también para los propios trabajadores de salud.

Con estas nuevas orientaciones, se exploran a fondo estas oportunidades que no se han aprovechado. El objetivo es promover las buenas prácticas en el diseño y la difusión de acuerdos bilaterales de movilidad internacional y migración, así como destacar la importancia de la aplicación basada en la evidencia y la publicación de libre acceso. Complementan el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y proporcionan orientaciones prácticas paso a paso dirigidas a los países sobre cómo elaborar acuerdos bilaterales justos y éticos.

Se alienta a los Estados Miembros y a otras partes interesadas a que optimicen el uso de estas orientaciones cuando negocien dichos acuerdos. Juntos podemos trabajar para lograr un mejor enfoque en relación con la migración de trabajadores de salud basado en la equidad y la ética que nos beneficie a todos.



James Campbell

Director del Departamento de Personal
Sanitario

Organización Mundial de la Salud

Agradecimientos

La conceptualización y la elaboración de los contenidos de las orientaciones estuvieron a cargo de Agya Mahat, Giorgio Cometto e Ibadat Dhillon, con la supervisión de James Campbell (Departamento de Personal Sanitario de la Organización Mundial de la Salud [OMS]). El Departamento de Personal Sanitario de la OMS forma parte del grupo orgánico de Cobertura Sanitaria Universal y Sistemas de Salud.

El desarrollo del producto también contó con el apoyo de Maren Hofpe, Natalia Popova y Christiane Wiskow (Organización Internacional del Trabajo [OIT]); y Jean-Christophe Dumont (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]) mediante el programa “Trabajar en pro de la salud”.

La Secretaría de la OMS dirigió la conceptualización de las orientaciones, seleccionó los miembros del Grupo de Expertos Técnicos, facilitó las reuniones del Grupo de Expertos Técnicos y dirigió la redacción del documento de orientaciones y las posteriores rondas de revisión. La Secretaría de la OMS estuvo integrada por los siguientes funcionarios de la OMS: Giorgio Cometto y Agya Mahat (sede de la OMS); Adam Ahmat (Oficina Regional de la OMS para África); José García Gutiérrez (Organización Panamericana de la Salud); Ibadat Dhillon (Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental); Cris Scotter y Tomás Zapata (Oficina Regional de la OMS para Europa); Gulin Gedik Fethye (Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental); y Masahiro Zakoji (Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental). Jean-Christophe Dumont (OCDE); y Maren Hofpe y Natalia Popova (OIT) también contribuyeron a la redacción de secciones específicas del documento. Teena Kunjumen y Tapas Sadasivan Nair (sede de la OMS) proporcionaron los datos más recientes sobre los trabajadores de salud de las Cuentas Nacionales del Personal de Salud. Entre los miembros de la Secretaría del programa “Trabajar en pro de la salud” también estaban Ayat Abu-Agla y Paul Marsden (sede de la OMS). Onyema Ajuebor, Khassoum Diallo, Siobhan Fitzpatrick, Catherine Kane, Michelle McIsaac, Tapas Sadasivan Nair, Amani Siyam y Pascal Zurn (sede de la OMS) hicieron aportaciones para las versiones preliminares de las orientaciones.

El Grupo de Expertos Técnicos perfeccionó el alcance de las orientaciones, examinó la evidencia y elaboró las consideraciones normativas. Entre los miembros figuraban los siguientes: Elsheikh Badr (anteriormente

de la Junta de Especialización Médica de Sudán); Mukul Bakhshi (CGFNS International y Alliance for Ethical International Recruitment Practices, Estados Unidos de América); Howard Catton (Consejo Internacional de Enfermeras); Rupa Chanda (Indian Institute of Management Bangalore, India y Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico); Sarah Cliff y Dave Howarth (Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); Helen Dempster (Center for Global Development, Estados Unidos de América); Ulrich Dietz y Alexandra Shale (Ministerio Federal de Salud de Alemania); Enrico Fos (Departamento de Relaciones Exteriores, Filipinas); André Gariépy (Oficina de Profesiones, Quebec, Canadá); Genevieve Gencianos (Internacional de Servicios Públicos); Percy Mahlathi (Departamento de Salud de Sudáfrica); Moeketsi Modisenyane (Departamento de Salud de Sudáfrica); Ali Sani (Organización de la Salud de África Occidental); Pretchell P. Tolentino (Departamento de Salud de Filipinas); y Carlos Van der Laet y Vassily Yuzhanin (Organización Internacional para las Migraciones). Se recopilaron las declaraciones de intereses de los miembros del Grupo de Expertos Técnicos, las cuales se gestionaron de conformidad con las políticas de la OMS.

Se contrató a Innovation Insights a fin de que se encargara de la investigación para fundamentar el contenido de las orientaciones. Jennifer Brant, Skylar Furley y Caitlain Wright (Innovation Insights) realizaron una revisión bibliográfica rápida (anexo 1); Jennifer Brant y Eduardo Escobedo (Innovation Insights) e Ibadat Dhillon (OMS) realizaron el análisis textual de los acuerdos (anexo 2); y Jennifer Brant (Innovation Insights) llevó a cabo las entrevistas con las partes interesadas clave (anexo 3). James Buchan (Health Foundation, Reino Unido; Universidad Tecnológica de Sídney, Australia), y Antonia Carzaniga y Joscelyn Magdeleine (Organización Mundial del Comercio) revisaron las versiones preliminares de las orientaciones.

Se recibió apoyo financiero para la elaboración y difusión de las orientaciones del Fondo Fiduciario Multipartito del programa “Trabajar en pro de la salud” y de la Alianza en pro de la Cobertura Sanitaria Universal (Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Reino Unido y la OMS).

Abreviaciones

ASEAN	Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (por su sigla en inglés)
COVID-19	enfermedad por el coronavirus del 2019
GIZ	Agencia Alemana de Cooperación Internacional (por su sigla en alemán)
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMS	Organización Mundial de la Salud
UE	Unión Europea
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Resumen

Antecedentes

La migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud han aumentado en cuanto a su volumen y complejidad en las últimas décadas. Los órganos regionales desempeñan un papel cada vez más importante en facilitar la prestación transfronteriza de servicios de salud. Entre las diversas vías para el desplazamiento de estos trabajadores, los acuerdos entre los gobiernos ofrecen un potencial importante para asegurar que estos trabajadores y los sistemas de salud de los países participantes se beneficien de la migración y la movilidad de estos trabajadores.

Objetivos

Los objetivos de las orientaciones son los siguientes:

- describir la diversidad de acuerdos gubernamentales sobre la migración y la movilidad del personal de salud que ya existen;
- determinar prácticas prometedoras; y
- articular consideraciones de política para fundamentar el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos sobre migración y movilidad, en consonancia con los objetivos y principios del *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud* (“el Código”) y otros instrumentos internacionales pertinentes.

Estas orientaciones constituyen una herramienta para mejorar la capacidad de los actores estatales implicados en la elaboración, la negociación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de acuerdos relacionados con la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud, de conformidad con las disposiciones del Código.

Alcance

En este documento se presentan algunas consideraciones operativas y de política para los países que negocian acuerdos sobre la migración y movilidad de los trabajadores de salud. En él se reseñan los principios fundamentales, las consideraciones

de política y las prácticas prometedoras para la negociación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos bilaterales y regionales de migración y movilidad, manteniendo en primer plano las prioridades del sistema de salud. Se abordan también la gama de cuestiones que suelen tratarse en este tipo de acuerdos, como la gobernanza, la protección, la seguridad del paciente, el reconocimiento de las calificaciones, el acceso a la capacitación en idiomas y de otro tipo, el apoyo financiero y de otro tipo a los países de origen, y programas para ayudar a los trabajadores de salud que llegan a integrarse en el país receptor (o “país de destino”). Las consideraciones de política presentadas en este documento se aplican a todos los acuerdos entre gobiernos que se centran en la migración y la movilidad de estos trabajadores, tienen un componente relativo a estos temas o pueden tener algún efecto en ellos.

Proceso y métodos

La OMS elaboró estas orientaciones en respuesta a solicitudes específicas de sus Estados Miembros. El documento se deriva de las recomendaciones del Grupo Consultivo de Expertos sobre el examen de los diez años del Código, y representa una herramienta para apoyar la aplicación de algunos de sus aspectos. También está en consonancia con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y con las normas internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta herramienta complementa las orientaciones sobre acuerdos bilaterales de migración laboral de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración¹ y está en consonancia con ellas. Las orientaciones se elaboraron como parte del programa “Trabajar en pro de la salud” de la OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su plataforma de movilidad internacional, iniciativa codirigida por la OMS, la OCDE y la OIT.

La evidencia principal para fundamentar el contenido de estas orientaciones se recopiló mediante una revisión bibliográfica rápida, el análisis textual de 37 acuerdos y 22 entrevistas con las partes interesadas.

1 Véase el documento *Orientaciones sobre acuerdos bilaterales de migración laboral*. Disponible en: https://migrationnetwork.un.org/system/files/resources_files/21-448_es_IOM%20EE%20UU%20-%20Guidance%20on%20bilateral%20labour%20migration%20agreement__V3-4%20April%202022%20FINAL_2_0.pdf.

Conclusiones

La evidencia puso de manifiesto una variedad de acuerdos entre gobiernos que influyen en la migración y la movilidad de los trabajadores de salud. Los acuerdos tienen por objeto promover la economía y el comercio, la educación y la salud, la migración y la movilidad laborales, y el apoyo humanitario y filantrópico. Los acuerdos bilaterales de migración y movilidad de estos trabajadores tienden a ser una respuesta a las necesidades del sector de la salud de los países de destino y, en algunos casos, con una participación significativa limitada de los ministerios de salud de los países de origen. En particular, el 59% de los acuerdos se centran en la migración laboral, o en las prioridades económicas y comerciales, en lugar de promover los objetivos de las políticas de salud. Por consiguiente, la elaboración y la aplicación de estos acuerdos son liderados por diferentes entidades.

Independientemente del ámbito del enfoque de los acuerdos, todos los trabajadores de salud que pertenecen a profesiones reguladas deben cumplir los requisitos regulatorios del país de destino a fin de ser elegibles para ejercer y cumplir las normas de seguridad del paciente. La evaluación de las calificaciones obtenidas en otro país es un componente importante de los requisitos para la entrada al ejercicio en el país receptor o de destino, y toda diferencia significativa en las calificaciones debe superarse adoptando las medidas establecidas. Si bien algunos países han firmado acuerdos específicos para el reconocimiento de calificaciones, esto no equivale a un permiso para comenzar la práctica, ya que puede haber requisitos adicionales establecidos por el organismo regulador que se consideren necesarios para fomentar la seguridad del paciente (por ejemplo, requisitos de idioma, examen de licencia).

En algunos casos, los acuerdos bilaterales de migración y movilidad de trabajadores de salud han permitido a los gobiernos de los países de origen contribuir a una migración y una movilidad más seguras y ordenadas para su personal de salud. La evidencia disponible indica que los elementos de los derechos y el bienestar de estos trabajadores se incorporan cada vez más en la mayoría de los acuerdos. Al mismo tiempo, las consideraciones de género suelen estar ausentes en los textos de los acuerdos, a pesar de que la salud es una esfera de la prestación de servicios fuertemente basada en el género. Las disposiciones relativas a la migración circular también son una característica o un objetivo de algunos acuerdos, pero la evidencia de este resultado es escasa, en particular cuando el propósito de la movilidad es conseguir empleo en otro país.

Aún no se ha aprovechado el potencial de los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud para fortalecer los sistemas de salud de los países de origen, a pesar de ser fundamental para los objetivos del Código. La capacidad de negociación, las desigualdades socioeconómicas y la dinámica de poder entre los países participantes

en los acuerdos colocan a los países de destino de ingresos altos, que tienen pocos incentivos para apoyar los sistemas de salud en los países de origen, en una posición intrínsecamente más ventajosa durante la negociación y la aplicación de los acuerdos. Por otro lado, la posición de los países de origen se ve aún más debilitada por los factores de expulsión y atracción, y la realidad de que el desplazamiento simultáneo de los trabajadores de salud seguirá ocurriendo a través de vías alternativas en diferentes direcciones.

Si bien los acuerdos bilaterales han permitido a los países de origen limitar hasta cierto punto las consecuencias negativas de la migración y la movilidad de los trabajadores de salud, no han generado inversiones en el fortalecimiento de los sistemas de salud. La participación limitada de los ministerios de salud en la elaboración y aplicación de estos acuerdos también podría haber contribuido a ello. Además, es difícil estimar las posibles repercusiones en los sistemas de salud producidas por el número total de trabajadores de salud que salen de un país por sí solos, sin información sobre las competencias, la experiencia y la especialidad de estos trabajadores. Las conclusiones indican que, incluso si el país de destino hace una contribución financiera a la educación en el país de origen, esto no compensa la pérdida de personal de salud con varios años de experiencia en esferas técnicas especializadas debido al tiempo adicional que les toma a los trabajadores de salud de alto nivel adquirir dicha experiencia. Algunos países de origen podrían enfrentar un ciclo interminable de inversiones continuas para mejorar las competencias de estos trabajadores que luego son contratados internacionalmente, dejando a su población a cargo de trabajadores de salud inexpertos.

Lagunas de la evidencia

Los datos sobre la aplicación y la evaluación de los acuerdos son escasos o inexistentes. La falta de mecanismos específicos de seguimiento y evaluación no permite realizar una evaluación exhaustiva de la eficacia y los efectos de los acuerdos en el fortalecimiento del sistema de salud y en el bienestar de los trabajadores de salud, ni siquiera determinar si los acuerdos se aplicaron ni en qué medida se lograron los objetivos.

Consideraciones clave en materia de políticas y buenas prácticas

El avance hacia la creación de una nueva generación de acuerdos bilaterales justos y éticos, o la revisión y actualización de los existentes, que sean equilibrados respecto de los beneficios para todas las partes, debe dar prioridad al derecho al goce del grado más alto posible de salud de las personas tanto en los países de origen como en los de destino. Esto requerirá que los signatarios definan explícitamente los tipos y montos de las inversiones y el apoyo, así como otras salvaguardias esenciales, que beneficiarán al sistema de salud del país de origen.

Para ello, se recomienda un enfoque intersectorial, con una participación sustancial del ministerio de salud, en la elaboración, negociación y aplicación de estos acuerdos. Se requiere una evaluación de las necesidades del sistema de salud que incluya un análisis del mercado laboral de salud para fundamentar los objetivos y las opciones normativas en los acuerdos, como también estrategias más amplias para lograr las metas socioeconómicas y de salud. Para asegurar la coherencia, reconocer las prioridades, generar sinergias y responder a inquietudes se necesita, en cada etapa de la elaboración, la aplicación y la evaluación de un acuerdo, la implicación de todas las partes interesadas competentes, incluidos los gobiernos (por ejemplo, los ministerios de salud, educación, relaciones exteriores, migración, trabajo y comercio) y las entidades no gubernamentales (representantes de los empleadores y trabajadores de salud, sindicatos, organismos reguladores, asociaciones de la diáspora o grupos de migrantes, asociaciones profesionales, actores del sector privado, etc.). La recopilación de datos sobre la aplicación de los acuerdos, junto con una mayor

transparencia, puede respaldar la evaluación en cuanto a si se lograron los objetivos de los acuerdos y los efectos en los sistemas de salud de los países implicados y en los derechos y el bienestar de los trabajadores de salud. Esto es esencial para contribuir al creciente acervo de conocimientos sobre las innovaciones y las mejores prácticas emergentes encaminadas a maximizar los beneficios de la migración y la movilidad de estos trabajadores para todas las partes. Los informes trienales de los Estados Miembros sobre la aplicación del Código son un mecanismo adecuado para recopilar e intercambiar esa información.

En estas orientaciones se presentan algunas consideraciones clave en materia de políticas y buenas prácticas para fundamentar la conceptualización y el contenido de los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud (figura ES1) junto con las consideraciones de aplicación durante las diferentes fases de elaboración y ejecución de estos acuerdos.

Figura R1. Acuerdos bilaterales: consideraciones de política

Todos los acuerdos bilaterales deben:



contribuir a la **sostenibilidad de la fuerza laboral, la cobertura universal de salud y la seguridad** de la salud en los países de origen y destino;



especificar cómo la **alianza fortalecerá los sistemas de salud** de ambos países;



incluir **salvaguardias y apoyo** adicionales a los países con vulnerabilidades en relación con la fuerza laboral;



asegurar la **igualdad de trato** de los trabajadores de salud capacitados en su país y en el extranjero;



planificar y atender las **necesidades en materia de género** de los trabajadores de salud;



incluir un mecanismo de **seguimiento y evaluación** con un circuito de **comentarios operativo**;



informar a la OMS sobre arreglos y la aplicación de los acuerdos.

1. Antecedentes

La movilidad y la migración internacionales afectan a todos los sectores de la economía. Los trabajadores migrantes representan 169 millones de los 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo (1), lo que convierte a la migración laboral en el principal motor de la migración internacional.

Las normas de la OIT sobre la migración laboral definen como “trabajador migrante” a toda persona que emigra de un país a otro para ocupar un empleo (2, 3). Si bien no todos los trabajadores de salud que se desplazan a nivel internacional cumplen los requisitos de la definición de trabajador migrante (por ejemplo, en los casos en que el objetivo principal del desplazamiento sea la educación, el apoyo técnico, la asistencia humanitaria o el comercio), en aras de la simplicidad y teniendo en cuenta que el empleo es el objetivo principal de la mayoría de los trabajadores de salud que se desplazan a nivel internacional, el presente documento se refiere sistemáticamente a los trabajadores de salud “migrantes”.

A los efectos del presente documento, se entiende por “movilidad” todo desplazamiento (físico o virtual) de trabajadores de salud y estudiantes de ciencias de la salud de un país a otro, independientemente de su condición, propósito, dirección o duración del desplazamiento. La migración se refiere al desplazamiento físico hacia otro país, independientemente del motivo o la condición jurídica, por una duración de 3 a 12 meses (migración temporal o a corto plazo), o a un cambio de país de residencia por una duración de un año o más (migración a largo plazo o permanente).

La migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud son cada vez más cuantiosas y complejas. Por ejemplo, sobre la base de los datos más recientes disponibles de las Cuentas Nacionales del Personal de Salud,² más de uno de cada cinco profesionales de medicina de 37 países, zonas y territorios y más de uno de cada cinco profesionales de enfermería de 30 países, zonas y territorios se han capacitado en el extranjero (4); y en los países de la OCDE, alrededor de una cuarta parte de los profesionales de medicina y el 16% de los de enfermería han nacido en el extranjero (5). El patrón de migración y movilidad de los trabajadores de salud no se limita

al desplazamiento desde países de ingresos bajos y medianos hacia países de ingresos altos, sino que también incluye el desplazamiento desde países de ingresos altos hacia países de ingresos bajos y medianos, así como el desplazamiento sustancial tanto dentro de los países de ingresos altos como de los de ingresos bajos y medianos (6).

La gran demanda de trabajadores de salud en los países de ingresos altos ha sido provocada por los cambios de las necesidades de servicios de salud, el envejecimiento poblacional y la escasez de personal de salud. Esto ha producido un aumento de la migración y la movilidad internacionales de estos trabajadores desde principios del siglo XXI, como lo demuestra el aumento del 60% de la migración internacional de los trabajadores de salud a los países de la OCDE hasta el 2016 (7). Las necesidades cada vez mayores y los cambios de la estructura de la demanda relacionados con la respuesta a la pandemia (2020-2022) han acelerado aún más la contratación internacional de estos trabajadores (8, 9).

Existen varias vías para la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud, de acuerdo con el propósito del desplazamiento, entre los que se incluyen educación, huida de conflictos u otras formas de desplazamiento, misiones humanitarias, voluntariado a corto plazo, empleo temporal o a largo plazo y comercio. El desplazamiento puede tomar la forma de inscripción directa en programas de educación o contratación directa para empleo; o mediante agencias e intermediarios públicos o privados para la educación, la contratación y el empleo; también puede formar parte del libre desplazamiento dentro de las comunidades económicas regionales o en el contexto de acuerdos gubernamentales en materia de salud, educación, comercio o trabajo. El proceso y los criterios para evaluar las competencias y calificaciones mediante el reconocimiento de credenciales o la concesión de licencias a los trabajadores de salud es un factor importante en la decisión de desplazarse a través de las fronteras.

La migración y la movilidad de los trabajadores de salud son resultado de decisiones individuales que estos trabajadores pueden tomar libremente y de las que pueden beneficiarse, mediante mejoras de las condiciones de trabajo y de vida, ingresos

² Al mes de abril del 2022, 76 países, zonas y territorios habían presentado datos sobre el lugar de capacitación del personal médico y 105 países lo habían hecho respecto del personal de enfermería. Los países de ingresos altos representaron 21 de 37 países donde más del 20% de los profesionales de medicina habían sido capacitados en el extranjero y 12 de 30 países donde más del 20% de los profesionales de enfermería habían sido capacitados en el extranjero.

y también oportunidades educativas y de desarrollo profesional. Sin embargo, la migración laboral también puede tener repercusiones en el sistema de salud del país del que salen estos trabajadores (el país de origen) y en el país donde eligen trabajar (el país de destino). La inversión realizada por los gobiernos y las sociedades en los países de origen respecto de la educación y capacitación de los trabajadores de salud tendrá efectos limitados en el propio país de origen si una proporción sustancial de trabajadores de salud capacitados y experimentados sale del país. En cambio, las personas de los países de destino obtienen una mayor parte de los beneficios a medida que estos trabajadores llegan a estar disponibles sin que sus gobiernos tengan que invertir en su educación y desarrollo profesional. Las consecuencias de la migración y la movilidad excesivas, no planificadas y no gestionadas, de los trabajadores de salud desde los países que afrontan vulnerabilidades en su fuerza laboral preexistentes pueden ser devastadoras. En tales casos, esto puede exacerbar la escasez de personal para las poblaciones más vulnerables, empeorando así las inequidades en materia de salud.

Las preocupaciones relativas a los efectos negativos que tiene la migración del personal de salud en los países de origen llevaron a la adopción del *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud* por parte de la 63.^a Asamblea Mundial de la Salud en el 2010 (denominado “el Código”) (10). El Código, junto con la *Lista de la OMS para el apoyo y la salvaguardia del personal de salud* (11), promueve la gestión justa y ética de la contratación internacional, incluso mediante acuerdos bilaterales,³ para salvaguardar los derechos y el bienestar de los trabajadores de salud migrantes. Además, procura mitigar los efectos negativos que tiene la migración en los sistemas de salud de los países de origen mediante la asistencia técnica y el apoyo financiero para el desarrollo del personal de salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud. El Código también alienta a los países a que desarrollen una capacidad interna suficiente para gestionar y hacer el seguimiento de esos acuerdos.

Además del Código, un conjunto de instrumentos internacionales ayuda a configurar el entorno normativo internacional para la migración y la movilidad internacionales en diferentes sectores. Estos instrumentos también pueden influir en la elaboración y la aplicación de acuerdos gubernamentales sobre la migración y la movilidad de los trabajadores de la salud. Entre ellos cabe destacar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (12), el Pacto Mundial

para la Migración Segura, Ordenada y Regular (13), la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior (14), las normas internacionales del trabajo de la OIT, en particular los convenios fundamentales de la OIT, pero también otros convenios, recomendaciones y protocolos pertinentes, como el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (2) y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (3), y también los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como la *Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares* (15). Durante las emergencias, también se aplica el derecho internacional humanitario.

Los acuerdos bilaterales tienen la posibilidad de contribuir a una migración y una movilidad ordenadas que pueden beneficiar a los trabajadores de salud, así como a los sistemas de salud de los países a través de los que se desplazan. Los acuerdos pueden adoptar varias formas. Se pueden adaptar especialmente para responder a las necesidades y prioridades específicas de cada país. Cuando se formulan adecuadamente, estos acuerdos pueden contribuir a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el trabajo decente y el crecimiento económico, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades.

Los posibles beneficios para los países de destino que se derivan de la migración y la movilidad de los trabajadores de salud se relacionan con su contribución a la respuesta a las necesidades insatisfechas de los servicios de salud, desempeñando así un papel crucial en la promoción del derecho humano a la salud y el crecimiento socioeconómico. A nivel individual, los trabajadores de salud migrantes pueden aumentar sus ingresos (cuando existen diferencias salariales entre los países de origen y de destino) o progresar en su educación, capacitación y desarrollo profesional.

Algunas estimaciones indican que el comercio de servicios mediante el desplazamiento de los trabajadores de salud representa más de 3000 millones de dólares anuales.⁴ En algunos casos, las remesas de los migrantes contribuyen significativamente a la economía de su país de origen (16), aunque la falta de datos sobre las remesas desglosados por sector de empleo dificulta la tarea de determinar la contribución específica de los trabajadores de salud migrantes.

El efecto de la migración y la movilidad de los trabajadores de salud en los sistemas de salud de los países de origen parece ser, en el mejor de los

3 A los efectos de esta herramienta de orientación, los acuerdos bilaterales sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud se refieren a cualquier acuerdo entre organismos públicos de dos o más países que afecte a la migración y la movilidad de los trabajadores de salud. Dado que ciertos acuerdos pueden implicar a más de dos países (por ejemplo, acuerdos regionales o multilaterales), utilizamos la expresión “acuerdos gubernamentales” indistintamente con “acuerdos bilaterales” a lo largo del presente documento.

4 Las estimaciones del comercio de servicios de salud por modo de suministro se elaboran utilizando la metodología de la OMC sobre datos relativos al comercio de servicios por modo de suministro (TISMOS, por su sigla en inglés) (2019, sobre la base de las recomendaciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas del 2012), que se mejoró aún más en el 2021. Próximamente se publicará un nuevo conjunto de datos de TISMOS. Para más información, véase el contenido de la OMC “Estadísticas sobre el comercio de servicios comerciales” (https://www.wto.org/spanish/res_s/statistics/tradeserv_stat_s.htm).

casos, mixto. Existe evidencia de que la migración y la movilidad internacionales pueden contribuir al aumento de la dotación total de profesionales de enfermería, al tiempo que afectan negativamente a la calidad (17). Sin embargo, el aumento de la dotación no fue suficiente para aumentar la densidad nacional del personal de enfermería (18). Los beneficios teóricos indirectos que la migración y la movilidad de los trabajadores de salud pueden generar para los sistemas de salud de los países de origen incluyen: la contribución de la red de la diáspora respecto de las competencias; la transferencia de conocimientos y tecnología, así como iniciativas de creación de capacidades. Sin embargo, la evidencia de que estos efectos positivos se materialicen realmente es muy limitada (19, 20). Si bien la asistencia internacional para el desarrollo del personal de salud ha aumentado en los últimos años, esta se ha concentrado en gran medida en actividades a corto plazo más que en intervenciones para la sostenibilidad de la fuerza laboral (21). Por otro lado, los argumentos en contra del aumento de la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud incluyen la reducción de la base de capacidades y competencias en los países de origen (22, 23).

1.1 Justificación

Como marco general que vincula la contratación internacional de trabajadores de salud con el fortalecimiento de los sistemas de salud (24), el Código sigue siendo el instrumento principal que sirve de base para la elaboración de acuerdos sobre migración y movilidad de estos trabajadores con miras a fortalecer los sistemas de salud de todos los países participantes, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos.

Está aumentando el interés en el uso de acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales sobre la migración y la movilidad de los trabajadores de salud (24). Al mismo tiempo, parece poco probable que todos los países hayan podido obtener beneficios suficientes de ellos, por diversas razones. Las desigualdades socioeconómicas tienen profundas raíces históricas (25) y siguen influyendo en la dinámica de poder entre los países (26, 27). Esto puede contribuir a la dificultad que tienen los países de origen para asegurar inversiones y otros beneficios para sus sistemas de salud como parte de sus acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud. Al mismo tiempo, los países de destino tienen pocos incentivos directos para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud de los países de origen.

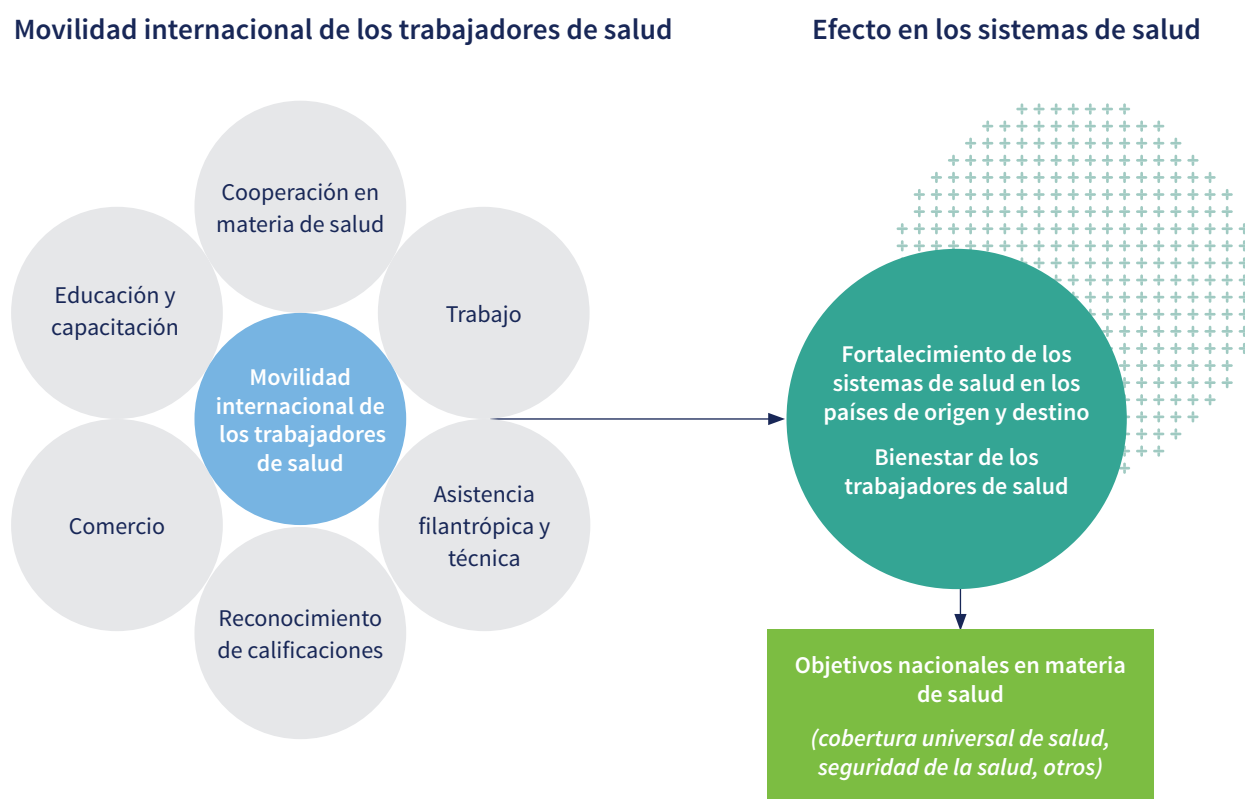
Sin embargo, redundaría en interés de todos los países garantizar que los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud no socaven los objetivos de salud pública y del sistema de salud de los países participantes. Los trabajadores de salud desempeñan

un papel vital en los progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud, igualdad de género, empleo y crecimiento económico, y migración segura, ordenada y regular. Son fundamentales para asegurar el derecho a la salud y son uno de los principales contribuyentes al crecimiento económico (28). En el mundo globalizado de hoy, los efectos de las enfermedades, el cambio climático, los conflictos y el aumento de la migración y la movilidad humanas se sienten en todos los países, continentes y economías. Un sistema de salud débil en cualquier parte del mundo puede poner en peligro la seguridad de la salud internacional, con graves repercusiones para las economías y las sociedades de todo el mundo.

Además, dado que muchos países dependen de los trabajadores de salud migrantes para atender la demanda interna, existe el riesgo de que se produzcan limitaciones de la oferta internacional durante las emergencias y las pandemias. Esto se hizo evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando algunos países introdujeron restricciones a la exportación de recursos esenciales para atender las necesidades internas (29). El fortalecimiento de los sistemas de salud de los países de origen no es solo una responsabilidad ética y moral, sino que también redundaría en interés de la sostenibilidad del personal de salud de los países de destino, la seguridad de la salud mundial y el crecimiento económico.

Además, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, independientemente del color de la piel, el origen étnico, la ubicación geográfica, el género, la nacionalidad, la religión y la condición social o económica (30-32). El progreso hacia la promoción de este derecho humano básico puede verse comprometido si las agendas económicas o políticas más amplias pasan por alto las repercusiones para el sistema de salud y las necesidades de dicho sistema. Si bien el crecimiento económico es esencial para promover la salud pública, no es suficiente para asegurar una buena salud y el bienestar de la población, por lo que debe ir acompañado de inversiones suficientes en los sistemas y el personal de salud. A su vez, una población sana es vital para el crecimiento económico.

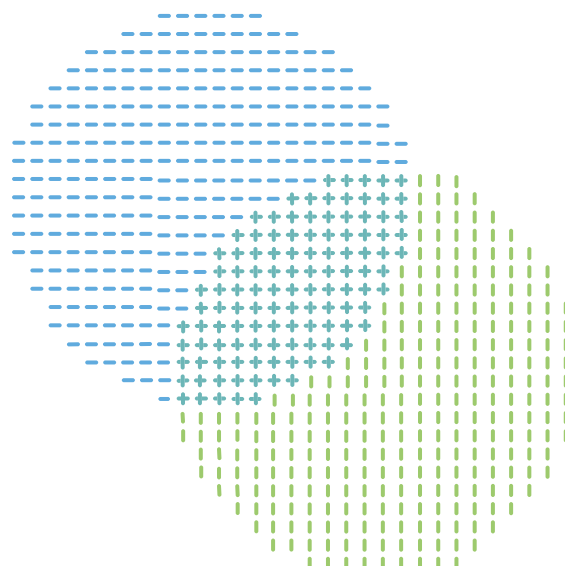
La premisa conceptual en la que se basa este documento es que los acuerdos bilaterales tienen la posibilidad de promover la contratación holística, justa y ética de trabajadores de salud, lo que puede ser mutuamente beneficioso para los sistemas de salud de los países de origen y destino y para los mismos trabajadores de salud, reduciendo así al mínimo las consecuencias negativas imprevistas de la migración y la movilidad y contribuyendo a los objetivos nacionales de salud (figura 1).

Figura 1. Alcance y posibles beneficios de los acuerdos entre gobiernos

Los acuerdos entre gobiernos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud ofrecen la posibilidad de mejorar la gestión del desplazamiento internacional de estos trabajadores y asegurar la convergencia de intereses entre los países participantes. Esos acuerdos no tienen por qué limitarse a la cuestión de la migración y la movilidad del personal. También pueden utilizarse para la cooperación en relación con otros aspectos de los sistemas de salud, y adaptarse a las necesidades específicas de cada país, con el fin de:

- permitir un suministro más predecible de trabajadores de salud migrantes internacionales en los países de destino para subsanar las deficiencias laborales y de competencias o de servicios;
- reducir al mínimo los efectos adversos de la migración y la movilidad de los trabajadores de salud en el país de origen, determinando la cantidad, el tipo y la duración de la migración y la movilidad, a fin de no perjudicar el sistema de salud (sin embargo, este beneficio solo puede materializarse si el acuerdo bilateral es el principal modo de contratación);

- fortalecer el sistema de salud del país de origen subsanando las deficiencias en materia de capacitación, educación y tecnología, y asegurando el apoyo financiero o técnico del país de destino en esferas prioritarias;
- garantizar a los trabajadores de salud una migración y movilidad seguras y ordenadas, así como sus derechos y su bienestar en los países de destino.



2. Objetivos

La meta de estas orientaciones es apoyar la elaboración de acuerdos bilaterales que promuevan las metas nacionales de salud tanto para los países de origen como para los de destino, y salvaguardar el bienestar y los derechos de los trabajadores de salud, al tiempo que se aprovechan las oportunidades de obtener beneficios en otros sectores, como la educación, el comercio, la economía, etc.

La intención de estas orientaciones no es promover ni desalentar el desplazamiento internacional de los trabajadores de salud. En el Código se reconoce el derecho de los trabajadores de salud a desplazarse a través de las fronteras en virtud de las leyes aplicables. Reconociendo que la migración y la movilidad humanas son una realidad, y que existen múltiples vías para el desplazamiento de estos trabajadores, este documento se centra en mejorar los acuerdos gubernamentales que rigen la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud. Para ello, se determinan enfoques que pueden ayudar a asegurar que dichos acuerdos sean éticos y justos, tengan en cuenta los asuntos de género, fortalezcan los sistemas de salud, sean inclusivos, se centren en las personas y se basen en los derechos, y apoyen la sostenibilidad del personal de salud.

Estas orientaciones se prepararon en respuesta a las solicitudes específicas de asistencia técnica de los Estados Miembros de la OMS para la elaboración de acuerdos bilaterales de migración y movilidad del personal de salud, y en consonancia con las recomendaciones del examen dirigido por los Estados Miembros sobre la pertinencia y eficacia del Código. Su objetivo es ser un instrumento para mejorar la capacidad de los actores estatales implicados en la elaboración, la negociación, la implementación, la gobernanza, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos relacionados con la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud, manteniendo las prioridades de los sistemas de salud en primer plano, y en consonancia con las normas internacionales del trabajo de la OIT y otros instrumentos pertinentes.

Estas orientaciones son coherentes con las de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre acuerdos bilaterales de migración laboral (33), que buscan apoyar a los Estados Miembros en la elaboración, la negociación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de acuerdos bilaterales de migración laboral basados en los derechos y que responden a las cuestiones de género en todos los sectores. Entre sus disposiciones, las orientaciones de las Naciones Unidas reconocen que la escasez de personal de salud en los países de origen tiene efectos negativos en la prestación de servicios de salud a su población, y hacen hincapié en la importancia de dar a los trabajadores de salud migrantes el mismo trato que se da a los trabajadores de salud nacionales. El presente documento complementa las orientaciones de todo el sistema de las Naciones Unidas mediante información adicional específica para el sector de la salud (33).

Estas orientaciones representan una herramienta de aplicación para poner en práctica las disposiciones y recomendaciones del Código, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y los instrumentos de derechos humanos. En particular, se centran en las implicaciones que los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud tienen para los sistemas de salud de los países de origen; la preservación del sistema de salud en los países de origen es un principio central del Código. También representan una herramienta de aplicación para apoyar la puesta en práctica de las disposiciones y recomendaciones del Código, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (13), la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico (28) y el programa “Trabajar en pro de la salud” de la OIT, la OCDE y la OMS,⁵ y promueven las normas internacionales del trabajo y los instrumentos de derechos humanos.

5 El programa “Trabajar en pro de la salud” es una alianza conjunta entre la OMS, la OIT y la OCDE para ampliar y transformar el personal de asistencia social y de salud con el fin de impulsar el crecimiento económico inclusivo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para más información, véase https://www.who.int/es/health-topics/health-workforce#tab=tab_1.

Objetivos de las orientaciones

1

Determinar y describir la variedad de acuerdos bilaterales y regionales de migración y movilidad internacionales de los trabajadores de salud.

2

Determinar los retos y las prácticas prometedoras para fomentar los principios del Código, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y los instrumentos de derechos humanos.

3

Brindar consideraciones sobre políticas para la preparación, el diseño, la negociación, la aplicación y el seguimiento y la evaluación de acuerdos bilaterales, de conformidad con el Código.

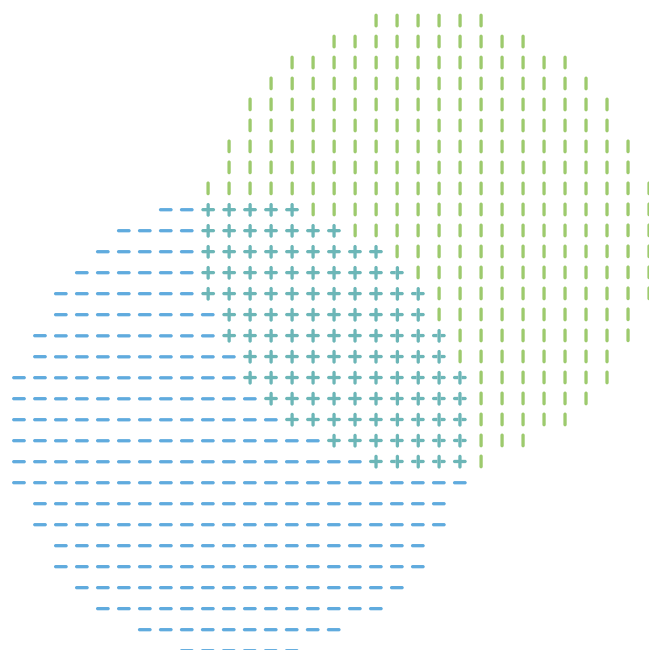
2.1 Público destinatario, alcance, aplicabilidad

Estas orientaciones tienen por objeto informar a los encargados de la formulación de políticas y otros funcionarios de los ministerios de salud y otros sectores (como el de trabajo y relaciones exteriores) que tienen la responsabilidad de diseñar, negociar, elaborar, aplicar, hacer el seguimiento y evaluar los acuerdos gubernamentales respecto de la migración y la movilidad internacionales del personal de salud. Los destinatarios secundarios son las entidades no gubernamentales (incluidos los empleadores públicos o privados, sindicatos, representantes de los trabajadores de salud, organismos reguladores, asociaciones profesionales, instituciones educativas, contratistas y otros) y los representantes de otros ministerios y sectores (como el de educación, comercio y migración), que pueden implicarse mediante diferentes funciones y capacidades en la preparación y redacción, negociación, aplicación, seguimiento y evaluación de acuerdos relacionados con la migración y la movilidad de los trabajadores de salud.

Las orientaciones tienen un alcance mundial. Se prevé que informen y habiliten a los funcionarios, como también a las partes interesadas no gubernamentales en todas las regiones que desempeñan un papel clave en los acuerdos gubernamentales que afectan a la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud, para que formulen acuerdos justos y éticos que defiendan el derecho al goce del grado más alto posible de salud de todas las personas en todos los países.

Para mayor claridad, cuando se hace referencia a las corrientes de migración y movilidad, en estas orientaciones se utilizan las expresiones “país de origen” y “país de destino”. Esto se debe a un reconocimiento de la dirección predominante del desplazamiento del personal de salud entre dos países, generalmente impulsado por diferencias salariales, oportunidades de ingresos y perspectivas de educación y desarrollo profesional. Esta distinción no es rígida, y las orientaciones no excluyen la posibilidad de que los países puedan ser al mismo tiempo un país de origen para los trabajadores de salud que se desplazan al extranjero y un país de destino para los que ingresan desde otros países.

Si bien las orientaciones están dirigidas a los acuerdos bilaterales de migración y movilidad de los trabajadores de salud, muchos de sus elementos son aplicables a otros acuerdos regionales o multilaterales. Los gobiernos y otras partes interesadas pueden utilizar este documento a la hora de considerar y negociar acuerdos con un componente de migración y movilidad de los trabajadores de salud, o a la hora de evaluar los efectos de dichos acuerdos.



3. Métodos

El proceso para formular el contenido de estas orientaciones incluyó una investigación exhaustiva, basada en los siguientes pasos:

- **una revisión exploratoria rápida de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud (anexo 1);**
- **un análisis textual de los acuerdos bilaterales (y regionales) de movilidad de los trabajadores de salud (anexo 2);**
- **entrevistas con las partes interesadas clave (anexo 3);**
- **validación y revisión entre pares realizadas por el grupo de expertos técnicos.**

Existe poca evidencia publicada sobre la aplicación y los efectos de los acuerdos gubernamentales que afectan a la migración y la movilidad de los trabajadores de salud. En particular, hay poca evidencia sobre los efectos que tienen dichos acuerdos en los sistemas de salud de los países implicados y en los propios trabajadores de salud. Esto también es cierto en relación con los 37 acuerdos cuyo texto está a disposición de la OMS mediante las tres primeras rondas de presentación de informes sobre la aplicación del Código (2012, 2015 y 2018) desde su adopción en el 2010 y mediante la notificación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de acuerdos comerciales regionales que incluyen compromisos en materia de servicios de salud (anexo 2).

Para estos acuerdos se llevó a cabo un análisis textual en relación con las implicaciones en:

- el desplazamiento ordenado de los trabajadores de salud;
- el bienestar de los trabajadores de salud que cruzan las fronteras, respecto de sus derechos y condiciones de trabajo; y
- los sistemas de salud de los países implicados.

Es un reto comprender plenamente los procesos que generan los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud, y sus efectos, solo mirando el texto. A modo de ejemplo, los textos de los acuerdos no proporcionan información sobre los antecedentes, las modalidades y el proceso de negociación que condujo a los acuerdos, ni sobre su seguimiento y evaluación, ni sobre los resultados una vez aplicados.

Los detalles pueden figurar en los planes de aplicación (normalmente elaborados como próximos pasos), pero los informes sobre la aplicación o la finalización de los acuerdos normalmente no están disponibles como material complementario; por consiguiente, es difícil saber si se aplicaron los acuerdos y cómo se aplicaron.

Por estas razones, fue necesario complementar el análisis textual mediante entrevistas a fondo con partes interesadas clave que tienen experiencia directa en la preparación y redacción, la negociación, la aplicación, el seguimiento o la evaluación de acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud. El número de partes interesadas fue de 22. Las personas se seleccionaron inicialmente a través de una muestra de conveniencia inicial, y a esto le siguió un muestreo de bola de nieve. El grupo de entrevistados estuvo integrado por expertos de entidades gubernamentales de los países de origen y destino, representantes sindicales, órganos consultivos y trabajadores de salud migrantes (anexo 3).

Los actores del sector privado (por ejemplo, empleadores, contratistas) no estuvieron representados entre los entrevistados porque la atención se centró en la vía de los acuerdos gubernamentales para la migración y la movilidad. Además, el enfoque de muestreo de bola de nieve no detectó ningún interesado directo del sector privado que cumpliera los criterios de inclusión en el período en que se llevaron a cabo las entrevistas. Las entrevistas exploraron cómo y por qué se elaboraron y negociaron los acuerdos, la consonancia entre el contenido de los acuerdos y la aplicación posterior, y los logros, retos y enseñanzas extraídas.

El grupo de expertos técnicos fue convocado por la OMS para contribuir a la determinación y priorización de los temas que debían tratarse como parte de la investigación y la elaboración de las orientaciones, la interpretación de la evidencia recopilada y la validación de las conclusiones y consideraciones de política. El grupo de expertos técnicos estuvo integrado por representantes de los países de origen y destino, expertos temáticos y funcionarios de los organismos implicados en los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud.

4. Principales conclusiones

4.1 Conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica

La revisión rápida mostró que los acuerdos bilaterales relativos a la migración y la movilidad de los trabajadores de salud varían significativamente en cuanto a sus objetivos, forma, contenido y alcance. Se han utilizado diferentes tipos de acuerdos bilaterales y regionales para facilitar la contratación de trabajadores de salud migrantes a fin de mitigar la escasez de personal y el desempleo (34), subsanar la mala distribución (35), como componente de los acuerdos sobre el comercio de servicios de salud (36), promover la educación y la capacitación de los trabajadores de salud (37), facilitar la migración y la movilidad intrarregionales de los profesionales de la salud (38), fomentar la cooperación en materia de salud (39), facilitar la migración y la movilidad seguras, especialmente para las mujeres (40), y responder a las emergencias y apoyar la prestación de servicios en zonas subatendidas (41, 42).

Varios instrumentos internacionales establecen principios y recomendaciones sobre diferentes elementos de esos acuerdos (véase el anexo 4). El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) establece un marco de cooperación con objetivos, compromisos y acciones para mejorar la gobernanza de la migración y la movilidad de los trabajadores. Fomenta la elaboración de acuerdos gubernamentales que promuevan el desarrollo de competencias, la movilidad profesional y los programas de intercambio profesional. Hace suyos los resultados favorables al desarrollo de los países de origen mediante inversiones en capital humano (13).

Las normas de la OIT (convenios, recomendaciones y protocolos) incluyen normas de aplicación general, instrumentos que contienen disposiciones específicas sobre los trabajadores migrantes, instrumentos específicos sobre los trabajadores migrantes e instrumentos de seguridad social que son aplicables a estos trabajadores (2, 3, 43, 44). Las normas internacionales del trabajo se aplican a todos los

trabajadores, incluidos los trabajadores (de salud) migrantes, a menos que se indique lo contrario (45). Por lo tanto, una amplia gama de normas de la OIT se aplica a los trabajadores de salud migrantes, pero existen dos instrumentos específicos, en particular el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) y la Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157).

Asimismo, la Recomendación núm. 157 se refiere específicamente a la cooperación internacional, incluidos los acuerdos bilaterales o multilaterales, y se refiere a varias cuestiones pertinentes, como la educación y la capacitación en el extranjero, el reconocimiento de calificaciones, la contratación, la repatriación y la seguridad social (46, 47). Además, en la *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*, enmendada en el 2022, se exige a los Estados Miembros de la OIT que promuevan, respeten y apliquen los principios y derechos en el trabajo establecidos en la declaración y que están cubiertos por los diez convenios que se han definido como fundamentales (48). Estos principios y derechos fundamentales se aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de salud migrantes. Igualmente, los *Principios generales y directrices para la contratación equitativa y Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos* de la OIT (2019), el *Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales* y las *Orientaciones sobre acuerdos bilaterales de migración laboral* también se han elaborado para apoyar la contratación justa (33, 49).

La Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) asegura el derecho de las personas a que se evalúen sus calificaciones relativas a la educación superior utilizando mecanismos justos, transparentes y no discriminatorios (14).

Además, los Miembros de la OMC pueden tener compromisos⁶ en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios respecto de la presencia temporal de personas extranjeras que prestan

6 Si la salud no está excluida de la cobertura del acuerdo, y no hay ninguna reserva en cuanto a posibles medidas futuras, entonces son compromisos por defecto.

servicios profesionales relacionados con la salud y servicios sociales y de salud. En la medida en que la migración y la movilidad de los trabajadores de salud estén comprendidas en el modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se refiere al desplazamiento de personas físicas para prestar servicios en el extranjero (extranjeros que trabajan para prestadores de servicios de salud de propiedad extranjera o que trabajan por cuenta propia y están presentes temporalmente en la jurisdicción receptora), los Miembros de la OMC tienen que cumplir la obligación de la nación más favorecida,⁷ independientemente de que hayan asumido o no compromisos específicos del sector.⁸ El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios permite que los acuerdos comerciales regionales o bilaterales entre dos o más economías se desvíen del principio de la nación más favorecida en ciertas condiciones (12).⁹

Los países están utilizando acuerdos gubernamentales sobre la contratación internacional de trabajadores de salud para facilitar la migración y la movilidad ordenadas de dichos trabajadores mediante canales formales y asegurar su bienestar. Están innovando mediante enfoques para gestionar la migración y la movilidad de los trabajadores de salud a fin de asegurar que ambos países se beneficien; un ejemplo de ello son las alianzas de competencias, que combinan la capacitación de estos trabajadores con la migración y la movilidad (50). Los organismos económicos regionales, como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por su sigla en inglés) y la Unión Europea (UE), están fomentando la migración y la movilidad libres dentro de sus regiones (38, 51). En el caso de los ciudadanos de un tercer país, la iniciativa de la UE denominada “Asociaciones para el Talento” (2021) procura afianzar las vías jurídicas para el desplazamiento y las alianzas internacionales en ámbitos prioritarios como la atención médica y de salud (52). La versión actualizada del Código de Prácticas del Reino Unido para la contratación internacional de personal de atención social y de salud, en consonancia con el Código, tiene por objeto fomentar acuerdos gubernamentales mutuamente beneficiosos que fortalezcan los sistemas de salud en los países de origen (53).

Junto con el uso cada vez mayor de acuerdos bilaterales, la evidencia apunta a numerosos retos en cuanto a su negociación y ejecución, incluida la ausencia de mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación. Los retos incluyen la desigualdad de poder y capacidad de negociación, mecanismos de gobernanza no vinculantes sobre migración y movilidad, y relaciones entre países que colocan a los países de destino más ricos en una posición ventajosa para

obtener más beneficios de los acuerdos, mientras que los países de origen pierden trabajadores calificados (51, 54-57). En ciertos casos, parece que los gobiernos de los países de origen han logrado obtener compromisos respecto de recursos a cambio de la salida de personal de salud, dependiendo de la capacidad y la disposición del país de destino (42).

Un reto notable atañe a las situaciones en las que los organismos públicos que lideran la negociación y ejecución de los acuerdos gubernamentales que afectan a los servicios de salud no consultan adecuadamente con el ministerio de salud. Cuando no hay un aporte adecuado del ministerio de salud, esto puede hacer que las agendas políticas y económicas prevalezcan sobre la salud (58).

Entre los retos que plantea la aplicación de los acuerdos cabe mencionar las variaciones en la educación y los sistemas de capacitación y regulación de los países que negocian el acuerdo, junto con las diferencias lingüísticas y culturales; la resistencia por parte de los trabajadores de salud locales en los países de destino a la llegada de trabajadores de salud extranjeros; las preferencias de los trabajadores de salud en cuanto a dónde desplazarse y cuál es su ruta de migración y movilidad; la participación limitada de las partes interesadas, incluidos los actores no estatales, en la elaboración y aplicación de los acuerdos; el costo de aplicar y hacer cumplir los acuerdos, y la posible falta de incentivos para que el país de destino aplique todas las disposiciones; y la falta de mecanismos para evaluar los efectos de los acuerdos (38, 42, 54, 55, 57, 59).

4.2 Conclusiones extraídas del análisis textual y de las entrevistas con las partes interesadas clave

El análisis textual de los acuerdos bilaterales y las entrevistas con las partes interesadas clave proporcionaron abundante evidencia descriptiva sobre la diversidad de los acuerdos bilaterales y sobre los procesos implicados en su negociación, elaboración y aplicación. En la siguiente sección se resume la evidencia obtenida del análisis y de las entrevistas.

Diversidad de los acuerdos

Los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud difieren considerablemente respecto de sus objetivos, el nivel de detalle de las disposiciones, el enfoque de la gestión de la migración y la movilidad, los mecanismos de administración y solución de controversias, y los grupos ocupacionales cubiertos. Los propósitos declarados

7 El principio de la nación más favorecida del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que forma parte de todos los acuerdos de la OMC, refleja la obligación de tratar de la misma manera a los prestadores extranjeros y nacionales de servicios similares.

8 Sin embargo, en el momento en que pasaron a ser miembros de la OMC, se permitía a las economías mantener algunas medidas de nación más favorecida incompatibles si las incluían en lo que se conoce como “exenciones relativas a la nación más favorecida”.

9 Por ejemplo, el acuerdo debe tener una cobertura sustancial, es decir, una cobertura *a priori* de los cuatro modos de suministro de servicios, y prever la ausencia o la eliminación sustancial de toda discriminación entre las partes. También existe la obligación de notificar el acuerdo al Consejo del Comercio de Servicios de la OMC.

de estos acuerdos van desde subsanar las brechas de personal hasta satisfacer las necesidades de innovación, y desde el despliegue de nuevas tecnologías hasta la prestación de apoyo filantrópico, la creación de nueva infraestructura de atención de salud con la ayuda de expertos del extranjero, y una combinación de los objetivos mencionados. Por consiguiente, no existe un formato estándar único o un modelo predominante para estos acuerdos. Esto refleja el hecho de que la situación de la migración y la movilidad de los trabajadores de salud en cada país es única respecto de su objetivo, alcance y contenido. Al mismo tiempo, se pueden detectar ciertos puntos en común y elementos positivos en los diferentes acuerdos que pueden reproducirse en otros lugares.

Sobre la base de la revisión de 37 textos de acuerdos, los acuerdos bilaterales gubernamentales sobre la migración y la movilidad de los trabajadores de salud se pueden clasificar en siete categorías según su ámbito de enfoque predominante (véanse la figura 2 y el anexo 2).

1. **Acuerdos con énfasis en subsanar las brechas de personal en los países de destino y proteger los derechos de los trabajadores de salud migrantes:** estos acuerdos sobre migración laboral tienen como objetivo mitigar la escasez en los sistemas de salud de los países de destino, al tiempo que procuran salvaguardar el bienestar de los trabajadores de salud migrantes, incluido el trato justo de los trabajadores y las prácticas de contratación transparentes. Si bien los acuerdos pueden prever la migración circular, esto no es un requisito, ya que algunos acuerdos mencionan explícitamente las disposiciones para la residencia permanente en el país de destino.
2. **Acuerdos sobre cooperación en materia de salud:** los acuerdos en la categoría de cooperación en materia de salud para beneficio mutuo suelen ser acuerdos marco que establecen los objetivos generales para la cooperación entre los países. Los ámbitos de cooperación pueden abarcar la capacitación y las oportunidades de trabajo temporal, la reforma del sector hospitalario, la cooperación entre hospitales, la investigación y el desarrollo, las intervenciones de emergencia, la adquisición de medicamentos y equipo, etc.
3. **Acuerdos sobre el comercio de servicios:** estos acuerdos se negocian entre dos o más economías y pueden incluir compromisos, y en ciertos casos disposiciones, para la migración y movilidad internacionales temporales de los trabajadores de salud. Los países han utilizado los acuerdos comerciales regionales para reforzar los compromisos en materia de servicios de salud en comparación con los del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en particular permitiendo un mayor acceso a los trabajadores de salud migrantes. Tanto en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios como en los acuerdos

comerciales regionales, los países de destino pueden imponer límites cuantitativos a la entrada de trabajadores de salud migrantes, por ejemplo, condicionando el acceso a la existencia de una necesidad demostrada de sus servicios. Dichos acuerdos incluyen compromisos de tratar a los trabajadores extranjeros de la misma manera en que se trata a los trabajadores nacionales que prestan el mismo servicio, la llamada disposición de la nación más favorecida que generalmente se encuentra en los acuerdos comerciales.

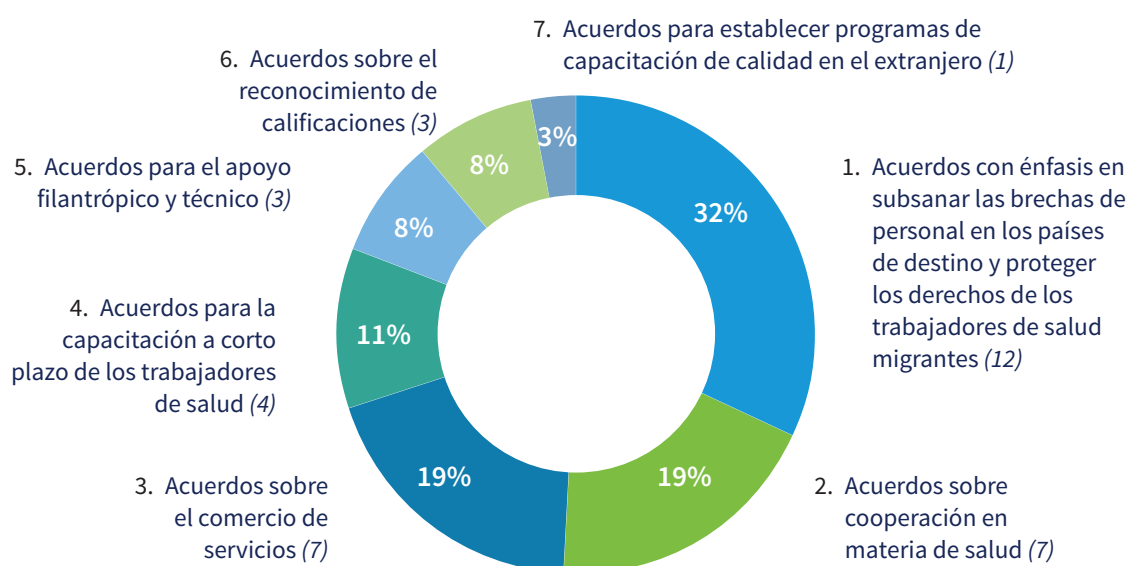
4. **Acuerdos para la capacitación a corto plazo de los trabajadores de salud:** estos implican a instituciones de educación para la salud en los países de destino que brindan educación y capacitación a los trabajadores de salud de los países de origen. Los acuerdos a menudo se negocian en el contexto de una estrategia de salud más amplia para el país de origen, y la migración circular es una de las disposiciones previstas de los acuerdos. Los trabajadores de salud de los países de origen reciben una capacitación superior a la que habrían recibido en su país de origen, y los países de destino se benefician de que estos trabajadores presten servicios temporalmente en su sistema de salud.
5. **Acuerdos para el apoyo filantrópico y técnico:** estos acuerdos incluyen disposiciones sobre migración y movilidad temporales en las que una de las partes brinda apoyo específico para subsanar las brechas en los servicios de salud, a veces en el contexto de emergencias. En algunos casos también pueden incluir elementos de cooperación para beneficio mutuo.¹⁰ Los objetivos generales de estos acuerdos incluyen mejorar la educación y la capacitación del personal de salud del país de destino para fortalecer la prestación de servicios. Algunos acuerdos incluyen disposiciones sobre las condiciones de empleo de los trabajadores de salud en el país de destino una vez finalizados los términos y la duración de la asistencia técnica.
6. **Acuerdos sobre el reconocimiento de calificaciones:** estos acuerdos tienen como objetivo principal fomentar la prestación de servicios de salud por parte de los trabajadores de salud que se desplazan a nivel internacional y los trabajadores migrantes, facilitando el reconocimiento de las calificaciones de los trabajadores. Los requisitos para las diferentes ocupaciones pueden variar. Los organismos reguladores de cada país conservan la autoridad para invalidar las disposiciones del acuerdo de armonización a fin de proteger al público. Por lo general, estos acuerdos se limitan al reconocimiento de las calificaciones de categorías específicas de ocupaciones de salud y, en realidad, no crean canales para la contratación internacional.

10 Se consideró que existía un “beneficio mutuo” si se podía determinar el beneficio tanto para el país de origen como para el de destino.

7. Acuerdos para establecer programas de capacitación de calidad en el extranjero: este tipo de acuerdo tiene como objetivo mejorar la educación de los trabajadores de salud en el país de origen en consonancia con los estándares del país de destino y brindar oportunidades de empleo a los graduados del país de origen en

el país de destino. Dichos acuerdos tienen por objeto facilitar la colaboración entre expertos, instituciones académicas, facultades y hospitales, incluidos los intercambios de docentes entre los países de origen y destino. Puede haber varias opciones de empleo en el país de destino, con o sin cláusula de retorno al país de origen.

Figura 2. Acuerdos sobre las categorías de migración y movilidad de los trabajadores de salud ($n = 37$)



Arreglos institucionales

Los países con una experiencia significativa en acuerdos bilaterales de migración de los trabajadores de salud tienden a contar con un marco bien establecido para la negociación y la aplicación de los acuerdos, incluida la especificación de los organismos responsables. En ellas participan las partes interesadas competentes dentro y fuera de diversos organismos públicos (por ejemplo, organismos reguladores, instituciones académicas, asociaciones profesionales, agencias de contratación, empleadores, sindicatos, etc.). Los países de origen, en particular los que son nuevos en el uso de acuerdos gubernamentales para la migración y la movilidad de los trabajadores de salud, pueden carecer de esa infraestructura organizativa. También pueden disponer de mecanismos institucionales y recursos específicos limitados para negociar y aplicar acuerdos.

Los organismos responsables de los acuerdos internacionales de migración y movilidad de los trabajadores de salud varían según el país y en relación con la categoría del acuerdo. A modo de ejemplo, los acuerdos que hacen hincapié en mitigar la escasez de personal de salud y proteger los derechos de los trabajadores de salud migrantes parecen estar dirigidos en su mayoría por entidades gubernamentales centradas en el empleo y, a veces, por ministerios de relaciones exteriores, de economía o del interior, mientras que los centrados en la educación, la cooperación en materia de salud y el apoyo filantrópico y técnico suelen estar dirigidos por los ministerios de salud (véanse la figura 3 y el anexo 2).

Figura 3. Número de acuerdos con el ministerio de salud como signatario

Acuerdos centrados en subsanar las brechas en la fuerza laboral de los países de destino y en proteger los derechos de los trabajadores de salud migrantes ($n = 9$)

Acuerdos de cooperación en materia de salud ($n = 5$)

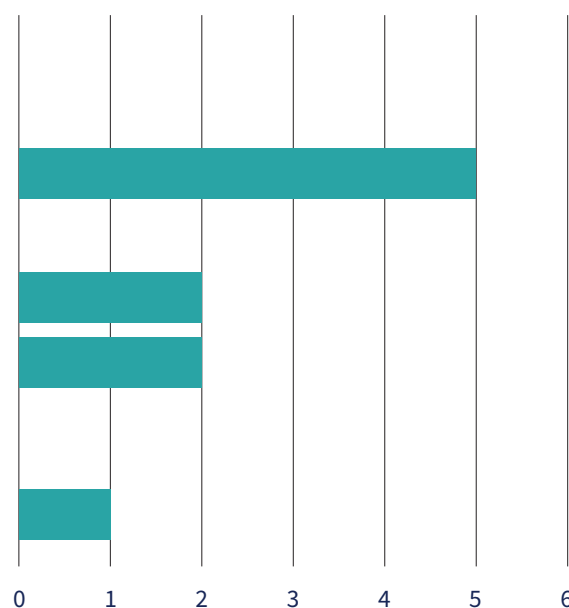
Acuerdos sobre el comercio de servicios ($n = 7$)

Acuerdos para la capacitación a corto plazo de los trabajadores de salud ($n = 2$)

Acuerdos para el apoyo filantrópico y técnico ($n = 2$)

Acuerdos sobre el reconocimiento de calificaciones ($n = 3$)

Acuerdos para establecer programas de capacitación de calidad en el extranjero ($n = 1$)



Sobre la base de la categoría del acuerdo y los factores específicos de los países negociadores, los signatarios de los acuerdos gubernamentales pueden ser los departamentos u organismos competentes dentro del ministerio de desarrollo económico, relaciones exteriores, salud, del interior o de inmigración, industria, comercio, trabajo, etc. Los signatarios de los países de origen y destino no son necesariamente los interlocutores técnicos de los mismos ministerios, sino que pueden representar a otros organismos públicos. En dos tercios de los textos examinados,¹¹ el ministerio de salud no fue signatario del acuerdo (anexo 2). Los acuerdos centrados en el reconocimiento de las calificaciones, la mitigación de las brechas de personal y la protección del comercio y los derechos de los trabajadores de salud fueron firmados todos por ministerios ajenos al ámbito de la salud, incluidas, por ejemplo, entidades públicas dedicadas al comercio, el desarrollo económico, las relaciones exteriores, el interior, el trabajo y el comercio, etc.

Las entrevistas con las partes interesadas indicaron que la elaboración de acuerdos gubernamentales puede ser provocada por diversos factores, entre ellos, la estrategia del sector de la salud, razones económicas, el desempleo, la educación, las relaciones internacionales, el comercio y gestos políticos. A menudo, los acuerdos no están precedidos ni se basan en una evaluación de las necesidades del sistema de salud, en un análisis del mercado laboral de la salud ni siquiera en una preparación cuidadosa de la estructura institucional y los procesos regulatorios para poner en práctica los acuerdos tanto en los países de origen como en los de destino.

Los temas centrales en los acuerdos a menudo reflejan diferentes objetivos de diferentes organismos públicos y grupos de partes interesadas, lo que puede ser complicado de gestionar, seguir y evaluar a lo largo del tiempo. Algunos países cuentan con un mecanismo de coordinación interinstitucional, en el que los coordinadores de cada organismo público competente u otras entidades se reúnen para debatir cuestiones relacionadas con los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud. En algunos casos, los ministerios de salud de los países de origen codirigen o tienen la misma voz en los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud, aunque el proceso de negociación esté dirigido por otro organismo público. En otros, las consultas con el ministerio de salud pueden ser limitadas, o sus aportes pueden no tenerse en cuenta, ya que la autoridad final sobre los términos del acuerdo sigue correspondiendo a otras partes del gobierno.

Beneficio para los sistemas de salud

La mayor parte de los acuerdos tienen como objetivo explícito subsanar la escasez de trabajadores de salud en los sistemas de salud de los países de destino. Sin embargo, a menudo no está claro en estos acuerdos cómo se mantendrá la prestación de servicios de salud en los países de origen, o cuáles son los beneficios previstos que la migración puede generar para el sistema de salud del país de origen. El texto de los acuerdos de cooperación en materia de salud parece impulsar la agenda de salud en algunas esferas específicas, pero estos acuerdos son menos numerosos

11 En 29 de los 37 acuerdos analizados se presentaba información sobre los signatarios. Solo 10 de los 29 acuerdos fueron firmados por el ministerio de salud.

que los comerciales o laborales (anexo 2). En particular, la mayoría de los países disponían de datos limitados sobre la aplicación de los acuerdos y no habían evaluado sus efectos. Esto dificulta saber si los acuerdos fueron beneficiosos para los sistemas de salud de ambos países.

La mayor parte de los acuerdos tienen como objetivo explícito subsanar la escasez de trabajadores de salud en los sistemas de salud de los países de destino.

Muchos países de ingresos bajos y medianos tienen escasez de personal basada en las necesidades, junto con el desempleo de los trabajadores de salud, debido a la limitada capacidad para crear oportunidades de trabajo suficientes e interesantes (60). En algunos de estos contextos, las partes interesadas informaron que los acuerdos para el empleo de trabajadores de salud se percibían como un medio para mitigar el desempleo de la fuerza laboral, que es una prioridad para el gobierno. Sin embargo, aunque este mecanismo apoya a las familias a nivel individual, la inversión o el financiamiento públicos necesarios para aumentar la contratación nacional de trabajadores de salud podrían seguir sin abordarse.

Si bien muchos acuerdos incluyen disposiciones para la migración circular o temporal, e incluso pueden citarlo como un objetivo, puede no ser siempre factible o probable. Por lo general, no se dispone de evidencia de que este resultado se materialice, en particular cuando el propósito de la migración y la movilidad es conseguir empleo en el extranjero. Incluso en los acuerdos con una cláusula explícita de retorno, la situación y la contribución de los trabajadores de salud después del retorno no estaban claras, dado que carecían de especificidad sobre la capacidad de absorción, los niveles de entrada y la remuneración.

Los países de origen parecen tener pocos puntos de influencia para negociar un acuerdo mutuamente beneficioso desde la perspectiva del fortalecimiento de los sistemas de salud. Las partes interesadas informaron que la diferencia sustancial en la remuneración de los trabajadores de salud que existía entre los países, que es el principal factor de atracción para estos trabajadores, junto con el carácter no vinculante del Código, puede colocar a los países de origen en una posición de desventaja.

La posición de los países de origen puede verse aún más debilitada por la realidad de que el desplazamiento de los trabajadores de salud seguirá teniendo lugar por rutas alternativas, de manera paralela al desplazamiento en el marco de acuerdos bilaterales. Debido a todo lo anterior, puede ser difícil lograr que los países de destino se comprometan a compensar a los países de origen por la pérdida de trabajadores de salud, y es difícil hacer cumplir esos compromisos. En el recuadro 1 se resumen algunas de las razones por las que los países de origen han recurrido a acuerdos bilaterales de migración y movilidad de estos trabajadores.

Varias partes interesadas mencionaron la necesidad de invertir en los sistemas de salud de los países de origen para compensar la pérdida de trabajadores de salud. Las modalidades y los arreglos sobre financiamiento concretos tendrían que enunciarse explícitamente en los acuerdos, con beneficios proporcionales a los costos en valor relativo para los sistemas de salud de los países de origen.

Las entrevistas con las partes interesadas indicaron que algunas de las especificaciones para la contratación internacional establecidas por los países de destino (por ejemplo, el requisito de que los trabajadores de salud tengan cierto número de años de práctica) pueden ir en detrimento del acceso a una fuerza laboral calificada en el país de origen y causar mayores desigualdades.

Por ejemplo, la contratación de trabajadores de salud con experiencia en ciertas especialidades, que a veces también tienen responsabilidades de enseñanza o capacitación, puede hacer que la población del país de origen sea atendida por trabajadores de salud comparativamente inexpertos y que disminuya el profesorado. Esto puede provocar un ciclo interminable de inversión pública en capacitación y práctica especializada para compensar la pérdida causada por la migración. Las partes interesadas también señalaron que la pérdida de personal de salud con varios años de experiencia en esferas técnicas especializadas no se compensará de manera adecuada ni equivalente con apoyo financiero prestado por el país de destino en el sistema de educación para la salud del país de origen, debido al tiempo adicional que se necesita para que los trabajadores de salud de alto nivel adquieran la experiencia necesaria. La educación previa al empleo de los nuevos trabajadores de salud es comparativamente más fácil de lograr que el proceso de años de adquisición de experiencia y competencias mediante el mantenimiento de un empleo.

Los acuerdos centrados en la educación y el apoyo técnico pueden beneficiar a los países de origen en cuanto al desarrollo de capacidades. Al mismo tiempo, es importante mantener expectativas realistas respecto de los efectos prácticos en la prestación de servicios de salud en estos países.

El número de estos acuerdos y el número de trabajadores de salud que tienen acceso a oportunidades de capacitación especializada mediante estos arreglos pueden ser sumamente limitados en comparación con los cientos o incluso miles de

trabajadores de salud que se desplazan al país de destino por diferentes vías. Cuando persisten las causas profundas de la movilidad y la migración, la retención de trabajadores de salud esenciales puede seguir planteando un reto para muchos países de origen.

Recuadro 1. En la mayoría de los casos no se encontró evidencia de que los sistemas de salud de los países de origen se beneficiaran, a pesar de que esto es fundamental de conformidad con el Código

Las entrevistas con las partes interesadas indicaron que parecía que los países de origen firmaban acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud por diversas razones. Entre ellas se encuentran: hacer frente a los retos del desempleo; permitir el acceso a los mercados internacionales; asegurar el bienestar de sus ciudadanos en el extranjero; aumentar la capacidad de su sistema de salud; y, en algunos casos, promover su agenda de cooperación internacional y asistencia para el desarrollo, y obtener beneficios en otros sectores.

Si bien algunos acuerdos establecen el fortalecimiento de la colaboración a largo plazo y unos cuantos acuerdos se comprometen a apoyar el fomento de la capacidad en los países de origen, esto generalmente se limita a declaraciones genéricas de mejores esfuerzos (anexo 2). En uno de esos acuerdos, el compromiso del país de destino de apoyar una iniciativa para aumentar la capacidad del sistema de salud en el país de origen no pudo cumplirse, al parecer, debido a problemas de financiamiento.

A menudo se espera que la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud aporten nuevos conocimientos y competencias al sistema de salud del país de origen a través de la migración circular. Sin embargo, se observó que puede ser difícil aplicar algunas de esas competencias en el país de origen debido a las diferencias contextuales y a la escasez de recursos y tecnologías.

En cambio, los acuerdos bilaterales permiten a los gobiernos de los países de origen asegurar hasta cierto punto la sostenibilidad de la fuerza laboral. Los gobiernos pueden decidir respecto de la cantidad y la categoría de los trabajadores de la salud que se desplazan a otro país sin que esto perjudique su sistema de salud. Si bien algunos países han impuesto un límite máximo anual a los trabajadores de salud que salen del país con visados de trabajo para mitigar la escasez interna o han establecido un requisito de servicio público durante cierto número de años después de la finalización de la capacitación, otros han limitado la elegibilidad de los trabajadores de salud para el desplazamiento en virtud de acuerdos sobre migración y movilidad para empleos a mediano y largo plazo a trabajadores de salud desempleados y grupos ocupacionales que no tienen gran demanda en el mercado nacional. Algunos países han concertado acuerdos adicionales con el mismo país de destino para aumentar la capacidad en esferas prioritarias.

La contratación de trabajadores de salud con experiencia y de alto nivel puede provocar un ciclo interminable de inversión pública en capacitación y práctica especializada para compensar la pérdida causada por la migración.

Bienestar de los trabajadores de salud

Las disposiciones que salvaguardan el bienestar de los trabajadores de salud migrantes son una característica notable de la mayoría de los acuerdos bilaterales (anexo 2). Las partes interesadas señalaron que los retos a los que se enfrentan estos trabajadores con los contratistas privados o mientras se desplazan de un país a otro individualmente para obtener empleo (respecto de costo, seguridad y transparencia) pueden superarse mediante acuerdos gubernamentales o beneficiarse de ellos. En la mayoría de los acuerdos, el costo de la contratación de trabajadores de salud lo cubren las entidades de los países de destino, no cada trabajador de salud, y esta es una de las principales ventajas que llevan a estos trabajadores a optar por la vía del acuerdo bilateral para la migración y la movilidad.

Las salvaguardias de los trabajadores de salud en los acuerdos se centran generalmente en el derecho a recibir un contrato por adelantado, condiciones de trabajo justas, incluida una remuneración adecuada, apoyo para comprender las condiciones del contrato, apoyo para prepararse a vivir y trabajar en el país de destino, acceso a la atención de salud y a las prestaciones de protección social, oportunidades de capacitación y procesos transparentes de migración, movilidad y contratación, entre otros. Algunos acuerdos también incluyen disposiciones para la solución de controversias, brindan apoyo en el proceso de inmigración y permiten que las familias de los trabajadores de salud se reúnan con ellos en el país de destino. Los sindicatos desempeñan un papel esencial a la hora de asegurar que los acuerdos tengan debidamente en cuenta los derechos y el bienestar de los trabajadores de salud.

Los países con experiencia en migración y movilidad internacional de trabajadores de salud cuentan con procedimientos específicos y agencias importantes que se encargan de la aplicación y gestión de los diferentes tipos de acuerdos sobre migración y movilidad de estos trabajadores. En el caso de los acuerdos de empleo, el proceso de migración puede ser gestionado por un organismo público designado y los términos del acuerdo pueden aplicarse también a los contratistas privados, exigiéndoles que respeten los términos del acuerdo junto con las entidades del sector público. La reglamentación de la contratación privada en los países de origen y destino puede tener lugar mediante la legislación nacional y las disposiciones normativas fundamentadas en el Código, o aplicarse condicionando sus licencias al cumplimiento de los términos de los acuerdos gubernamentales.

En el caso de los acuerdos para el apoyo filantrópico y la asistencia técnica, los países de origen son generalmente responsables del gasto del viaje y la remuneración de los trabajadores de salud, pero los países de destino pueden proporcionar subsidios adicionales y complementarios (anexo 2).

Algunos acuerdos establecen disposiciones detalladas para la integración profesional y personal en el país de destino. La creación de fondos de bienestar para los trabajadores se incluyó en algunos acuerdos para apoyar a los trabajadores migratorios que los necesitaban. Sin embargo, las partes interesadas señalaron la necesidad de informar a las comunidades de los países de destino sobre las calificaciones profesionales de los trabajadores internacionales, ya que sus homólogos y colegas locales o los miembros de la comunidad pueden necesitar garantías sobre su situación oficial, profesional o académica.

A pesar de que la prestación de servicios de salud es una esfera fuertemente basada en el género (61), no parece haberse considerado una perspectiva específica de género en ninguno de los acuerdos analizados: por ejemplo, ninguno de los acuerdos menciona el derecho a la licencia de maternidad, dejando de hecho

la concesión de tales prestaciones a la aplicación de la legislación y las políticas nacionales en los países de destino.

Reconocimiento de calificaciones

El reconocimiento de las calificaciones es una característica importante de los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud en las diferentes categorías (anexo 2). Si bien la calificación del trabajador de salud obtenida en el país de origen puede ser reconocida, no se traduce necesariamente en equivalencia ni da lugar a una licencia para ejercer en el país de destino.

La evaluación de la forma en que la capacitación en los países de origen de los trabajadores se ajusta a los requisitos de los países de destino es un factor esencial para la migración y la movilidad de los trabajadores de salud. Por consiguiente, los países de origen negocian acuerdos bilaterales y regionales que rigen el reconocimiento de las calificaciones por parte de los países de destino. Estos acuerdos de reconocimiento (mutuo) benefician a los trabajadores de salud que se desplazan en virtud de acuerdos bilaterales y regionales de migración y movilidad de estos trabajadores, así como a los que se desplazan entre estos países a través de otras vías. Estos acuerdos pueden ayudar a gestionar las preocupaciones sobre el trato diferenciado que se da a los trabajadores de salud calificados en función de su país de origen y el programa de capacitación en el país.

Los acuerdos sobre el reconocimiento de calificaciones son resultado de un proceso en el que se prevé que las autoridades de los países de origen certifiquen que los trabajadores de salud poseen las calificaciones requeridas para su jurisdicción, y los organismos reguladores de los países de destino examinan y comparan detenidamente la educación y la capacitación de estos trabajadores en ambos países para detectar similitudes y cualquier diferencia y deficiencia significativas, y luego definir maneras de tener en cuenta esas deficiencias al otorgar un permiso para ejercer. Se trata de un ejercicio para detectar, compensar y gestionar las diferencias en la capacitación y la preparación, por ejemplo, mediante una capacitación adicional o complementaria o mediante la concesión de una licencia parcial.

La responsabilidad última de aceptar a los trabajadores en función de sus calificaciones, especialización y experiencia recae en los países de destino. En el caso de las profesiones de la salud reguladas, deben cumplirse los requisitos reglamentarios de los profesionales de la salud de los países de destino, que pueden incluir, por ejemplo, demostrar competencia para las esferas de práctica previstas, estar familiarizados con el idioma local, tener un número mínimo de años de experiencia laboral, presentar un certificado de acreditación emitido recientemente, etc. También se puede exigir a estos trabajadores migrantes que reciban capacitación adicional (en esferas técnicas específicas que son

prioridades de salud pública o requisitos locales de los países de destino) o que adquieran experiencia laboral en un puesto subalterno o en una práctica limitada o supervisada en el país de destino antes de ser considerados elegibles para un puesto que corresponda a sus competencias y calificaciones.

La mayor parte de los países tienen requisitos específicos y transparentes para la entrada a las profesiones de la salud reguladas. Dado que los programas de capacitación difieren de un país a otro, generalmente se requieren disposiciones especiales para aplicarlos a los trabajadores que vienen del extranjero. A veces estas disposiciones pueden aplicarse de manera diferente según el país de origen del trabajador de salud. En algunos casos, hay una falta de claridad en cuanto a los requisitos para la entrada a esferas específicas, por ejemplo, para especialistas de posgrado o para los trabajadores provenientes de ciertos países o regiones.

Ciertos acuerdos ofrecen oportunidades de capacitación, capacitación en idiomas y apoyo para prepararse para el examen de calificación o licencia, cuando sea necesario, en los países de destino o en el país de origen antes de la salida.

La mayor parte de los acuerdos no incluyen ningún mecanismo de recopilación de datos que facilite el monitoreo, la aplicación y la evaluación de los efectos.

Seguimiento y evaluación

Los acuerdos firmados entre países son acuerdos marco que establecen normas que rigen la contratación, la educación, la migración y los arreglos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Los detalles de los planes de aplicación incluyen las esferas técnicas específicas y los términos y condiciones de los trabajadores de salud elegibles para la migración y la movilidad (por ejemplo, especialidad, experiencia, situación laboral, número de trabajadores de salud determinado por los equipos técnicos de ambos países) y, por lo general, no están disponibles al público. La mayor parte de los acuerdos no incluyen ningún mecanismo de recopilación de datos que facilite el seguimiento, la aplicación y la evaluación de los efectos. Pocos acuerdos mencionan explícitamente la recopilación de datos y el intercambio de información sobre la migración y la movilidad de los trabajadores de salud entre países, a pesar de ser una disposición explícita del Código. Solo en una pequeña

minoría de los acuerdos analizados se previó la creación de un órgano específico, a menudo llamado “comité”, para supervisar la ejecución de los acuerdos, hacer el seguimiento de los efectos, proponer modificaciones y adoptar otras medidas necesarias durante la aplicación. En los acuerdos que han establecido “comités bilaterales conjuntos”, “grupos de trabajo conjuntos” o “comités consultivos conjuntos”, las actividades, deliberaciones o decisiones de estos órganos no son públicas.

En general, la evaluación de los acuerdos parece inadecuada. Si bien las partes interesadas entrevistadas informaron que los términos de los acuerdos se aplicaron en gran medida de buena fe, no pudieron proporcionar información sobre sus resultados, la situación de los trabajadores de salud migrantes después de la expiración de los acuerdos o los efectos de los acuerdos en el sistema de salud de los países de origen. A falta de un mecanismo específico de seguimiento y evaluación, no se sabe con certeza cómo se pueden ajustar o ampliar los arreglos para lograr los efectos máximos.

Limitaciones

Los métodos de investigación y las conclusiones tienen varias limitaciones. En la revisión bibliográfica no se encontró ninguna evidencia cuantitativa sobre los resultados de la aplicación o la evaluación de los acuerdos bilaterales. Los acuerdos analizados fueron los que estaban a disposición de la OMS o los que estaban a disposición del público mediante el portal de la OMC. Los textos de estos acuerdos no incluían detalles sobre la aplicación ni informes sobre la finalización o la evaluación. Las partes interesadas entrevistadas se seleccionaron inicialmente sobre la base de los acuerdos examinados, y a esto le siguió un muestreo de bola de nieve dentro del marco temporal de la investigación. Por lo tanto, es posible que las conclusiones no hayan captado por completo la diversidad de acuerdos, los retos de negociación y aplicación y las prácticas y perspectivas prometedoras de todas las partes interesadas. Aunque el sector privado proporciona una parte importante de los servicios de salud en muchos países, las entrevistas con las partes interesadas no incluyeron a representantes del sector privado porque la mayoría de los acuerdos examinados estaban relacionados con el sector público. Por último, con el aumento del uso de la tecnología de la información y la prestación transfronteriza de servicios de salud, especialmente tras la pandemia de COVID-19, es posible que los acuerdos gubernamentales más recientes también se hayan centrado en los servicios de salud digitales internacionales, la telemedicina y la educación a distancia, que incluyen la utilización de conocimientos especializados o servicios de trabajadores de salud con desplazamiento físico mínimo o nulo a través de las fronteras; estos aspectos emergentes no se detectaron en los acuerdos examinados.

5. Consideraciones de política y buenas prácticas clave

El contenido de este capítulo se basa en la evidencia que, como se ilustra en la sección anterior, en gran medida es de carácter descriptivo y exploratorio. Por lo tanto, la evidencia y los resultados de la investigación se han complementado con los aportes del Grupo de Expertos Técnicos de la OMS sobre acuerdos bilaterales. La adopción de las buenas prácticas y las consideraciones de políticas que se describen en este documento, junto con las consideraciones de aplicación conexas, dependen de la adaptación contextual, los elementos de aceptabilidad y viabilidad, y la capacidad de aplicación de los países participantes.

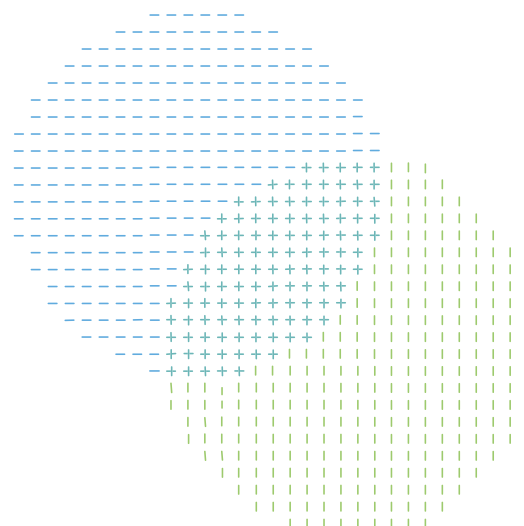
Renovando el llamamiento a la creación de alianzas, la colaboración técnica y el apoyo financiero, tal como se describe en el Código, y sobre la base de las necesidades específicas y las circunstancias especiales de los países, el enfoque de los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud podría incluir lo siguiente: subsanar las brechas en la fuerza laboral y asegurar los derechos de los trabajadores de salud migrantes; la cooperación en materia de salud; la movilidad del personal de salud en relación con el comercio de servicios; la educación y capacitación del personal de salud; la migración y la movilidad del personal de salud para la asistencia técnica y el apoyo filantrópico; y la armonización de los requisitos o el reconocimiento de las calificaciones.

Independientemente del tema o los temas específicos o del objetivo principal del acuerdo, los acuerdos gubernamentales relacionados con los sistemas de salud y la fuerza laboral (incluidos los profesionales, profesionales asociados, auxiliares y trabajadores asistenciales en el sector de la salud) deben estar en consonancia con los objetivos y principios del Código para que se consideren justos y éticos. Los principios y derechos consagrados en los convenios, recomendaciones y protocolos pertinentes de la OIT, como también los establecidos en las declaraciones de la OIT (en particular la *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*, enmendada en el 2022), las resoluciones de la OIT y otras orientaciones, como los *Principios generales y directrices prácticas relativos a la contratación equitativa y Definición de las comisiones de contratación y los*

gastos conexos de la OIT (49) y el *Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales*, son igualmente pertinentes.

Las declaraciones mundiales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y los compromisos asumidos en virtud de los convenios de reconocimiento de la UNESCO y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, son complementarias y pueden reforzar la aplicación del Código.

A continuación se presentan las consideraciones clave en materia de políticas y buenas prácticas para fundamentar la conceptualización y el contenido de los acuerdos gubernamentales de migración de los trabajadores de salud. Si bien las consideraciones de política y las declaraciones de buenas prácticas se relacionan con cualquier tipo de acuerdo de migración y movilidad de estos trabajadores, no todas las consideraciones serán aplicables en todos los casos. Por ejemplo, cuando se produce un desplazamiento de un país con un sistema de salud y una economía comparativamente más fuertes a otro más débil o en virtud de un acuerdo de apoyo filantrópico o técnico, no sería necesario prever la inversión en los países de origen por parte de los países de destino.





Sostenibilidad de la fuerza laboral

Los acuerdos bilaterales deben asegurarse de que la contratación o la migración y la movilidad internacionales del personal de salud contribuyan a la sostenibilidad de la fuerza laboral, la seguridad de la salud y el progreso hacia la cobertura universal de salud tanto en el país de origen como en el de destino, sin agravar los retos de la fuerza laboral.

El compromiso de respetar y promover el derecho al goce del grado más alto de salud de todas las personas, tanto en los países de origen como en los de destino, debe servir de base para la elaboración de acuerdos que contribuyan a la sostenibilidad del personal de salud (62). Cuando un país de destino promueve el derecho a la salud de su población mediante la contratación de trabajadores de salud migrantes, debe garantizarse el mismo derecho a las personas de los países de origen a avanzar hacia la cobertura universal de salud (24), la seguridad de la salud y otros objetivos de desarrollo sostenible conexos.

Los acuerdos deben basarse en el análisis de las necesidades del sector de la salud y del mercado laboral tanto en los países de origen como en los de destino. El examen de los efectos a corto y largo plazo de la migración y la movilidad internacional en los países de origen y de destino incluye tener en cuenta las posibles consecuencias en la disponibilidad, distribución y calidad de las diferentes categorías del personal de salud; el mercado laboral de la salud; la prestación de servicios de salud; la armonización de la educación y la capacitación sobre salud con las necesidades de salud de la población; el costo de los servicios de salud; y, en última instancia, los resultados de salud de la población.

Reconociendo que la migración y la movilidad internacional de los trabajadores de salud pueden tener lugar por múltiples vías en gran volumen, las consecuencias negativas existentes o previstas de los patrones de migración y movilidad podrían contrarrestarse mediante la cooperación internacional. Los países de origen podrían considerar inversiones apropiadas en educación, regulación, incentivos y apoyo para los trabajadores de salud (63), y una regulación adecuada de las diferentes vías de migración y movilidad internacional. Los países de destino podrían prestar apoyo mediante los canales internacionales de desarrollo existentes, aumentando o adaptando la ayuda existente, sin perjuicio en cuanto a las necesidades generales de desarrollo del país de origen, así como priorizar la contratación mediante las disposiciones del acuerdo bilateral.



Beneficio para los sistemas de salud

El acuerdo debe especificar los beneficios que tiene la alianza para los sistemas de salud de los países participantes en consonancia con los respectivos objetivos nacionales relacionados con la salud.

Cuando un número considerable de trabajadores de salud migrantes ingresan a un país por diversas vías, podría parecer que los países de destino tienen pocas razones para comprometerse en un acuerdo gubernamental, aparte de asegurar un suministro más estable de trabajadores de salud. Sin embargo, el fortalecimiento de los sistemas de salud en los países de origen redundaría en beneficio directo de los países de destino para su economía, la sostenibilidad de su sistema de salud y su seguridad de la salud.

Reconociendo los factores estructurales que colocan a ciertos países en desventaja en la negociación de acuerdos mutuamente beneficiosos, la contribución del acuerdo de migración y movilidad al fortalecimiento de los sistemas de salud en los países de origen debe ser explícita en el acuerdo. Algunos ejemplos específicos de los beneficios para el sistema de salud del país de origen pueden incluir lo siguiente:

- Inversión de recursos financieros en el país de origen. Estos recursos pueden provenir, según sea aplicable de conformidad con la legislación del país y los compromisos internacionales, de diversas fuentes del país de destino, por ejemplo, la asistencia internacional oficial para el desarrollo, la salud, la educación u otros presupuestos; las comisiones de contratación cobradas a los países de destino o a los empleadores; e impuestos limitados sobre los ingresos de los trabajadores de salud migrantes obtenidos en el país de destino.



Beneficio para los sistemas de salud

El acuerdo debe especificar los beneficios que tiene la alianza para los sistemas de salud de los países participantes en consonancia con los respectivos objetivos nacionales relacionados con la salud.

- Desarrollo de la capacidad institucional que podría incluir, entre otras cosas, la educación y las oportunidades de empleo para los trabajadores de salud en los países de origen, según corresponda a las necesidades detectadas a nivel nacional.
- Asistencia técnica o financiera adicional a otras esferas del sistema de salud, como la infraestructura y la tecnología de prestación de servicios, el liderazgo y la información, los medicamentos y los productos de salud, el financiamiento de la salud, según las necesidades contextuales.
- Es fundamental que, independientemente de la modalidad de asistencia y el canal elegido, los beneficios que se obtengan para el sistema de salud del país de origen sean:
 - proporcionados y acordes con la contribución de los trabajadores de salud en el país de destino;
 - determinados por las autoridades nacionales del país de origen en consonancia con las prioridades normativas y estratégicas definidas a nivel nacional;
 - asociados a compromisos vinculantes de financiamiento o apoyo a dichas actividades.



Salvaguardias para los países vulnerables

Deben proporcionarse salvaguardias adicionales contra la contratación activa y apoyo relacionado con los sistemas de salud a los países que afrontan vulnerabilidades en la fuerza laboral.

Para que la contratación internacional se considere justa y ética, debe vincularse al fortalecimiento equitativo de los sistemas de salud en los países de origen y destino, teniendo en cuenta también las necesidades adicionales de los países que afrontan vulnerabilidades de la fuerza laboral o una capacidad insuficiente para aplicar el Código. Las remesas no cumplen los requisitos de apoyo para el fortalecimiento de los sistemas de salud, ya que se trata de ingresos individuales de los trabajadores de salud migrantes que pueden optar por enviar a sus familias en el país de origen y, por lo tanto, no pueden utilizarse como un indicador de “beneficio mutuo”.

Los países que afrontan los retos más acuciantes respecto del personal de salud están incluidos en la Lista de la OMS para el apoyo y la salvaguardia del personal de salud (11), que se actualiza periódicamente. Es necesario dar prioridad a estos países en el fortalecimiento de sus sistemas de salud y en el apoyo al desarrollo de su personal de salud.

Los países con vulnerabilidades en la fuerza laboral requieren salvaguardias adicionales contra la contratación internacional activa de trabajadores de salud. El Código recomienda a los países de destino y a los organismos de contratación que se abstengan de contratar activamente en esos países, excepto en el marco de acuerdos entre gobiernos. Esos acuerdos, cuando se negocian con la participación de las partes interesadas del ámbito de la salud y aseguran que el suministro interno de trabajadores de salud que se está negociando sea suficiente, deben proporcionar la inversión necesaria en los países de origen para mejorar sus resultados de salud. Cuando la demanda económica y la capacidad de absorción de los trabajadores de salud son insuficientes para atender de manera adecuada las necesidades de salud de la población, también se debe considerar la posibilidad de adoptar medidas encaminadas a aumentar el espacio fiscal para contratar tipos específicos de trabajadores de salud.

Estas prácticas también podrían extenderse, de acuerdo con un principio de precaución, a los países no incluidos en la Lista de la OMS para el apoyo y la salvaguardia del personal de salud.



Derechos y bienestar de los trabajadores de salud

El personal de salud migrante debe gozar de los mismos derechos, beneficios y oportunidades que los trabajadores de salud de los países de destino.

Los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud deben fundamentarse en un enfoque basado en los derechos y que responda a las cuestiones de género, protegiendo a los trabajadores de salud migrantes y ayudándoles a contribuir al desarrollo socioeconómico de ambos países y beneficiarse de este de manera justa y equitativa. Esto incluye informar al personal de salud de sus derechos y obligaciones y defender esos derechos, incluido el de salir de cualquier país de conformidad con las leyes aplicables, y gestionar la contratación internacional con transparencia, equidad y promoción de la sostenibilidad de los sistemas de salud en los países en desarrollo.

Todos los trabajadores de salud deben tener la oportunidad de evaluar los beneficios y los riesgos asociados a la migración y la movilidad a fin de tomar decisiones informadas sobre sus opciones. Por lo tanto, la comunicación transparente relativa al acuerdo de migración y movilidad (como el proceso de inmigración, los requisitos reglamentarios y de licencia, el reconocimiento de calificaciones, los detalles del contrato, el idioma y la cultura, el ámbito del trabajo, las condiciones de trabajo y la remuneración, los gastos de sustento estimados y los impuestos, y la información sobre los derechos y prestaciones laborales y de protección social, incluida la atención de salud y la transferibilidad de las prestaciones de seguridad social, la solución de controversias, las opciones para la educación, la ampliación de la carrera o los servicios, la migración y la movilidad, la condición de residencia y la vía de retorno) representa un componente esencial de la migración y la movilidad ordenadas.

Una vez en el país de destino, los trabajadores de salud migrantes deben gozar del mismo trato que los trabajadores de salud nacionales respecto de los derechos pertinentes laborales o más amplios, los derechos y oportunidades profesionales (incluida la promoción de un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida), las prestaciones sociales (incluido el acceso a los servicios de salud) y la protección social, la seguridad y la salud en el trabajo (incluso en caso de una emergencia), en consonancia con las normas pertinentes de la OIT (2, 3, 47, 64, 65), como también con los diez convenios sobre la protección de los derechos fundamentales en el trabajo y los relativos a la violencia y el acoso, los salarios y las condiciones de trabajo. Los miembros de la OMC también tienen la obligación jurídica de dar un trato no discriminatorio a los trabajadores de salud extranjeros si han incluido los servicios de salud y relacionados con la salud en sus compromisos comerciales sin especificar las limitaciones pertinentes a dicho trato.

Siempre que sea posible, los trabajadores de salud deben tener acceso a servicios específicos que les ayuden a integrarse y tener éxito personal y profesional en el país de destino. La participación de los interlocutores sociales en todas las etapas de los acuerdos bilaterales puede ayudar a facilitar la inclusión de estos componentes en los derechos de los trabajadores de salud y en el componente de bienestar.



Consideraciones de género

Los acuerdos gubernamentales deben incorporar un enfoque que responda a las cuestiones de género para atender las necesidades específicas en materia de género y mitigar las vulnerabilidades de los trabajadores de salud migrantes.

Los mecanismos de migración y movilidad y la provisión de derechos y beneficios para el bienestar de los trabajadores de la salud pueden afectar a los géneros de diferentes maneras. Dado que las mujeres pueden ser particularmente vulnerables en las diferentes etapas del proceso de migración y movilidad, y puesto que el sector de la salud es una esfera fuertemente basada en el género, los acuerdos gubernamentales deben incluir disposiciones pertinentes para salvaguardarlas y promover su empoderamiento.

Los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud deben considerar, abordar y hacer el seguimiento (mediante parámetros desglosados por género) de los posibles efectos negativos del arreglo sobre migración y movilidad en los diferentes géneros, en particular en relación con lo siguiente: cobertura del seguro de salud de las enfermedades y afecciones específicas de cada género; disposiciones relativas a la licencia de maternidad a fin de preservar la igualdad de oportunidades para las mujeres en materia de educación, capacitación, promoción o adelanto profesional; remuneración igual entre los géneros por trabajo de igual valor; salvaguardias contra las posibilidades de explotación sexual, acoso, violencia y abuso; acceso a la justicia, en particular al sistema jurídico de forma gratuita; y pleno reconocimiento de derechos más amplios.



Seguimiento y evaluación

Todos los acuerdos gubernamentales deben incluir un mecanismo de seguimiento y evaluación con un circuito de comentarios operativo.

El seguimiento y la evaluación permiten determinar el éxito y las deficiencias de los acuerdos y su valor agregado para el sistema de salud de los países de origen y destino, así como sus efectos en el bienestar de los trabajadores de salud. Los indicadores para medir el éxito, en función del objetivo y el contenido del acuerdo, ayudarán a los países a determinar si las operaciones se realizan según lo previsto, a adoptar medidas adecuadas para afrontar los problemas emergentes, a hacer el seguimiento del sistema de salud en los países de origen y a evaluar la efectividad y los efectos del acuerdo, incluidos los efectos desglosados por género.

Los acuerdos deben tener en cuenta un mecanismo de examen que podría adoptar la forma, por ejemplo, de un comité conjunto integrado por representantes de los organismos públicos competentes, interlocutores sociales (organizaciones de empleadores y de trabajadores) y las partes interesadas clave, con reuniones periódicas programadas y recursos específicos para informar sobre los progresos en la aplicación y facilitar el debate entre las diferentes partes. Es importante destacar que los acuerdos deben incluir una cláusula de revisión que permita realizar adaptaciones de los indicadores o disposiciones en el acuerdo sobre la base de los datos de seguimiento, las necesidades cambiantes o toda evolución en la situación política de cualquiera de los dos países. En circunstancias excepcionales, también podrían considerarse disposiciones relativas a una suspensión temporal del acuerdo.

Los resultados de las actividades de seguimiento y evaluación serán esenciales para determinar los puntos fuertes, limitaciones y oportunidades de los diferentes acuerdos, que luego se pueden utilizar para mejorar futuros acuerdos y para fundamentar las estrategias de personal de salud en ambos países. También proporcionarán evidencia para que los países comparen los pros y los contras entre los beneficios fiscales y económicos a corto y mediano plazo y la creación de una oferta más sostenible de personal de salud para abordar la seguridad y la equidad en materia de salud. La disponibilidad pública de estos informes ayudará a otros países a fortalecer sus estrategias de la fuerza laboral y sus acuerdos bilaterales.



Transparencia e intercambio de información

La información sobre los acuerdos y los datos de la aplicación correspondientes deben compartirse a nivel nacional e internacional, incluido mediante notificación a la Secretaría de la OMS.

La transparencia en el intercambio de datos e información es un elemento clave de una gobernanza de salud mundial eficaz, que también se aplica a la migración y la movilidad internacionales del personal de salud. Los Estados Miembros de la OMS están obligados a informar sobre la aplicación del Código cada tres años, y la participación de los Estados Miembros ha ido en aumento en las rondas posteriores de presentación de informes. Cada vez se notifican más acuerdos, y el texto completo de los acuerdos se comparte con la OMS. Esta presentación de informes puede ampliarse para incluir información y datos sobre la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud.

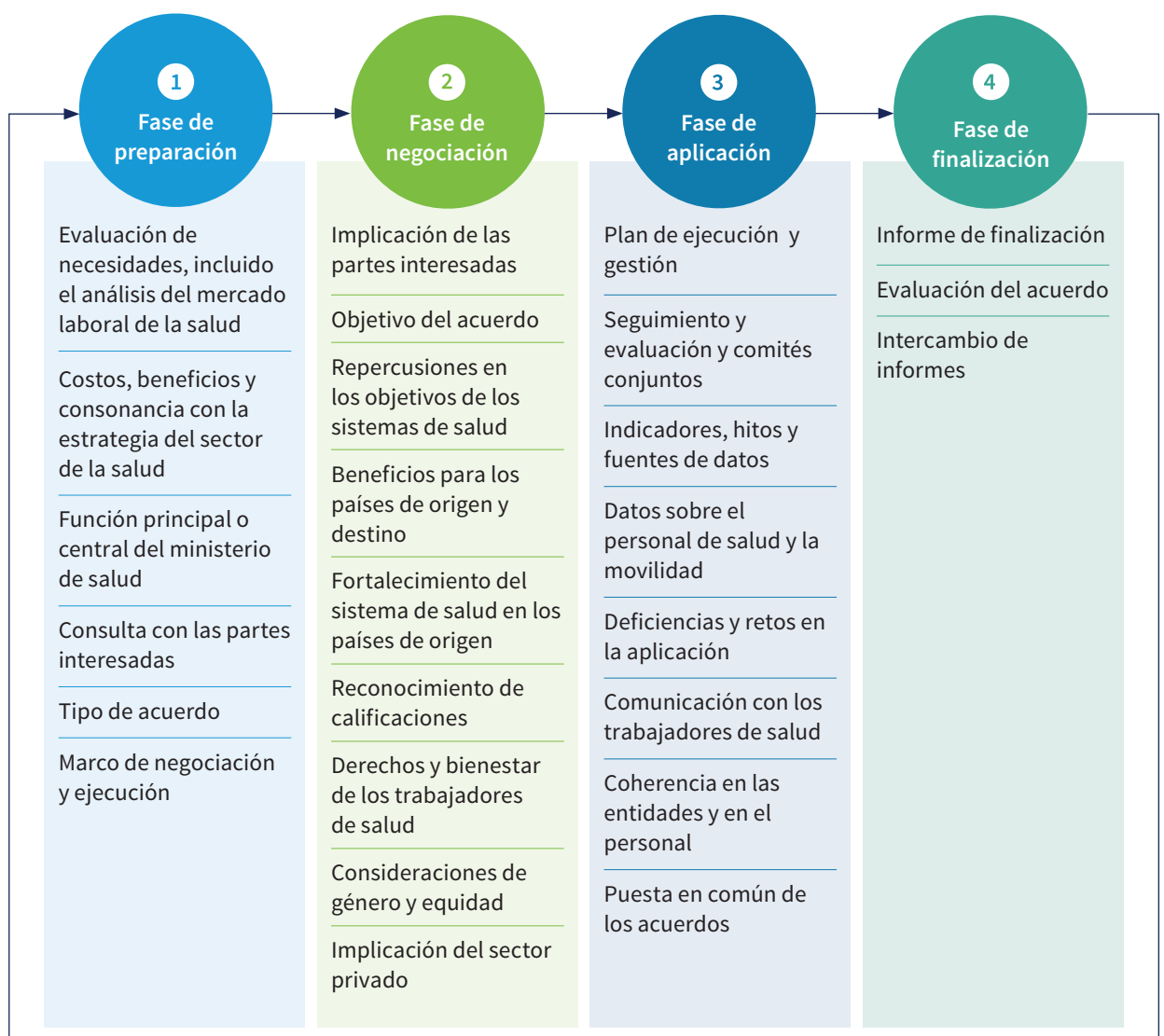
Un repositorio centralizado de evidencia recopilada mediante el proceso de presentación de informes, que incluya información sobre la existencia y la aplicación de los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud, ayudaría a informar a la comunidad mundial sobre la evaluación de los éxitos, los retos y las enseñanzas extraídas de su aplicación en diferentes contextos. Esto contribuiría a un creciente acervo de conocimientos que pueden fundamentar las decisiones de política en los países de origen y destino, como también a mejorar la conceptualización y el diseño de futuros acuerdos que puedan maximizar los beneficios en los sistemas de salud para los países participantes, salvaguardar los derechos de los trabajadores de salud, y servir de base para las políticas y la planificación del personal de salud tanto en los países de origen como en los de destino.

6. Consideraciones relativas a la aplicación

En este capítulo se resumen las consideraciones clave pertinentes para las fases típicas de preparación, negociación, aplicación y finalización del acuerdo. Si bien se presentan en aras de la simplicidad de acuerdo con un orden cronológico estándar (figura 4), diferentes elementos pueden superponerse e intersectarse en diferentes puntos en el tiempo, por ejemplo, cuando

nueva evidencia, o los resultados del seguimiento del acuerdo en sí, pueden informar sobre la necesidad de elaborar y negociar elementos adicionales o diferentes del acuerdo. Todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, deben poder participar en todos estos casos mediante estructuras de diálogo social eficaces.

Figura 4. Acuerdos bilaterales: consideraciones sobre la aplicación





Fase de preparación

Evaluación de las necesidades

Los ministerios de salud, tanto en los países de origen como en los de destino, deben llevar a cabo una evaluación de las necesidades del sistema de salud y del personal de salud que incluya un análisis del mercado laboral de salud (66) y previsiones, en consulta con otros sectores y partes interesadas clave, para determinar las necesidades del sistema de salud, la oferta, la demanda y las tendencias del mercado laboral, así como las intervenciones prioritarias en materia de políticas sobre el personal de salud en cada país. El análisis del mercado laboral de la salud es particularmente necesario a fin de que:

- el país de destino comprenda los factores que impulsan depender de los trabajadores de salud capacitados en el extranjero y determine opciones de política para adoptar medidas correctivas;
- el país de origen determine si hay un exceso o una escasez de oferta en comparación con la demanda económica y la capacidad de absorción de los trabajadores de salud, y calcule los efectos de la migración y la movilidad internacionales; y
- ambos países determinen el nivel de migración y movilidad internacionales (entrada y salida).

Los análisis deben desglosarse por ocupaciones, especialidad o experiencia, y distribución subnacional, ya que el exceso de oferta de algunos trabajadores de salud y en algunas regiones suele coexistir con la escasez de otros. En el caso de los acuerdos comerciales, esto también podría ayudar a definir las necesidades del mercado laboral y aportar más transparencia y previsibilidad a los prestadores de servicios en los países de origen.

Consonancia con la estrategia del sector de la salud y otras estrategias sectoriales

Los mecanismos para mitigar las brechas y los retos detectados en los sistemas de salud y el personal de salud deben estar en consonancia con las respectivas estrategias, prioridades y objetivos sectoriales a largo plazo, tanto en la salud como en la educación, el trabajo, la migración y otros sectores pertinentes. La excesiva dependencia de los trabajadores de salud migrantes debe superarse progresivamente con medidas encaminadas a aumentar la producción nacional y la retención de la fuerza laboral en los países de destino mediante decisiones adecuadas sobre políticas de educación e inversión. Paralelamente, la salida de los trabajadores de salud del mercado laboral de los países de origen debe compensarse con la creación de oportunidades adecuadas de educación, empleo y desarrollo profesional, lo que requiere coordinación y sinergia entre las políticas de salud, educación y trabajo. Es importante tener en cuenta los costos y beneficios de los diferentes enfoques para atender las necesidades del personal de salud o del sistema de salud, incluidas las

diversas vías de migración y movilidad, antes de decidir sobre los acuerdos bilaterales entre los posibles países y la probabilidad de que los trabajadores de salud elijan esta vía en lugar de otras.

Entidad rectora

El apoyo político de alto nivel ayudará a facilitar la elaboración, la adopción y la aplicación del acuerdo. Además, la selección de una sola entidad gubernamental para coordinar la elaboración de los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud en cada país puede ser fundamental para asegurar la coherencia y la eficiencia. Si bien el organismo rector puede variar según el país y el tipo de acuerdo (por ejemplo, relaciones exteriores, salud, trabajo, comercio e industria, etc.), el ministerio de salud debe formar parte del equipo principal (de no ser la entidad rectora) o, como mínimo, ser consultado sobre todo acuerdo que esté relacionado con la migración y la movilidad de los trabajadores de salud, que tenga un componente del sector de la salud o un alcance más amplio que podría tener posibles efectos en el sector de la salud. Se podría designar a un coordinador del ministerio de salud o a una subdependencia del ministerio encargada de los recursos humanos para la salud o los sistemas de salud a fin de que participe en todo asunto relacionado con la educación, el empleo, el comercio de servicios de salud o la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud con interlocutores de diferentes entidades gubernamentales (por ejemplo, educación, relaciones exteriores, trabajo, industria, etc.) mediante un proceso de consulta interinstitucional para el debate continuo, intercambio de información y aportes. A fin de asegurar que los aportes de los ministerios de salud (en particular de los países de origen) tengan suficiente peso para ser considerados, estos también podrían incluirse como cosignatarios en acuerdos que incluyan la implicación del sector de la salud y seguir participando en la aplicación, los comentarios y la evaluación.

Consulta con las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales

Es necesario celebrar consultas con las partes interesadas prioritarias de los países para tener en cuenta los aportes de diferentes perspectivas a fin de adoptar un enfoque que abarque todo el gobierno y todo el país en relación con los posibles acuerdos antes de la negociación. Estos incluyen entidades gubernamentales competentes de los sectores de educación, relaciones exteriores, salud, inmigración, trabajo y comercio, así como grupos de la diáspora, instituciones educativas, empleadores, asociaciones de derechos de los migrantes, asociaciones profesionales, sindicatos, actores del sector privado, organismos reguladores, etc. La colaboración entre los diferentes sectores asegurará la armonización de las políticas entre los sectores; la comprensión mutua de las

prioridades; la contribución de recursos; la detección de limitaciones; y esferas de sinergia. Los ministerios de salud deben compartir la justificación y las estrategias prioritarias para impulsar la agenda de salud en los acuerdos y destacar su importancia en el progreso hacia objetivos socioeconómicos más amplios.

Tipo de acuerdo

La elección de los temas centrales y el alcance del acuerdo dependerán de las prioridades y el contexto de los países negociadores. Cada categoría de acuerdo tiene sus ventajas, limitaciones y desventajas, y la elección correcta dependerá de los objetivos de los países participantes. Los términos del acuerdo deben adaptarse para satisfacer los requisitos específicos de ambos países y estar en consonancia con las respectivas políticas nacionales de salud y (según el tipo y el contenido del acuerdo) con otras políticas pertinentes en materia de educación, inmigración, relaciones internacionales, trabajo, regulación profesional y comercio, y ser coherentes con los principios y recomendaciones de los instrumentos internacionales pertinentes. Los acuerdos comerciales deben aprovecharse para promover los objetivos de los sistemas de salud y el bienestar de los trabajadores de salud en la mayor medida posible.

Los términos del acuerdo deben adaptarse a los requisitos específicos de ambos países y estar en consonancia con las respectivas políticas nacionales de salud.

Marco de negociación y ejecución

Un marco de procedimientos y metodología para gestionar la negociación y la ejecución de los acuerdos en cada país puede contribuir a la coherencia y a la eficiencia del proceso, a diferencia de los arreglos *ad hoc*. Sobre la base de los contextos de los países, en este marco se podría aclarar explícitamente la distribución de funciones, especificarse el organismo rector para el tipo específico de acuerdo, los pasos a seguir en las diferentes etapas del acuerdo, incluido un proceso de consulta interinstitucional, el papel de las diferentes entidades gubernamentales en los diversos aspectos de la aplicación y la forma de resolver cualquier diferencia. También se podría reconocer y establecer disposiciones para un acuerdo de aplicación más detallado, así como los recursos financieros y humanos necesarios o el tiempo dedicado por el personal de las entidades responsables.



Fase de negociación

Implicación de las partes interesadas

Dependiendo del tipo de estructura de gobernanza, los gobiernos nacionales o federales podrían liderar las negociaciones sobre el acuerdo, si así lo permiten las leyes y los marcos normativos nacionales. Las entidades gubernamentales a nivel subnacional (por ejemplo, gobiernos provinciales o estatales en países con estructura federal) también pueden negociar acuerdos cuyo alcance se relacione con su jurisdicción específica. Reviste suma importancia la implicación de las partes interesadas clave (además de los empleadores, los representantes y expertos del sector de la salud, las entidades gubernamentales de todos los ministerios competentes, los organismos reguladores, las asociaciones de migrantes y los grupos de la diáspora, las asociaciones profesionales, los agentes del sector privado, los sindicatos y otros, según proceda). Además, también se justifica la previsión y la gestión de las preocupaciones de los grupos o partes interesadas que pueden verse afectados por el acuerdo. Por ejemplo, los trabajadores de salud del país de destino pueden tener reservas respecto de la competencia o la calidad de los trabajadores de salud migrantes, o del hecho de depender de los trabajadores de salud migrantes en lugar de promover la fuerza laboral del país.

Objetivo del acuerdo

El texto de todo acuerdo con un componente de migración y movilidad de los trabajadores de salud debe determinar claramente el objetivo y la contribución y los beneficios previstos para el sistema de salud (y el personal de salud) de cada país. Un compromiso explícito en el acuerdo de defender el Código puede ayudar a asegurar que los acuerdos contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de salud, al bienestar del personal de salud, aseguren la transparencia y se refuercen mutuamente con otros instrumentos internacionales pertinentes. En el caso de la entrada de un número significativo de trabajadores de salud migrantes a través de diversas vías, los países de destino podrían concertar acuerdos bilaterales teniendo en cuenta el desplazamiento general de los trabajadores de salud de un país cuando consideren el grado de apoyo financiero o de otro tipo que se proporciona a ese país de origen.

Repercusiones en los objetivos de los sistemas de salud

Es importante considerar las repercusiones del arreglo sobre migración y movilidad en los objetivos más amplios del sector de la salud de cada país, incluidos los efectos en la disponibilidad y la sostenibilidad de la fuerza laboral y en la prestación equitativa de servicios de salud. Independientemente de la categoría del acuerdo, los países pueden especificar la cantidad y los criterios de elegibilidad sobre la base de su oferta y demanda internas respecto de diferentes categorías de trabajadores de salud, en el contexto

del seguimiento, la planificación y las previsiones de la disponibilidad de la fuerza laboral en relación con las necesidades de los sistemas de salud. En los casos de arreglos sobre migración y movilidad a mediano o largo plazo, las cláusulas del acuerdo que limitan la contratación internacional a los recién graduados del país de origen o a las competencias y ocupaciones que no tienen una gran demanda pueden evitar la pérdida de trabajadores de salud esenciales o con experiencia. A su vez, un enfoque basado en contratar solo a los recién graduados requeriría que los países de destino invirtieran posteriormente en capacitación y experiencia laboral adicionales para asegurar que los trabajadores de salud migrantes adquieran las competencias necesarias después de su llegada a su país de destino. Al mismo tiempo, ninguna medida regulatoria sobre el desplazamiento internacional (como niveles máximos o límites para incluir solo la migración de ciertos grupos) debe incentivar a los trabajadores de salud a optar por canales no regulados de migración y movilidad. Cuando los gobiernos deciden promover la oferta de estos trabajadores para el mercado internacional, la inversión en el desarrollo de la capacidad del sistema regulatorio debe realizarse en paralelo para mantener la calidad.

Ninguna medida regulatoria sobre el desplazamiento internacional debe incentivar a los trabajadores de salud a optar por canales no regulados de migración y movilidad.

Beneficios mutuos

La migración y la movilidad de los trabajadores de salud deben beneficiar a los sistemas de salud de ambas partes. Los países de origen deben recibir beneficios tangibles y realistas para sus sistemas de salud que guarden proporción con los beneficios para el país de destino. Lo que puede constituir beneficios proporcionados depende de los contextos de cada país, pero en los acuerdos sobre migración y movilidad a mediano y largo plazo podrían incluir apoyo técnico y financiero en esferas prioritarias de salud pública; compensación de la inversión pública en la educación previa al servicio de los trabajadores de salud; o ayuda general al presupuesto para los sistemas de salud; esto podría tener un valor equivalente a los costos ahorrados por los países de destino en educación y capacitación

de los trabajadores de salud o a las pérdidas registradas por los países de origen debido a la salida de trabajadores de salud calificados. Especificar las esferas de asistencia o inversión sobre la base de esferas prioritarias determinadas a nivel nacional debería ser un elemento central del proceso de negociación del acuerdo. En muchos países, el desplazamiento de los trabajadores de salud por vías alternativas supera sustancialmente en número a los que se desplazan dentro del marco de acuerdos gubernamentales. En tales casos, también se pueden elaborar acuerdos no solo a fin de proporcionar un marco formal a la situación de hecho, sino también con miras a introducir beneficios específicos para los sistemas de salud de los países de origen.

Inversiones en el fortalecimiento de los sistemas de salud

Las intervenciones específicas para el fortalecimiento de los sistemas de salud en los países de origen incluyen el apoyo a la aplicación de componentes de la estrategia del sector de la salud o de la estrategia del personal de salud. Por ejemplo: ampliar los programas de educación y capacitación y las oportunidades de empleo; apoyar planes y políticas para mitigar las desigualdades en la distribución de la fuerza laboral; asegurar la calidad de la educación y la práctica de los servicios de salud; elaborar o ampliar la infraestructura de salud, los sistemas de información, la tecnología, los medicamentos y los productos de salud; y apoyar el financiamiento, el liderazgo y la buena gobernanza en materia de salud para mejorar la prestación de servicios de salud y la calidad de la atención. Los países de destino deben asignar recursos para asegurar que los arreglos del acuerdo se apliquen y produzcan resultados positivos para la salud en ambos países, lo que también debe formar parte de la evaluación de los acuerdos.

Reconocimiento de calificaciones

Los mecanismos de reconocimiento de calificaciones deben ser transparentes, justos, objetivos, imparciales, no discriminatorios y no más complicados de lo necesario. La evaluación de las calificaciones detecta similitudes y diferencias en los programas de capacitación y aprendizaje o los requisitos de competencias entre países para el tipo respectivo de trabajador de salud; las diferencias deben resolverse con mecanismos compensatorios apropiados para los requisitos de calificaciones en una jurisdicción a fin de evitar la infrautilización de los trabajadores de salud, la pérdida de competencias y las diferencias en la remuneración. La entidad responsable de este proceso podrá formar parte del organismo regulador o de una agencia independiente creada a tales efectos. Sin embargo, el reconocimiento de calificaciones puede no ser suficiente por sí solo para entrar en la práctica de las profesiones de la salud reguladas.

Requisitos regulatorios

Los organismos reguladores determinan los criterios para la entrada a las ocupaciones de salud reguladas y los ámbitos de práctica de una profesión sobre la base de la competencia y la probidad de los trabajadores de salud para prestar los servicios que son pertinentes respecto de la seguridad del paciente, las necesidades de la población y los objetivos de salud de la jurisdicción. Es importante tener en cuenta que las diferencias en la regulación ocupacional entre las jurisdicciones y las ocupaciones podrían impedir la entrada a una ocupación de salud o limitar el alcance de la práctica a menos que se cumplan los requisitos. Cuando los países celebren acuerdos de reconocimiento de calificaciones o consideren la posibilidad de actualizar las normas y los procesos regulatorios para cumplir las normas o requisitos internacionales, cuando existan, estos también deben seguir siendo pertinentes para atender las necesidades nacionales.

Derechos y bienestar de los trabajadores de salud

Para que los acuerdos gubernamentales sean ampliables, deben ser más interesantes para los trabajadores de salud en comparación con las vías alternativas para la migración y la movilidad. La consideración de los derechos y el bienestar de estos trabajadores, en consonancia con las normas internacionales del trabajo, debe incluir, entre otras cosas, disposiciones que permitan lo siguiente: el acceso gratuito a oportunidades de capacitación y educación en virtud de un acuerdo gubernamental; la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores de salud nacionales y migrantes, incluso durante las emergencias; la libertad de asociación y de negociación colectiva, equivalente a la de los trabajadores de salud nacionales; la posibilidad de que los trabajadores de salud eviten asumir el costo de la contratación y la colocación; el apoyo a la integración profesional y social en los países de destino; la concesión de visas a los dependientes y visitas para la reunificación familiar; claridad y apoyo relativos a la navegación por el sistema de inmigración y el proceso regulatorio; el acceso a los sistemas de solución de controversias; la cobertura de seguros; mecanismos para notificar cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo, como la explotación o el abuso, y solicitar asistencia jurídica al respecto; prestaciones de protección social pertinentes, como el acceso a los servicios de salud; asegurar la transferibilidad de las prestaciones de seguridad social mediante la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales de seguridad social; protección para evitar que los trabajadores queden en un estado de irregularidad en caso de pérdida de empleo y flexibilidad respecto de cambios de empleo; vías para un retorno en condiciones de seguridad y dignidad y procedimientos para facilitar la reintegración

sostenible de los trabajadores de salud en los países de origen, cuando proceda, incluso durante situaciones de emergencia.¹² Si bien los trabajadores migrantes pueden recibir capacitación y orientación sobre el idioma, la cultura y el estilo de vida de los países de destino antes de su partida, también puede ser beneficioso informar a sus posibles empleadores y colegas sobre los antecedentes de educación o capacitación de los trabajadores de salud migrantes y su cultura para facilitar su integración en el lugar de trabajo.

Las disposiciones destinadas a proteger a las mujeres deben promover su empoderamiento, en lugar de restringir la migración, la movilidad y la integración.

Consideraciones de género y equidad

Las consideraciones específicas de género deben integrarse en una perspectiva más amplia de equidad que aborde otros elementos de vulnerabilidad, que pueden ser pertinentes para el alcance del acuerdo y las características geográficas, demográficas y socioculturales y las diferencias entre los países de origen y destino. Esto puede incluir atención específica a los trabajadores de salud de grupos que pueden estar en riesgo de discriminación y trato injusto por su origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual, entre otros. Como parte de este enfoque más amplio orientado a la equidad, es necesario aplicar una perspectiva específica de género en los acuerdos para prever y gestionar adecuadamente los posibles efectos en materia de género. Las disposiciones destinadas a proteger a las mujeres durante el proceso de migración y movilidad deben promover su empoderamiento y brindar apoyo, en lugar de restringir la migración, la movilidad y la integración.

Sector privado

Con sujeción a las especificidades de cada país, el desplazamiento de trabajadores de salud también puede realizarse mediante agencias de contratación privadas y consultorías de educación o inmigración, independientemente de que los trabajadores de salud sean empleados posteriormente en el sector público o privado. En muchos casos, el desplazamiento mediante estos canales puede ser la fuente principal de migración

12 En las *Orientaciones sobre acuerdos bilaterales de migración laboral* de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración (33) se proporciona información más específica para ayudar a los países a elaborar acuerdos basados en los derechos que respondan a las cuestiones de género y se basen en un enfoque cooperativo y de múltiples partes interesadas.

y movilidad, con un volumen mucho mayor en comparación con la vía de acuerdos bilaterales (si esta existe). Los gobiernos deben esforzarse por asegurar que las agencias de contratación apliquen las mismas disposiciones que las existentes en virtud del acuerdo gubernamental de migración y movilidad de los trabajadores de salud, incluida la implicación de los ministerios de salud, la inclusión de beneficios proporcionados para los países de origen, el respeto a los derechos y el bienestar de los trabajadores de salud migrantes, incluido no cobrar comisiones de contratación a los trabajadores de salud (49). Para que esto sea efectivo, es esencial que un organismo público regule y supervise adecuadamente las agencias de contratación, los consultores de educación e inmigración y los empleadores del sector privado que operan dentro de una jurisdicción para transferirles los elementos pertinentes de los acuerdos gubernamentales firmados por las respectivas autoridades gubernamentales.



Fase de aplicación

Plan de ejecución y gestión

Es posible que el acuerdo en sí no siempre incluya un plan de aplicación detallado. En tales casos, los equipos técnicos pueden elaborar un plan después de la firma del acuerdo en el que se especifiquen los detalles de este, las actividades, las funciones de las diferentes entidades públicas y otras partes interesadas, los plazos previstos, los procesos, las modalidades de aplicación, los recursos necesarios, las fuentes de financiamiento y un marco de seguimiento y evaluación. El plan de ejecución debe reflejar el contenido del acuerdo y la situación real para asegurar que la aplicación esté en consonancia de manera realista con los objetivos previstos. La infraestructura, los recursos y la voluntad política adecuados son requisitos importantes para el éxito de la aplicación.

Seguimiento

Se puede establecer un órgano de seguimiento, como un comité conjunto que puede incluir representantes de los países participantes y partes interesadas competentes, según lo acuerden los países participantes. La tarea del comité conjunto es asegurar la aplicación del acuerdo sin tropiezos mediante la correcta interpretación de las cláusulas, la solución de controversias entre las partes del acuerdo, el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las disposiciones y sugerencias de modificaciones para realizar mejoras. Este organismo puede determinar indicadores SMART¹³ y recopilar datos pertinentes desglosados por género a fin de hacer un seguimiento de los adelantos en la aplicación de los acuerdos. Las entidades correspondientes deben responder a las deficiencias o los retos detectados en el seguimiento. En las *Orientaciones sobre acuerdos bilaterales de migración laboral* de la Red de las Naciones Unidas sobre la

Migración se proporciona un modelo de atribuciones para un comité conjunto de seguimiento (33).

Selección de indicadores

Los indicadores, hitos y fuentes de datos para hacer el seguimiento de la aplicación y evaluar los efectos del acuerdo dependen de los objetivos, el alcance y el contenido de cada acuerdo. Lo ideal es que se recopilen datos antes y después de la aplicación del acuerdo.

Los ejemplos de indicadores (cuadro 1) para el componente de bienestar de los trabajadores de salud migrantes pueden incluir el número de trabajadores de salud que se desplazan en virtud del acuerdo de migración y movilidad en comparación con otras rutas; la remuneración, las horas de trabajo, los derechos y oportunidades en comparación con los trabajadores de salud nacionales; y el acceso a los mecanismos de solución de controversias, prestaciones sociales y servicios jurídicos, etc., y su utilización.

Los indicadores para el componente de los sistemas de salud del arreglo sobre migración y movilidad podrían incluir, entre otros, la proporción y distribución de los trabajadores de salud migrantes, desglosados por sexo, ocupación y mecanismo de contratación, en comparación con la fuerza laboral nacional, desglosada por sector y nivel de prestación de servicios de salud; la proporción de puestos vacantes, desempleo y salida natural de personal de salud; la tasa de entrada, salida y retorno de los trabajadores de salud al mercado laboral; el período medio de empleo en el extranjero; el nivel de calificación y los años de servicio o experiencia de la fuerza laboral; la duración de la estancia; las inversiones financieras y técnicas en otras esferas del sistema de salud; la densidad nacional y subnacional de las categorías pertinentes de trabajadores de salud, etc.

Podrían realizarse encuestas *ad hoc* con los beneficiarios, tanto los empleadores, los trabajadores de salud migrantes como los gobiernos de los países de origen y destino, para recopilar información más detallada, en particular sobre las repercusiones de la migración y la movilidad, la evidencia de la transferencia de conocimientos y la contribución de la diáspora a los países de origen, así como la intención de migrar y desplazarse en el futuro.

Fuentes de datos relativos a los recursos humanos para la salud

Los datos sobre el personal de salud (incluida la información relacionada con la migración y la movilidad, como la entrada, la salida, el país de nacimiento, la capacitación y la nacionalidad) necesarios para el seguimiento y la evaluación, al igual que las fuentes de datos, deben mapearse para determinar las fuentes viables y también las deficiencias en la obtención de la información necesaria. Si bien los registros administrativos de acuerdos específicos hacen un

13 Específicos, medibles, viables, pertinentes y con plazos.

seguimiento del número de trabajadores de salud que entran en un país o salen de él en virtud de los acuerdos durante el período del acuerdo, también es importante comparar los datos con el desplazamiento del personal de salud mediante otras vías. Siempre que sea posible, el uso de los sistemas de información de salud y las fuentes de datos nacionales o subnacionales existentes para detectar la dotación total de trabajadores de salud, incluidos los trabajadores de salud migrantes, evitará la duplicación de esfuerzos y asegurará la coherencia y fiabilidad de los datos, pero requiere que

el sistema de información sea funcional y exacto, o que se fortalezca para que lo sea. En los casos en que las agencias privadas de contratación, las consultorías de inmigración y los empleadores privados estén regulados, la información periódica sobre la contratación de trabajadores de salud mediante estos canales podría obtenerse de la entidad encargada de supervisar su desempeño o supervisión. Los datos cualitativos se pueden obtener mediante entrevistas con las partes interesadas.

Cuadro 1. Ejemplos seleccionados de dominios e indicadores de seguimiento y evaluación

Ejemplo de ámbito de seguimiento y evaluación	Ejemplo de indicadores seleccionados (lista no exhaustiva)	Posibles fuentes de datos
Fortalecimiento de los sistemas de salud	Número de trabajadores de salud que parten del país de origen a través de diferentes rutas de migración o movilidad, incluidos los estudiantes ^{a,b,c,d,e}	• Cuentas Nacionales del Personal de Salud o sistemas de información sobre recursos humanos • Análisis del mercado laboral de salud • Base de datos de la OCDE sobre trabajadores de salud migrantes (nacidos en el extranjero) y capacitados en el extranjero (por país de origen) en destinos de la OCDE y fuera de la OCDE • Certificado de acreditación, certificados de migración expedidos por organismos reguladores u otras entidades en los países de origen, si corresponde • Agencias de contratación privadas
	Proporción y distribución de los trabajadores de salud migrantes en el país de destino ^{b,c,f}	• Cuentas Nacionales del Personal de Salud o recursos humanos para el sistema de información sobre salud • Base de datos de la OCDE sobre trabajadores de la salud migrantes (nacidos en el extranjero) y capacitados en el extranjero (por país de origen) en destinos de la OCDE y fuera de la OCDE
	Inversión en el sistema de salud del país de origen (apoyo técnico o financiero proporcionado por el país de destino para el desarrollo de la fuerza laboral o el empleo, la prestación de servicios, y el financiamiento en materia de salud)	• Cuentas nacionales de salud • Informe sobre los progresos realizados o informe de finalización del acuerdo
Bienestar de los trabajadores de salud	Diferencias salariales de los migrantes sobre la base de los ingresos mensuales ^{b,c}	• Términos del contrato • Ministerio de trabajo
	Número de trabajadores de salud contratados en virtud de un acuerdo específico ^{a,b,c,d,e}	• Ministerio de trabajo
	Número de trabajadores de salud migrantes que se desplazaron en virtud de un acuerdo bilateral que abona cotizaciones al régimen nacional de seguridad social del país de destino ^{b,c}	• Instituciones de seguridad social

Cuadro 1 (continuación). Ejemplos seleccionados de dominios e indicadores de seguimiento y evaluación

Ejemplo de ámbito de seguimiento y evaluación	Ejemplo de indicadores seleccionados (lista no exhaustiva)	Posibles fuentes de datos
Movilidad ordenada	Implicación del ministerio de salud y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales competentes en la negociación, la aplicación o el seguimiento del acuerdo	Documento del acuerdo e informes sobre los progresos realizados
	Establecimiento de comités de seguimiento conjuntos	Documento del acuerdo
	Número y proporción de trabajadores de salud contratados mediante un acuerdo bilateral que firmaron su contrato de empleo antes de su partida ^{a,b,c}	- Ministerio de trabajo - Servicios públicos de empleo - Agencias de empleo privadas
	Proporción de trabajadores de salud, contratados mediante un acuerdo bilateral, que han regresado a su país de origen ^{b,c,d,e}	- Ministerios de salud, de trabajo y del interior - Autoridades fronterizas y de inmigración - Informe sobre los progresos realizados o informe de finalización - Servicios estadísticos

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

^a Desglose por edad.

^b Desglose por sexo.

^c Desglose por ocupación.

^d Desglose por especialidad.

^e Desglose por años de práctica.

^f Desglose por mecanismo de contratación (si procede).

Colaboración para los datos de migración y movilidad

La recopilación de datos sobre la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud puede ser un reto, ya que estas pueden ocurrir con diferentes categorías de visas, como negocios, educación, empleo, migración permanente o turismo. Puede ser aún más difícil rastrear el desplazamiento internacional que no requiere visa. Si bien el acceso a la información sobre la entrada de trabajadores de salud migrantes a las ocupaciones de salud reguladas y sobre los trabajadores empleados en el sector público puede lograrse mediante los registros profesionales si se recogen datos sobre la fuerza laboral activa, puede ser más difícil obtener información sobre los que no ejercen una profesión regulada, los empleados en el sector privado o los que han salido del mercado laboral. Además, los datos agregados sobre las amplias categorías de trabajadores de salud pueden enmascarar los datos sobre la combinación de competencias dentro de las profesiones y en esferas de especialidad (por ejemplo, cuidados intensivos y salud mental). Si bien los requisitos de presentación de informes del Código y las Cuentas Nacionales del Personal de Salud proporcionan una plataforma para compartir datos sobre la dotación de trabajadores de salud y la migración y la movilidad, el fortalecimiento de la disponibilidad y la calidad de los datos para el análisis y el uso de los datos requiere la colaboración entre los países de origen y destino.

Mitigación de las deficiencias y los retos

Debe haber flexibilidad para incluir información actualizada y adiciones a las disposiciones originales a fin de resolver los problemas que surjan durante la aplicación. Los logros, las deficiencias y los retos detectados durante la aplicación y el seguimiento pueden presentarse durante las reuniones de examen periódicas y conjuntas para informar sobre la necesidad de realizar actualizaciones y ajustes. Por ejemplo, en el contexto de un acuerdo sobre educación, en caso de que las ausencias debidas a emergencias, licencia de maternidad o problemas de salud inesperadas comprometan la finalización oportuna de la capacitación, podrían adoptarse disposiciones de común acuerdo sobre la prórroga de la estancia; el número de trabajadores de salud o la esfera de especialidad de la capacitación podría actualizarse en función de las necesidades y prioridades de los países participantes, etc.

Comunicación con los trabajadores de salud

La comunicación periódica entre los trabajadores de salud migrantes y la entidad competente responsable de poner en práctica el acuerdo puede brindar apoyo y facilitar una transición sin tropiezos al sistema de salud del país de destino o el retorno de los trabajadores. Estos mecanismos también pueden canalizar información pertinente, como datos actualizados sobre el acuerdo, y facilitar el acceso a apoyo para responder

a los retos que afrontan los trabajadores de salud, incluidos los mecanismos de solución de controversias cuando sea necesario.

Puesta en marcha de entidades gubernamentales

La coherencia respecto de los funcionarios y las entidades gubernamentales responsables de poner en práctica el acuerdo de migración y movilidad de los trabajadores de salud o su seguimiento ayudará a fortalecer las relaciones entre los países y a fomentar la identificación con el programa. Esto también fomentará la capacidad de los organismos y del personal para apoyar la adaptabilidad de la aplicación de esos acuerdos. Por el contrario, una alta rotación del personal responsable puede dar lugar a la pérdida de memoria institucional, lo que puede causar una aplicación incompleta, retrasos e ineficiencias.

Presentación de informes

Todos los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud deben ser comunicados a la Secretaría de la OMS por la autoridad nacional designada de cada país como parte de los informes trienales sobre la aplicación del Código. La participación activa del ministerio de salud en la elaboración y aplicación de los acuerdos podría facilitar la presentación de informes.



Fase de finalización

Informe de finalización

Los resultados del acuerdo al final de su período de aplicación deben documentarse mediante un informe de finalización presentado por las entidades gubernamentales responsables de la aplicación o los órganos de seguimiento establecidos al comienzo del acuerdo; y también en el caso de renovación automática. El informe podría incluir información sobre los antecedentes, el alcance y el contenido del acuerdo, la evidencia y los datos de aplicación, las modalidades de la aplicación, los progresos realizados, los retos encontrados, las estrategias de mitigación adoptadas, los datos sobre los resultados de conformidad con los indicadores acordados, el papel de las partes interesadas clave, etc., para ayudar a los países a decidir sobre la continuación, modificación o ampliación de la vía de migración y movilidad.

Evaluación

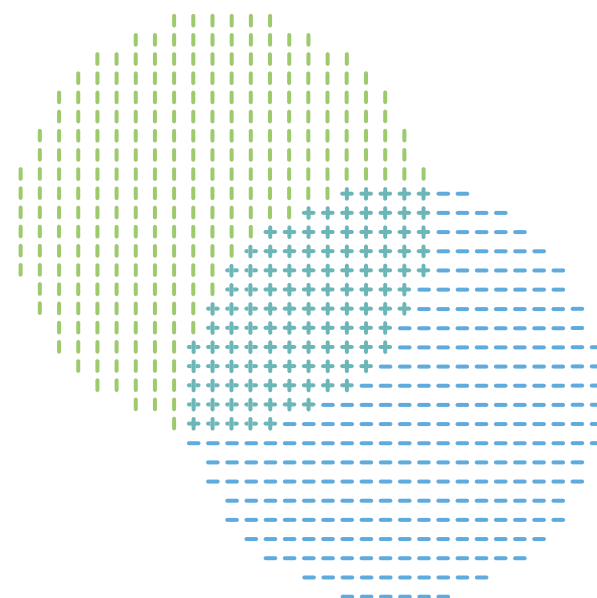
La evaluación de los efectos del acuerdo puede realizarla un organismo independiente (que no sea el comité conjunto) para evaluar también el papel de cada interesado directo que participe en el acuerdo. La evaluación del acuerdo después de su finalización puede determinar en qué medida se cumplieron los objetivos del acuerdo y su contribución a los objetivos

más amplios de los sistemas de salud; evaluar los costos y beneficios del acuerdo para ambos países; describir las deficiencias y los retos encontrados; y aplicar las innovaciones y enseñanzas extraídas en futuros acuerdos. Los efectos del acuerdo en los sistemas de salud de los países participantes podrían evaluarse incluso cuando la salud no es el objetivo principal del acuerdo. Una evaluación de los efectos de la migración y la movilidad de los trabajadores de salud en los sistemas de salud también podría ser una actividad periódica importante, que abarcaría múltiples acuerdos a lo largo del tiempo, si es factible. Dichas evaluaciones podrían aportar datos sobre cuestiones positivas y negativas para orientar la estrategia del personal de salud de los países de origen y destino y fortalecer los acuerdos futuros.

Intercambio de evidencia y aprendizaje

Los mecanismos actuales de presentación de informes del Código constituyen un mecanismo viable que podría ampliarse para incluir información y datos sobre la aplicación y los resultados de los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud, a fin de intercambiar las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas a nivel mundial. Hacer pública la información no solo aumentará la transparencia, sino que también ayudará a los países que están iniciando acuerdos sobre migración y movilidad por primera vez a determinar y adoptar prácticas prometedoras.

En el cuadro 2 se presenta una lista de verificación de los elementos que han de considerarse durante las diferentes fases de elaboración y aplicación de acuerdos bilaterales.



Cuadro 2. Lista de verificación para la elaboración y aplicación de acuerdos bilaterales en consonancia con el *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud*

1 Fase de preparación	2 Fase de negociación
☐ Llevar a cabo una evaluación de las necesidades del sector de la salud y del personal de salud, incluido el análisis del mercado laboral de la salud (en los países de origen y destino). ☐ Considerar diversos enfoques para atender las necesidades y los retos de la fuerza laboral, incluida la celebración de acuerdos con un componente de la fuerza laboral de la salud. Si la meta es establecer un acuerdo de este tipo, tener en cuenta los resultados de la evaluación de las necesidades de personal. ☐ Considerar los costos y beneficios de los acuerdos gubernamentales de migración y movilidad de los trabajadores de salud frente a intervenciones alternativas y paralelas para resolver los problemas de la fuerza laboral en consonancia con la estrategia del sector de la salud. ☐ Seleccionar un mecanismo adecuado de coordinación gubernamental, como un proceso continuo de consulta interinstitucional, para la elaboración de acuerdos con un papel central o rector del ministerio de salud. ☐ Consultar con otros sectores pertinentes y representantes de los trabajadores, los empleadores y los contratistas como parte de la elaboración de objetivos y posiciones de negociación coherentes entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales. ☐ Deliberar sobre el tipo de acuerdo gubernamental más apropiado para lograr los objetivos nacionales más amplios en consonancia con las políticas nacionales. ☐ Establecer un marco para la negociación y ejecución del acuerdo, especificando la función de las diferentes entidades gubernamentales.	☐ Implicar a todas las partes interesadas competentes, incluidos los ministerios de salud de ambas partes (países de origen y destino) y determinar un enfoque para responder a las preocupaciones de los diferentes grupos. ☐ Determinar los objetivos y los beneficios previstos del acuerdo para ambas partes, en consonancia con el Código. ☐ Dependiendo del tipo de acuerdo, asegurar la consonancia con las normas internacionales del trabajo y otros instrumentos internacionales sobre migración y movilidad. ☐ Considerar los posibles efectos del acuerdo en los sistemas de salud de cada país y promulgar contramedidas para mitigar todo efecto negativo. ☐ Determinar si el arreglo en el acuerdo es ético, justo y equilibrado en lo que atañe a proporcionar beneficios para el sistema de salud para ambas partes, teniendo en cuenta que la migración y la movilidad ocurren en paralelo mediante vías alternativas. ☐ Determinar intervenciones específicas para el fortalecimiento de los sistemas de salud en los países de origen que puedan mejorar la prestación de servicios y los resultados de salud, lo que también debería formar parte de la evaluación del acuerdo. ☐ Asegurar que el reconocimiento de calificaciones sea transparente, justo, objetivo, imparcial, no discriminatorio y no más complicado de lo necesario; después de evaluar las diferencias de la capacitación en los países participantes, determinar los requisitos adicionales legítimos para la entrada a la práctica; y asegurar que los mecanismos compensatorios sean accesibles. ☐ Aplicar una perspectiva de género para prever y gestionar adecuadamente los efectos en materia de género del acuerdo asegurando la promoción del empoderamiento en lugar de restringir la migración y la movilidad. ☐ Determinar mecanismos para asegurar que los actores del sector privado, como las agencias de contratación, los consultores de inmigración y los empleadores, cumplan con los términos del acuerdo.

Cuadro 2 (continuación). Lista de verificación para la elaboración e implementación de acuerdos bilaterales en consonancia con el *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud*

3 Fase de aplicación	4 Fase de finalización
☐ Elaborar un plan detallado de ejecución y gestión para el acuerdo que también incluya el seguimiento y la evaluación, los recursos necesarios y las fuentes de financiamiento. ☐ Crear una plataforma para la comunicación y reuniones periódicas entre ambas partes (por ejemplo, un comité conjunto) para hacer un seguimiento de los progresos, compartir información sobre la aplicación y detectar las deficiencias y los retos que deben afrontarse. ☐ Determinar indicadores apropiados, hitos, fuentes de datos y frecuencia de la recopilación de datos sobre los componentes del sistema de salud y los componentes del bienestar de los trabajadores de salud, que se utilizarán en el seguimiento de la aplicación y para la evaluación futura del acuerdo. ☐ Determinar mecanismos, incluida la colaboración internacional, para afrontar los retos planteados en cuanto a los datos sobre el personal de salud, incluidos los datos desglosados sobre migración y movilidad. ☐ Actualizar el acuerdo para responder a asuntos pertinentes, según sea necesario, durante las reuniones periódicas entre ambas partes. ☐ Crear un sistema de comunicación regular entre el personal internacional y el organismo público responsable de poner en práctica el acuerdo para apoyar la transición o el retorno sin tropiezos. ☐ Asegurar la coherencia respecto del organismo o los organismos públicos y el personal responsable de poner en funcionamiento el acuerdo, a fin de permitir el desarrollo de capacidades a lo largo del tiempo y apoyar la adaptabilidad de la aplicación. ☐ Compartir el acuerdo de migración y movilidad con la OMS.	☐ Asegurar que el informe de finalización incluya información sobre los antecedentes y el objetivo del acuerdo, datos cualitativos y cuantitativos sobre la aplicación, información sobre el proceso, las metas logradas, los retos, las innovaciones y la experiencia adquirida; y utilizar los resultados para determinar la continuación, actualización o ampliación del acuerdo. ☐ Determinar si el acuerdo cumplió los objetivos previstos; utilizando los datos disponibles, evaluar sus efectos en el sistema de salud de los países de origen y destino y en los trabajadores de salud, y utilizar los resultados para fundamentar las estrategias de la fuerza laboral y la elaboración de futuros acuerdos. ☐ Compartir con la OMS el informe de finalización, junto con información sobre la aplicación y la evaluación del acuerdo.

7. Función de la Secretaría de la OMS

Si bien los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud representan un mecanismo de colaboración directa entre los países participantes, la Secretaría de la OMS puede desempeñar una serie de funciones de apoyo, según sea necesario y según lo soliciten los Estados Miembros, implicando, según proceda, a otros organismos de las Naciones Unidas mediante la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración.

La Secretaría de la OMS proporcionará, cuando los Estados Miembros lo soliciten, apoyo específico en relación con los acuerdos bilaterales, en particular:

- **Asistencia técnica a los Estados Miembros**
Esto puede incluir facilitar la aplicación del Código; y brindar apoyo técnico en las diferentes etapas de la preparación, elaboración y aplicación de los acuerdos (véase el capítulo 6); el fomento de capacidades sobre la base de las necesidades y demandas específicas de cada país; apoyo operativo en la realización de análisis del mercado laboral de la salud; creación de vínculos con expertos de diferentes sectores (por ejemplo, educación, trabajo, migración, regulación ocupacional, comercio, etc.) en colaboración con otros organismos competentes de las Naciones Unidas (por ejemplo, la OIT, la OIM, la UNESCO, la OMC); elaboración de metodologías para evaluar los efectos de los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud en los sistemas de atención de salud y el bienestar de estos trabajadores. A petición de los Estados Miembros, la OMS también proporcionará una evaluación confidencial de las versiones preliminares de los acuerdos sobre la armonización con los principios del Código de contratación internacional justa y ética. Dicha evaluación se basará en los criterios y elementos descritos en el presente documento, a fin de encontrar oportunidades para perfeccionar y fortalecer su contenido a fin de mejorar el cumplimiento de las disposiciones del Código.
- **Intercambio de información y buenas prácticas**
La creación de un repositorio sobre la migración y la movilidad de los trabajadores de salud y las políticas y reglamentaciones nacionales e internacionales sobre la migración y la movilidad de estos trabajadores podrían servir a los Estados

Miembros para obtener una perspectiva mundial para la planificación y el diseño de políticas, marcos normativos y acuerdos basados en la evidencia sobre la migración y la movilidad de los trabajadores de salud. Un repositorio de acuerdos gubernamentales, incluidos sus textos; información sobre los antecedentes, la negociación y el funcionamiento, y evidencia sobre su aplicación y sus resultados contribuirían a promover la transparencia y aumentar la base mundial de conocimientos, proporcionando así una referencia adicional para los Estados Miembros que inician acuerdos de este tipo por primera vez. Además del análisis de los datos de los Estados Miembros mediante el informe sobre la aplicación del Código, la elaboración de una metodología y la realización de estudios de casos que analicen los diferentes acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud, su desempeño a lo largo del tiempo y sus efectos podrían servir de base para las decisiones de los Estados Miembros y permitirles incorporar prácticas positivas de interés para sus contextos.

- **Aplicación de los acuerdos en el contexto del Código**
Los gobiernos y las partes interesadas competentes de todos los sectores podrían reunirse en los países e informarse sobre el Código, centrándose específicamente en los elementos recomendados y las características operativas de los acuerdos sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud, y alentar a los Estados Miembros a incorporar elementos de fortalecimiento de los sistemas de salud, del bienestar de estos trabajadores y de la sostenibilidad de la fuerza laboral en sus políticas de educación, relaciones exteriores, comercio, inmigración, regulación ocupacional, trabajo y migración para obtener resultados de desarrollo socioeconómico.

Referencias

1. Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes: resultados y metodología, tercera edición. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2021 (<https://www.ilo.org/es/publications/estimaciones-mundiales-de-la-oit-sobre-los-trabajadores-y-las-trabajadoras>, consultado el 22 de febrero del 2023).
2. C097 – Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1949 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242, consultado el 22 de febrero del 2023).
3. C143 – Convenio sobre los trabajadores migrantes (Disposiciones Complementarias), 1975 (núm. 143). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1975 (https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=normlexpub:12100:0::no:12100:p12100_instrument_id:312288:no), consultado el 22 de febrero del 2023).
4. WHO report on global health worker mobility. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/370938>, consultado el 19 de julio del 2023).
5. Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVID-19 crisis in OECD countries. París: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; 2020 (<https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/contribution-of-migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-covid-19-crisis-in-oecd-countries-2f7bace2/>, consultado el 22 de febrero del 2023).
6. A dynamic understanding of health worker migration. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (<https://www.who.int/publications/m/item/a-dynamic-understanding-of-health-worker-migration>, consultado el 22 de febrero del 2023).
7. Dumont J-C y Lafortune G. International migration of doctors and nurses to OECD countries: recent trends and policy implications. En: Buchan J, Dhillion IS, Campbell J, eds. Health employment and economic growth: an evidence base. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. pp. 81-118 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326411/9789241512404-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consultado el 22 de febrero del 2023).
8. Omaswa F. COVID-19 exposes a global scramble for health workers. Health Workers for All Coalition; 2020 (https://achest.org/index.php?Itemid=481&Item_id=279&option=com_zoo&task=item&utm_source=chatgpt.com, consultado el 22 de febrero del 2023).
9. Buchan J, Catton H, Schaffer FA. Sustain and retain in 2022 and beyond: the global nursing workforce and the COVID-19 pandemic. Ginebra: Consejo Internacional de Enfermeras; 2022 (<https://www.icn.ch/es/recursos/publicaciones-e-informes/apoyar-y-retener-en-2022-y-mas-alla>, consultado el 22 de febrero del 2023).
10. Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud. 63.ª Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2010 (<https://www.who.int/es/publications/m/item/nri-2021>, consultado el 22 de febrero del 2023).
11. Lista de la OMS para el apoyo y la salvaguardia del personal de salud, 2023. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023 (<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/374014/9789240081543-spa.pdf?sequence=1>, consultado el 14 de marzo del 2023).
12. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Ginebra: Organización Mundial del Comercio; 1995 (https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm, consultado el 22 de febrero del 2023).
13. Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular [resolución A/RES/73/195]. Septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas; 2018 (<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/452/03/pdf/n1845203.pdf>, consultado el 22 de febrero del 2023).
14. Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 2019 (<https://www.unesco.org/es/legal-affairs/global-convention-recognition-qualifications-concerning-higher-education>, consultado el 22 de febrero del 2023).

15. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares [resolución A/RES/45/158]. Naciones Unidas; 1990 (<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>, consultado el 22 de febrero del 2023).
16. Annual remittances data (mayo del 2021). Washington, D.C.: Banco Mundial; 2021 (<https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>, consultado el 18 de noviembre del 2024).
17. Abarcar P y Theoharides C. Medical worker migration and origin-country human capital: evidence from U.S. Visa Policy. *Rev Econ Stat.* 2021;1(46) (https://doi.org/10.1162/rest_a_01131, consultado el 22 de febrero del 2023).
18. GBD 2019 Human Resources for Health Collaborators. Measuring the availability of human resources for health and its relationship to universal health coverage for 204 countries and territories from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet.* 2022;6736(22):1-26 (doi:10.1016/S0140-6736(22)00532-3, consultado el 22 de febrero del 2023).
19. Abdalla FM, Omar MA, Badr EE. Contribution of Sudanese medical diaspora to the healthcare delivery system in Sudan: exploring options and barriers. *Hum Resour Health.* 2016;14(28). (<https://doi.org/10.1186/s12960-016-0123-x>).
20. Taslakian EN, Garber K, Shekherdimian S. Diaspora engagement: a scoping review of diaspora involvement with strengthening health systems of their origin country. *Glob Health Action.* 2022;15(1) (doi:10.1080/16549716.2021.2009165, consultado el 22 de febrero del 2023).
21. Micah AE, Solorio J, Stutzman H, Zhao Y, Tsakalos G, Dieleman JL. Development assistance for human resources for health, 1990–2020. *Hum Resour Health.* 2022;20(51):1-12 (doi:10.1186/s12960-022-00744-x, consultado el 22 de febrero del 2023).
22. Bhargava A y Docquier F. HIV pandemic, medical brain drain, and economic development in sub-Saharan Africa. *World Bank Econ Rev.* 2008;22(2):345-366 (doi:10.1093/wber/lnh005 consultado el 22 de febrero del 2023).
23. Chauvet L, Gubert F, Sandrine MS. Aid, Remittances, medical brain drain and child mortality: evidence using inter and intra-country data. *J Dev Stud.* 2013;49(6):801-818 (doi:10.1080/00220388.2012.742508, consultado el 22 de febrero del 2023).
24. Informe del Grupo consultivo de expertos encargado de examinar la pertinencia y eficacia del *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud* [documento A73/9, 73.ª Asamblea Mundial de la Salud]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_9-sp.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
25. Acemoglu D, Johnson S, Robinson JA. Reversal of fortune: geography and institutions in the making of the modern world income distribution. *Q J Econ.* 2002;117(4):1231-1294. (<https://doi.org/10.1162/003355302320935025>).
26. Abimbola S y Pai M. Will global health survive its decolonisation? *Lancet.* 2020;396(10263):1627-1628 (doi:10.1016/S0140-6736(20)32417-X, consultado el 22 de febrero del 2023).
27. Packard RM. A history of global health: interventions into the lives of other peoples. Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press; 2016.
28. Working for health and growth: investing in the health workforce. High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250040>, consultado el 22 de febrero del 2023).
29. Buchan J y Catton H. COVID-19 and the international supply of nurses. Ginebra: Consejo Internacional de Enfermeras; 2020 (https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-7/COVID19_internationalsupplyofnurses_Report_FINAL.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
30. Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal de salud 2030. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016 (resumen en español disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_38-sp.pdf, publicación completa en inglés disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250368>, consultado el 22 de febrero del 2023).
31. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas; 1966 (<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>, consultado el 22 de febrero del 2023).
32. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra: OMS; 1946 ([https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-sp.pdf#page=6%20\(LINK\)](https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-sp.pdf#page=6%20(LINK)), consultado el 22 de febrero del 2023).

33. Orientaciones sobre acuerdos bilaterales de migración laboral. Red de las Naciones Unidas sobre la Migración; 2022 (https://migrationnetwork.un.org/system/files/resources_files/21-448_es_IOM%20EE%20UU%20-%20Guidance%20on%20bilateral%20labour%20migration%20agreement__V3-4%20April%202022%20FINAL_2_0.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
34. Bernhardt M y Henriette S. Sustainable recruitment of nurses (Triple Win). Bonn: GIZ; 2022 (<https://www.giz.de/en/worldwide/41533.html>, consultado el 22 de febrero del 2023).
35. de Oliveira APC, Dussault G, Craveiro I. Challenges and strategies to improve the availability and geographic accessibility of physicians in Portugal. Hum Resour Health. 2017;15(24) (doi:10.1186/s12960-017-0194-3, consultado el 22 de febrero del 2023).
36. Carzaniga A, Ibadat D, Magdeleine J, Xu L. International health worker mobility and trade in services. Ginebra: Organización Mundial del Comercio; 2019. (<https://ideas.repec.org/p/zbw/wtowps/ersd201913.html>).
37. Walsh AM y Brughra RF. Brain drain to brain gain: Ireland's two-way flow of doctors. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (<https://www.who.int/publications/m/item/2017-ireland-hw-migration>, consultado el 22 de febrero del 2023).
38. Te V, Griffiths R, Law K, Hill PS, Annear PL. The impact of ASEAN economic integration on health worker mobility: a scoping review of the literature. Health Policy Plan. 2018;33(8):957-965 (doi:10.1093/heapol/czy071, consultado el 22 de febrero del 2023).
39. Dhillon IS, Clark ME, Kapp R. Innovations in cooperation: a guidebook on bilateral agreements to address health worker migration. Washington, D.C.: The Aspen Institute; 2010 (https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/files/content/docs/pubs/Bilateral%20Report_final%20code.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
40. Thompson M y Walton-Roberts M. International nurse migration from India and the Philippines: the challenge of meeting the sustainable development goals in training, orderly migration and healthcare worker retention. J Ethn Migr Stud. 2019;45(14):2583-2599 (doi:10.1080/1369183X.2018.1456748, consultado el 22 de febrero del 2023).
41. Cala DC. La cooperacion internacional de Cuba frente a la COVID-19: ampliando la solidaridad. Bol la OPS/OMS en Cuba. 2021;25(1):32-35. (<https://iris.paho.org/handle/10665.2/53339>).
42. Asante AD, Negin J, Hall J, Dewdney J, Zwi AB. Analysis of policy implications and challenges of the Cuban health assistance program related to human resources for health in the Pacific. Hum Resour Health. 2012;10(10) (doi:10.1186/1478-4491-10-10, consultado el 22 de febrero del 2023).
43. R086 – Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 86). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1949 (https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=1000:12100:::12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312424, consultado el 22 de febrero del 2023).
44. R151 – Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 (núm. 151). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1975 (https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=1000:12100:::12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489, consultado el 22 de febrero del 2023).
45. Normas internacionales del trabajo sobre migración laboral. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2023 (<https://www.ilo.org/es/temas/migracion-laboral/normas-del-trabajo-sobre-la-migracion>), consultado el 22 de febrero del 2023).
46. C149 – Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1979 (https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312294:NO, consultado el 22 de febrero del 2023).
47. R157 – Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1977 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NO:RMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312495, consultado el 22 de febrero del 2023).
48. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2022 (<https://www.ilo.org/es/declaracion-de-la-oit-relativa-los-principios-y-derechos-fundamentales-en/acerca-de-la-declaracion/texto-de-la-declaracion-y-su-seguimiento>, consultado el 22 de febrero del 2023).
49. Principios generales y directrices para la contratación equitativa y definición de las comisiones de contratación y gastos conexos. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2019 (<https://www.ilo.org/es/publications/principios-generales-y-directrices-para-la-contratacion-equitativa-y>, consultado el 22 de febrero del 2023).

50. Clemens M y Dempster H. Ethical recruitment of health workers: using bilateral cooperation to fulfill the Organización Mundial de la Salud's Global Code of Practice. CGD Policy Paper 212. Washington, D.C.: Center for Global Development; 2021 (<https://www.cgdev.org/sites/default/files/PP212-Clemens-Dempster-Ethical-recruitment-health-workers-WHO-Code.pdf>, consultado el 22 de febrero del 2023).
51. Glinos IA. Health professional mobility in the European Union: exploring the equity and efficiency of free movement. *Health Policy*. 2015;119(12):1529-1536. (doi:10.1016/j.healthpol.2015.08.010 consultado el 22 de febrero del 2023).
52. Jahnz A, Berard L, Bottomley C. Talent Partnerships: Commission launches new initiative to address EU skills shortages and improve migration cooperation with partner countries. IP/21/2921. Bruselas: Comisión Europea; 2021 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921, consultado el 22 de febrero del 2023).
53. Code of practice for the international recruitment of health and social care personnel in England (actualizado el 22 de agosto del 2022). Departamento de Salud y Servicios Sociales del Reino Unido (GOV.UK); 2022 (<https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-the-international-recruitment-of-health-and-social-care-personnel/code-of-practice-for-the-international-recruitment-of-health-and-social-care-personnel-in-england>, consultado el 22 de febrero del 2023).
54. Abuagla A y Badr E. Challenges to implementation of the WHO Global Code of Practice on International Recruitment of Health Personnel: the case of Sudan. *Hum Resour Health*. 2016;14(26) (doi:10.1186/s12960-016-0117-8, consultado el 22 de febrero del 2023).
55. Makulec A. Philippines' bilateral labour arrangements on health-care professional migration: in search of meaning. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2014 (www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/486992.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
56. Yeates N y Pillinger J. International healthcare worker migration in Asia Pacific: international policy responses. *Asia Pac Viewp*. 2018;59(1):92-106 (doi:10.1111/apv.12180, consultado el 22 de febrero del 2023).
57. Yakubu K, Durbach A, van Waes A, Mabunda SA, Peiris D, Shanthosh J *et al*. Governance systems for skilled health worker migration, their public value and competing priorities: an interpretive scoping review. *Glob Health Action*. 2022;15(1) (doi:10.1080/16549716.2021.2013600, consultado el 22 de febrero del 2023).
58. Gough I. Surgical competence and mutual recognition in ASEAN countries: editorials. *ANZ J Surg*. 2013;83(3):99 (doi:10.1111/ans.12054, consultado el 22 de febrero del 2023).
59. Takahashi K. Japan's immigration policy and the EPA between the Philippines and Japan. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Yamagata, 2018 (<https://www.hs.yamagata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/10TAKAHASHI.pdf>, consultado el 22 de febrero del 2023).
60. Scheffler RM, Campbell J, Cometto G, Maeda A, Liu J, Bruckner TA *et al*. Forecasting imbalances in the global health labor market and devising policy responses. *Hum Resour Health*. 2018;16(1):1-10 (doi:10.1186/s12960-017-0264-6, consultado el 22 de febrero del 2023).
61. Delivered by women, led by men: a gender and equity analysis of the global health and social workforce. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311322>, consultado el 22 de febrero del 2023).
62. Yakubu K, Abimbola S, Durbach A, Balane C, Peiris D, Joshi R. Utility of the right to health for addressing skilled health worker shortages in low- and middle-income countries. *Int J Heal Policy Manag*. 2022;(x):1-11 (doi:10.34172/ijhpm.2022.6168 consultado el 22 de febrero del 2023).
63. Directrices de la OMS sobre el desarrollo, la captación, la contratación y la retención del personal de salud en las zonas rurales y remotas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/346648>, consultado el 22 de febrero del 2023).
64. C118 – Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1962 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NO RMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312263, consultado el 21 de marzo del 2023).
65. C181 – Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1997 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326, consultado el 21 de marzo del 2023).
66. Guía para el análisis del mercado laboral de la salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/374423>, consultado el 22 de febrero del 2023).

Anexo 1. Revisión bibliográfica rápida acerca de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Antecedentes

A nivel mundial, subsanar la escasez de trabajadores de salud ha sido una prioridad para los gobiernos desde hace muchos años. Este reto cobró una nueva urgencia tras la pandemia de COVID-19, que causó interrupciones generalizadas en los servicios de salud esenciales y dio lugar a informes de un aumento de la dependencia de la contratación internacional de personal asistencial y de salud para cubrir los puestos de trabajo vacantes, especialmente en los países de ingresos medianos y altos (1).

En los últimos años, los gobiernos han manifestado un interés creciente en gestionar la movilidad de los trabajadores de salud. En muchos lugares se están realizando esfuerzos para comprender mejor, y configurar, los canales, los factores impulsores y las condiciones de esa movilidad. A modo de ejemplo, el Reino Unido ha instituido un código de prácticas para la contratación internacional de personal social y de salud, cuyo objetivo es promover normas de práctica ética de alto nivel en la contratación internacional de trabajadores de salud (2).

Los Estados Miembros de la OMS han establecido diferentes tipos de acuerdos internacionales para facilitar el desplazamiento de los trabajadores de salud, subsanar la escasez, impartir capacitación y educación a estos trabajadores, prestar asistencia para el desarrollo, promover la cooperación en materia de salud y mejorar las condiciones de estos trabajadores durante su desplazamiento a través de las fronteras. Los acuerdos bilaterales y regionales pertinentes reflejan muchos formatos y contenidos diferentes relacionados con la movilidad de los trabajadores de salud. Abordan una gama de cuestiones, como las prácticas de contratación,

el reconocimiento de las calificaciones, la integración en el país de destino, el acceso a la capacitación, las normas de inmigración y la solución de controversias (3).

Si bien en la mayoría de los casos los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud son bilaterales (entre dos gobiernos), los países también han concertado acuerdos regionales, por ejemplo, en el marco de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y la Unión Europea. Además de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, los acuerdos comerciales pueden afectar al desplazamiento de estos trabajadores a nivel internacional; algunos acuerdos comerciales incluyen compromisos de mercados libres para la prestación de servicios de salud por parte de las personas que cruzan las fronteras (conocido como “modo 4”) (4). La estructura internacional en torno a la contratación ética y la movilidad de estos trabajadores también incluye políticas nacionales y regionales (3).

Los trabajadores de salud se desplazan en muchas direcciones: de norte a sur, de sur a norte, de norte a norte y de sur a sur. Al parecer, la mayoría de las veces se han establecido acuerdos para subsanar la escasez de personal de salud en los países de destino, que a menudo son naciones de ingresos más altos, y el desempleo de los trabajadores de salud calificados en los países de origen. Los países también han concertado acuerdos formales de movilidad de los trabajadores de salud para otros fines, por ejemplo, para otorgar un “reconocimiento mutuo” bilateral o regional de las calificaciones profesionales (5).

Adoptado en el 2010, el *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal*

de salud (“el Código”) tiene por objeto establecer y promover principios y prácticas voluntarios en relación con la contratación internacional ética de personal de salud, tomando en consideración los derechos, las obligaciones y las expectativas de los países de origen, los países de destino y los trabajadores de salud.

Además del Código, se aplica una gama de normas, directrices e instrumentos internacionales al desplazamiento de trabajadores, incluidos los trabajadores de salud. Algunos instrumentos internacionales regulan aspectos generales de la migración, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que está diseñado para apoyar la cooperación internacional en la gobernanza de la migración internacional, brindar opciones de políticas a los países sobre algunas de las cuestiones más apremiantes y dar a los países el espacio y la flexibilidad para llevar a cabo la aplicación en consonancia con sus contextos y capacidades (6). Más específicamente, la OIT proporciona varias herramientas para los gobiernos, los trabajadores y los empleadores en materia de movilidad laboral; por ejemplo, las normas de la OIT rigen el trato de los trabajadores migrantes y establecen principios generales y directrices prácticas para su contratación ética (7-11). Respecto de la atención de salud, la OIT ha promulgado normas para la contratación internacional ética de personal de enfermería (12, 13). Además, la Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior contribuye a asegurar que las calificaciones de las personas se evalúen sobre la base de criterios justos, transparentes y no discriminatorios (14).

En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, los Miembros de la OMC pueden comprometerse a abrir sus mercados a fin de permitir la prestación de servicios de salud por parte de personas extranjeras. Como se ha señalado, la prestación de servicios basada en el desplazamiento de personas a través de las fronteras (personas extranjeras que trabajan para prestadores de servicios de salud de propiedad extranjera o son autónomos, y se encuentran temporalmente en la jurisdicción receptora) se denomina prestación de servicios del modo 4. En la medida en que la movilidad de los trabajadores de salud esté abarcada por los compromisos del modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los Miembros de la OMC están obligados a respetar la obligación de la nación más favorecida; esto significa que deben conceder a todos los Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el que se da a los demás Miembros de la OMC. Esto se aplica independientemente de si han asumido compromisos específicos para cada sector. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios permite que los acuerdos de libre comercio regionales o bilaterales entre dos o más economías se desvíen del principio de la nación más favorecida según ciertas condiciones.

El uso de acuerdos bilaterales por parte de los gobiernos para gestionar la movilidad internacional de los trabajadores de salud ha aumentado con el tiempo, como lo demuestran los informes de los Estados Miembros de la OMS sobre la implementación del Código (15, 16). Estos acuerdos también parecen haber permitido un apoyo de refuerzo internacional durante la pandemia de COVID-19 (17). La iniciativa Asociaciones para el Talento de la UE (2021) tiene por objeto ampliar las vías legales para el desplazamiento de los trabajadores de salud y establecer nuevas alianzas internacionales para la prestación de atención de salud (18). La versión actualizada del Código de Prácticas del Reino Unido respalda la concertación de acuerdos bilaterales mutuamente beneficiosos para la contratación de estos trabajadores (2).

Objetivo

El objetivo principal de este anexo es buscar evidencia sobre los efectos de los acuerdos bilaterales y regionales en la movilidad de los trabajadores de salud, en los sistemas de salud de los países participantes y en el bienestar de estos trabajadores.

Metodología

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica rápida para realizar una búsqueda en PubMed, SSRN y ScienceDirect utilizando las palabras clave que se presentan a continuación (recuadro A1.1). También se realizaron búsquedas manuales en Google de publicaciones adicionales sobre los efectos de los acuerdos conocidos de movilidad de los trabajadores de salud sobre la base de los informes relativos al Código. También se efectuaron búsquedas de bibliografía gris en los sitios web de organizaciones específicas (Center for Global Development) y gobiernos de países (ministerios de salud, ministerios de trabajo y ministerios de comercio) que se sabe que han firmado acuerdos bilaterales de movilidad de los trabajadores de salud.

Los criterios de inclusión para la revisión incluyeron publicaciones en inglés relativas a acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, publicadas entre enero del 2010 y octubre del 2022, que contuvieran información sobre la aplicación o el análisis de los efectos del acuerdo. También se incluyeron acuerdos prospectivos que incluían los efectos previstos o teóricos.

Los criterios de exclusión incluyeron publicaciones que contenían un análisis general o conceptual sobre la movilidad de los trabajadores de salud en general, pero no específicamente sobre los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, publicaciones que mencionaran este tipo de acuerdos de pasada o que se centraran en los acuerdos de movilidad de los trabajadores de salud existentes, pero sin información sobre la aplicación o los efectos (reales o previstos), y artículos de periódicos o blogs.

Las publicaciones pertinentes, tanto las verificadas por homólogos como las de bibliografía gris, se seleccionaron en función del título, el resumen y las palabras clave utilizadas para describir la publicación. JB y SF seleccionaron de forma independiente los títulos y los resúmenes, para compensar el sesgo que podría ocurrir al ser examinados por una sola persona. Ambos investigadores leyeron el texto completo de las publicaciones preseleccionadas y confirmaron la inclusión o exclusión (figura A1.1) de las publicaciones preseleccionadas mediante un debate.

Los datos fueron analizados y sintetizados empleando un análisis cualitativo del contenido. JB y SF leyeron

el texto completo de las publicaciones seleccionadas y codificaron los datos en siete categorías: el acuerdo específico; la región geográfica abarcada por el acuerdo; las oportunidades y los retos de la implementación del acuerdo; datos cuantitativos sobre la implementación o los efectos; evaluación general del acuerdo; el tema central de la investigación; y recomendaciones. Las notas de ambos investigadores fueron comparadas y analizadas para asegurar la concordancia y la coherencia. CW leyó el texto completo de los artículos para verificar los mensajes clave.

Recuadro A1.1 Estrategia de búsqueda: palabras clave

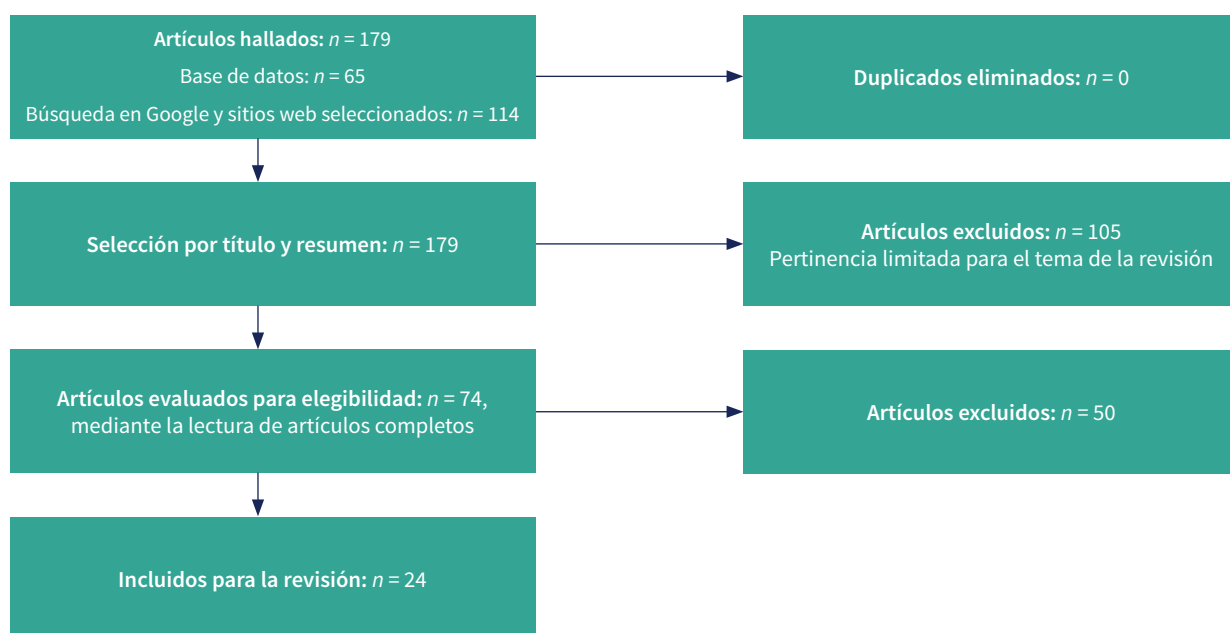
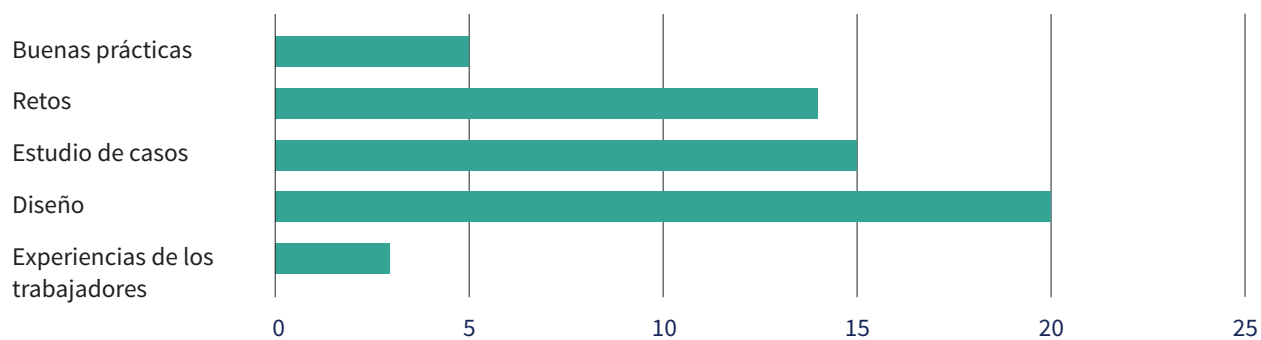
“bilateral agreements” AND “health worker mobility”, “health worker mobility agreements”, “mobility and health systems”, “health worker shortages”, “international health worker migration”, “international recruitment of medical personnel”, “health worker policies”, “doctors migration”, “nurses migration”, “medical brain drain”, “medical brain gain”, “migration policy for skilled workers”, “recognition of qualifications for health workers”, “standards for mutual recognition of qualifications”, “health worker mobility impact”, “global movement of doctors”, y “global movement of nurses”, solas o combinadas con los nombres de los países que suscribieron los acuerdos.

Resultados

Se seleccionó para la revisión un total de 24 publicaciones (verificadas por homólogos y de bibliografía gris) que trataban sobre los efectos de los acuerdos bilaterales y regionales en la movilidad de los trabajadores de salud, los sistemas de salud y los trabajadores de salud (véase el cuadro A1.21). De estas, 15 eran publicaciones verificadas por homólogos y nueve eran de bibliografía gris. La mayoría de estas fueron descriptivas y proporcionaron un análisis cualitativo de los efectos de los acuerdos, en lugar de datos sobre aplicación y evaluación cuantitativa.

Los temas principales de los artículos se reflejan en la figura A1.2; algunos tratan más de un tema. El diseño de los acuerdos bilaterales fue el tema más común (83%). En la mayoría de las publicaciones (58%) también se destacaron los retos en la aplicación del acuerdo, mientras que otras se referían a las buenas prácticas (21%) y a la experiencia de los trabajadores de salud (13%).

La gran mayoría de las publicaciones (87,5%) se referían a un acuerdo específico entre dos países o a varios acuerdos que implicaban a un país o región específicos, y solo algunas tenían un enfoque global (12,5%).

Figura A1.1 Diagrama PRISMA que muestra el proceso de búsqueda y selección bibliográficas**Figura A1.2** Temas principales de los artículos

Cuadro A1.1 Sinopsis de los artículos sobre los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Autor principal	Año	Foco geográfico	Tema central del artículo	Conclusiones clave	Tipo de estudio^a
Fernandez KR (1)	2022	Mundial	Acuerdos bilaterales laborales y movilidad de los trabajadores de salud durante la pandemia	- La COVID-19 puso de manifiesto la dependencia de trabajadores de salud migrantes para subsanar las brechas de personal. - No está claro cómo estos acuerdos benefician a los trabajadores de salud y a los países de origen, y también a los países de destino.	Estudio cualitativo
Yakubu K et al. (5)	2022	Mundial	Examen de las publicaciones sobre los efectos de los acuerdos bilaterales sobre la movilidad de los trabajadores de salud	- En la actualidad, los acuerdos bilaterales parecen beneficiar desproporcionadamente a los países de destino. - Los servicios de salud en los países de origen requieren más atención. - Es importante tener en cuenta todos los canales para el desplazamiento de los trabajadores. - Es necesario mejorar la aplicación y el seguimiento de los acuerdos.	Revisión
European Commission (18)	2020	Unión Europea-terceros países	Asociaciones para el Talento de la UE y la movilidad de los trabajadores de salud	- Evaluación positiva de las Asociaciones para el Talento de la UE en relación con la movilidad de los trabajadores de salud y la migración en general. - La correspondencia entre las necesidades laborales dentro de la UE y las competencias de los trabajadores de salud extranjeros puede generar resultados positivos para los trabajadores y los sistemas de salud.	Estudio de casos cualitativo descriptivo
Clemens M y Dempster H (19)	2021	Mundial	Posibles buenas prácticas a la hora de diseñar alianzas para la movilidad de los trabajadores de salud	- Los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud bien diseñados pueden facilitar el logro de los objetivos de todas las partes. - El uso de la misma metodología que la OMS utilizó en el 2006 para detectar los países con una “escasez crítica” de trabajadores de salud reduciría el número de países de 57 a 43. Los 47 países de la <i>Lista de la OMS para el apoyo y la salvaguardia del personal de salud</i> del 2020 se han detectado utilizando un método diferente. - Los países de destino deben hacer más para mitigar la escasez de trabajadores de salud en sus sistemas de salud; no es realista depender de la movilidad.	Estudio con métodos mixtos
Abuagla A y Badr E (20)	2016	Sudán-varios países	Aplicación del Código por parte de Sudán y los acuerdos bilaterales	- El Código mejoró la gestión de la movilidad de los trabajadores de salud en Sudán. - Incorporación limitada de la contratación ética en los acuerdos, a menos que el país diseñe y aplique una política nacional sólida. - Ausencia de un marco regional o de un mediador que apoye los esfuerzos de Sudán por firmar acuerdos bilaterales con los países de destino. - Efectos limitados del Código porque no es vinculante.	Estudio de casos cualitativo

Autor principal	Año	Foco geográfico	Tema central del artículo	Conclusiones clave	Tipo de estudio ^a
Adhikari S <i>et al.</i> (21)	2021	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte-Nigeria	Modelo de Global Skill Partnerships para la movilidad de los trabajadores de salud	- Al 2018, Nigeria tenía una escasez de más de 400 000 profesionales de enfermería y el Reino Unido necesitaba más de 100 000 nuevos profesionales de enfermería para el período 2028-2029. - El modelo de Global Skill Partnerships asegura la capacitación de los trabajadores de salud, tanto los que se quedan como los que migran. - La adopción de este enfoque permitiría a los países de destino y origen aumentar el número de trabajadores de salud.	Estudio de casos con métodos mixtos
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Servicio de Colocación Internacional de la Agencia Federal de Empleo (ZAV) (22)	2022	Alemania-Filipinas	Acuerdos bilaterales laborales y movilidad de los trabajadores de salud filipinos	- Alemania y los países de origen colaboran para seleccionar, preparar y colocar a profesionales de enfermería en Alemania. - Se proporciona apoyo y capacitación continuos a los profesionales de enfermería una vez que estén en Alemania. - Sólido historial de colocaciones (4900 al mes de enero del 2022).	Estudio de casos descriptivo
Makulec A (23)	2014	Filipinas-varios países	Acuerdos bilaterales laborales y movilidad de los trabajadores de salud filipinos	- La recopilación de datos será esencial para evaluar los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud y para hacer un seguimiento del desplazamiento de los trabajadores de salud. - Entre el 2002 y el 2006, el Reino Unido contrató a 6124 profesionales de enfermería filipinos, de los cuales solo 175 fueron contratados en virtud del acuerdo entre Filipinas y el Reino Unido. - Se deben adoptar más medidas que se centren en mitigar los efectos negativos en el sistema de salud del país de origen cuando los trabajadores se desplazan a otro país. - Podría considerarse la posibilidad de compensar a los países de origen. - Los acuerdos bilaterales deben incluir el apoyo de otros mecanismos para aumentar las probabilidades de aplicación.	Estudio de casos con métodos mixtos

Autor principal	Año	Foco geográfico	Tema central del artículo	Conclusiones clave	Tipo de estudio ^a
Efendi F <i>et al.</i> (24)	2017	Japón-Indonesia	Movilidad de los trabajadores de salud en virtud del acuerdo de asociación económica de Indonesia-Japón	- La movilidad de los trabajadores de salud requiere políticas locales, nacionales y mundiales adecuadas para una gestión más ética y eficiente. - Entre el 2010 y el 2014, solo el 18% de los trabajadores de salud indonesios ($n = 481$) lograron aprobar el examen de enfermería japonés. - En particular, los gobiernos deben tener en cuenta los intereses de cada trabajador de salud al tiempo que se equilibran las necesidades del personal de salud. - La contratación ética debe ser un principio fundamental de toda renegociación del Acuerdo de Asociación Económica de Indonesia-Japón.	Estudio de casos con métodos mixtos
Efendi F <i>et al.</i> (25)	2016	Japón-Indonesia	Experiencia vivida por los profesionales de enfermería indonesios en Japón en el marco del acuerdo de asociación económica	- Dada la escasez de profesionales de enfermería en Indonesia, tal vez le convenga al país renegociar el arreglo con Japón. - La contratación de personal de enfermería internacional no es más que una solución rápida para los países con escasez de trabajadores de salud. - Los profesionales de enfermería indonesios han señalado que los retos de comunicación y las diferencias culturales son problemáticos.	Estudio de casos cualitativo
Sato F, Hayakawa K, Kamide K (26)	2016	Japón-Indonesia	Investigación sobre la salud mental de los trabajadores de salud indonesios que inmigran a Japón en el marco del acuerdo de asociación económica	- El 22,5% de los participantes del estudio ($n = 71$) consideraron que corrían riesgo de sufrir problemas de salud mental. - Los principales factores que influyeron en el estado de salud mental de los profesionales de enfermería fueron el género y la dificultad para obtener una calificación nacional. - Los profesionales de enfermería indonesios sentían que habían perdido sus competencias debido a las restricciones impuestas por Japón. - Un sistema de apoyo continuo y exhaustivo para los trabajadores inmigrantes indonesios del acuerdo de asociación económica merece consideración.	Estudio de casos con métodos mixtos
Yagi N <i>et al.</i> (27)	2014	Japón-Filipinas	Movilidad de los trabajadores de salud y el acuerdo de asociación económica de Japón-Filipinas	- Las deficiencias del acuerdo han limitado sus efectos positivos en la movilidad y la prestación de asistencia de salud. - En los primeros cuatro años de aplicación del acuerdo, solo el 7% de los trabajadores de salud filipinos pudieron aprobar el examen requerido para la práctica profesional. - El reconocimiento mutuo de las calificaciones, un mayor apoyo financiero y la capacitación de los trabajadores de salud podrían mejorar los resultados.	Estudio de casos con métodos mixtos

Autor principal	Año	Foco geográfico	Tema central del artículo	Conclusiones clave	Tipo de estudio ^a
Takahashi K (28)	2018	Japón-Filipinas	Movilidad de los trabajadores de salud y el acuerdo de asociación económica de Japón-Filipinas	- El acuerdo de asociación económica es una excepción a las estrictas políticas de inmigración japonesas. - El sistema que utiliza Japón para aceptar a los trabajadores de salud filipinos no es eficaz para ninguna de las partes implicadas. - Los efectos de este acuerdo en los trabajadores de salud filipinos fueron negativos, ya que muchos regresan a su país o aceptan trabajos que no utilizan sus competencias. - Si bien el acuerdo era que 200 profesionales de enfermería filipinos y 300 cuidadores fueran a trabajar a Japón anualmente, entre el 2009 y el 2016, el número máximo de llegadas en cualquiera de esos años fue de 93 profesionales de enfermería y 278 cuidadores.	Estudio de casos con métodos mixtos
Kurniati A et al. (29)	2017	Japón-Indonesia	Movilidad de los profesionales de enfermería indonesios en el marco del acuerdo de asociación económica con Japón y su regreso a Indonesia	- Los acuerdos de reconocimiento mutuo apoyan la movilidad, pero no por sí solos. - Los acuerdos de reconocimiento mutuo deben estar en consonancia con las políticas comerciales y de inmigración, y también con las metas normativas, para obtener resultados.	Estudio de casos cualitativo
Yeates N y Pillinger J (30)	2018	Países de la región de Asia y el Pacífico	Examen de las respuestas en materia de políticas internacionales a la migración transfronteriza de trabajadores de salud en la región de Asia y el Pacífico	- Existe una gran variedad entre los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. - Las diferencias de poder entre los países de destino y origen pueden afectar a los resultados. - Es necesario realizar un seguimiento y una evaluación de los acuerdos a lo largo del tiempo, en particular respecto del bienestar de los trabajadores y las necesidades de los países de origen. - Las condiciones de trabajo decentes y el aumento de la protección social deben incluirse en los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.	Estudio cualitativo descriptivo
Gough I (31)	2013	ASEAN	Movilidad y acceso a la atención quirúrgica	- Los acuerdos de reconocimiento mutuo no parecen haber permitido una mayor libertad de desplazamiento para los trabajadores de salud. - Los acuerdos de salud deben negociarse con la implicación de los ministerios de salud. - Un enfoque centrado en el paciente para los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud es primordial.	Estudio cualitativo descriptivo

Autor principal	Año	Foco geográfico	Tema central del artículo	Conclusiones clave	Tipo de estudio ^a
Te V <i>et al.</i> (32)	2018	ASEAN	Acuerdos de reconocimiento mutuo y la movilidad de los profesionales de medicina y enfermería	- Los acuerdos de reconocimiento mutuo apoyan la movilidad, pero no por sí solos. - Los acuerdos de reconocimiento mutuo deben estar en consonancia con las políticas comerciales y de inmigración, y también con las metas normativas, para obtener resultados.	Revisión
Plotnikova E (33)	2014	Reino Unido-varios países	Acuerdos y políticas de movilidad de los trabajadores de salud promulgados por los países europeos	- La adopción de medidas en todos los canales contribuye a asegurar la contratación ética de los trabajadores de salud. - Los acuerdos bilaterales pueden mejorar las relaciones comerciales y empresariales más que los servicios de salud. - Puede ser difícil medir los efectos que políticas como el Código de Prácticas del Reino Unido tienen en el mundo real. - Las agencias de contratación privadas están desempeñando un papel más importante en la movilidad de los trabajadores de salud en comparación con los acuerdos bilaterales laborales.	Estudio cualitativo descriptivo
Weber T y Frenzel H (34)	2014	Reino Unido y Alemania con varios países	Migración circular de los trabajadores de salud	- Los planes de migración circular han fracasado en gran medida en Europa. - Se hace hincapié en la armonización de los acuerdos con el Código de Prácticas del Reino Unido y en asegurar la contratación y la capacitación éticas. - Se ha informado que la pérdida de competencias es un reto para los profesionales de enfermería extranjeros que llegan a trabajar al Reino Unido.	Estudio cualitativo descriptivo
Blacklock C <i>et al.</i> (35)	2012	Reino Unido-Sudáfrica	Políticas del Reino Unido en materia de migración médica	- El Código de Prácticas del Reino Unido no fue eficaz para reducir el número de profesionales de medicina extranjeros que se registran en el Reino Unido. - El número de nuevos profesionales de medicina capacitados en Sudáfrica registrados en el Reino Unido disminuyó de 3206 en el 2003 a cuatro en el 2004. - Entre los retos clave figuran las prioridades gubernamentales que compiten entre sí y la falta de coordinación de políticas. - Los acuerdos bilaterales y las leyes de inmigración parecen haber reducido el desplazamiento de trabajadores de salud hacia el Reino Unido.	Estudio de casos con métodos mixtos

Autor principal	Año	Foco geográfico	Tema central del artículo	Conclusiones clave	Tipo de estudio ^a
De Oliveira APC, Dussault G, Craveiro I (36)	2017	Portugal-varios países	Políticas en Portugal para ampliar el acceso a la atención de salud, incluida la contratación de profesionales de medicina extranjeros	- Las estrategias para mejorar la mala distribución geográfica de los profesionales de medicina incluyeron la contratación de profesionales de medicina extranjeros mediante acuerdos bilaterales. 88 profesionales de medicina de Cuba, 82 de Colombia y nueve de Costa Rica trabajaron en Portugal como resultado del acuerdo bilateral con estos países. - Se necesita más investigación sobre las causas de la mala distribución de los trabajadores de salud en Portugal, y si la contratación de profesionales de medicina extranjeros puede ayudar.	Estudio de casos con métodos mixtos
Glinos IA (37)	2015	Unión Europea	Movilidad de los trabajadores de salud dentro de la UE	- Los arreglos para la movilidad de los trabajadores de salud dentro de la UE pueden mejorar los sistemas de salud, pero se necesita una mayor coordinación. - El riesgo es que los acuerdos beneficien desproporcionadamente a los países más ricos de la UE. - Se necesitan inteligencia y datos sobre el personal de salud, además de apoyo financiero para compensar las repercusiones negativas.	Estudio cualitativo descriptivo
Hammett D (38)	2014	Cuba-Sudáfrica	Apoyo médico cubano a Sudáfrica	- Los profesionales de medicina cubanos se benefician de la experiencia adquirida al trabajar en el extranjero, así como del trabajo que proporciona un incentivo financiero. - Los retos que plantea este arreglo incluyen la insuficiente coordinación para asegurar que la capacitación médica internacional atienda las necesidades del país de origen. - El país de origen puede obtener recursos a cambio del envío de personal.	Estudio de casos cualitativo descriptivo
Asante AD et al. (39)	2012	Cuba-naciones insulares del Pacífico	Cooperación médica cubana con las naciones insulares del Pacífico	- Los arreglos de cooperación médica cubana podrían mejorar los sistemas de salud en las naciones insulares del Pacífico. - Un total de 177 estudiantes de medicina de siete naciones insulares del Pacífico se capacitaron en Cuba; 33 profesionales de medicina cubanos trabajaron en cuatro países. - Deben remediarse los inconvenientes de la movilidad temporal, como las cuestiones presupuestarias y el reconocimiento de calificaciones. - Se necesitan recopilación y evaluación de datos en relación con este y otros acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.	Estudio de casos con métodos mixtos

ASEAN: Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
COVID-19: enfermedad por el coronavirus del 2019
UE: Unión Europea

Nota: Los artículos incluidos son de carácter explicativo y descriptivo; por lo tanto, se consideran evidencia con grado de certeza bajo.

^a Todas las publicaciones (verificadas por homólogos y de bibliografía gris) se clasifican según los métodos utilizados.

En la revisión se encontró una variedad de acuerdos bilaterales de movilidad de los trabajadores de salud entre países. Dependiendo del contexto, el diseño y el propósito de los acuerdos varían, y van desde la respuesta a la escasez de personal de salud, incluso durante las emergencias (1, 18), o la mala distribución hasta la contratación internacional de trabajadores de salud (22); la limitación de la contratación internacional de personal de países concretos (35); el apoyo a la capacitación de estudiantes de medicina internacionales; el fomento de la cooperación (39); y la promoción de objetivos comerciales y económicos (31).

Las publicaciones se centran en gran medida en el diseño de acuerdos para obtener resultados positivos. Sin embargo, hay poca información sobre si estos acuerdos se aplicaron y se les dio seguimiento, y de qué manera se hizo esto. Por ejemplo, un elemento positivo detectado en las publicaciones es el establecimiento de un comité conjunto integrado por representantes de los ministerios de trabajo y salud y de sindicatos, que supervisa la aplicación del acuerdo a lo largo del tiempo (30); sin embargo, falta información sobre las actividades realizadas por dichos comités.

Parece haber un acuerdo general entre la mayoría de los autores de que los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud podrían fomentar la contratación ética y ser mutuamente beneficiosos para los países participantes (19, 33, 38). Sin embargo, los estudios que analizan la efectividad de los acuerdos bilaterales laborales para hacer esto son escasos y, dado el enfoque y la metodología descriptivos, no proporcionan evidencia sólida sobre los productos y efectos atribuibles a los acuerdos.

En las publicaciones se desaconseja tener altas expectativas respecto de los acuerdos bilaterales. Los beneficios previstos de los acuerdos bilaterales pueden ser difíciles de lograr debido a varios factores. En primer lugar, dado que la movilidad internacional es en gran medida una decisión individual, el desplazamiento de los trabajadores de salud en virtud de acuerdos bilaterales puede representar solo una pequeña proporción en comparación con otras vías (5, 33). En segundo lugar, las diferencias de poder entre los países de destino de ingresos altos y los países de origen de ingresos bajos, y el carácter voluntario y no vinculante de instrumentos internacionales como el Código, pueden colocar a los países de destino en una posición ventajosa en la negociación de los acuerdos (20). En tercer lugar, los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud pueden negociarse sin una consulta adecuada con los ministerios de salud, en cuyo caso se puede dar prioridad a las consideraciones políticas y económicas en lugar de dársele a la salud (31). Además, la gestión de las diferencias de los

requisitos regulatorios para la práctica y el trabajo realizados por tipos específicos de trabajadores de salud, la garantía de que las competencias de estos trabajadores capacitados internacionalmente coincidan con las necesidades locales y el manejo de asuntos relativos al idioma, la cultura y las condiciones de trabajo, requiere coordinación y comunicación entre las distintas partes interesadas (32, 38, 39).

Puede ser difícil lograr concertar acuerdos mutuamente beneficiosos que favorezcan a los trabajadores de salud de todas las partes y a los sistemas de salud de los países de origen y destino. La contratación internacional de trabajadores de salud mediante acuerdos gubernamentales puede contribuir a la prestación de servicios de salud en el país de destino, incluso en zonas desatendidas (36). Si bien algunos acuerdos ofrecen incentivos financieros o profesionales para los trabajadores de salud (38, 39), los trabajadores de salud migrantes también han informado sobre la pérdida de competencias y la insatisfacción con las condiciones de trabajo en el país de destino y la dificultad para reintegrarse después de regresar a su país de origen (25, 26, 28, 29, 34).

También hay casos en los que los trabajadores de salud internacionales optan por no desplazarse a países con los que existe un acuerdo gubernamental para la movilidad o no cumplen los requisitos necesarios para entrar a la práctica en el país de destino (27). Además, las diferencias culturales y lingüísticas y las expectativas que no coinciden podrían crear una situación en la que ni los trabajadores de salud ni el país de origen o destino obtienen los beneficios previstos del acuerdo (28). También podría haber resistencia por parte de los trabajadores de salud en los países de destino a aceptar trabajadores de salud extranjeros (32, 39). Las disposiciones que se centran en el bienestar de los trabajadores de salud y las experiencias individuales de estos trabajadores son factores importantes para la retención de los trabajadores de salud migrantes en los países de destino (27, 28, 29).

Varios autores expresan preocupación respecto del beneficio desproporcionado de los acuerdos para el país de destino de mayores ingresos y el efecto en los servicios de salud del país de origen, lo que podría aumentar las inequidades (5, 32, 37). Proponen incluir en el apoyo a la aplicación del acuerdo elementos, como inversiones, metas de contratación seguras o medidas de compensación para mitigar el efecto negativo en el país de origen (23, 37).

Son escasos los ejemplos de países de origen que se benefician de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud (38, 39). Se han propuesto alianzas de competencias para que los países de

origen y destino puedan ampliar de manera sostenible su dotación de trabajadores de salud. El país de destino proporcionaría tecnología y financiación para capacitar a estos trabajadores en el país de origen con competencias específicas, con miras a facilitar el empleo una vez que se desplacen al país de destino. El país de origen impartiría la capacitación, al tiempo que recibe apoyo para capacitar también a los trabajadores de salud que decidan permanecer en el país de origen (21).

Algunos autores destacan los retos que plantea evaluar los efectos de los acuerdos en los sistemas de salud. La recopilación de datos fiables sobre la movilidad de los trabajadores de salud, el seguimiento de los desplazamientos de estos trabajadores y el seguimiento de la aplicación de los acuerdos son necesarios para medir los efectos de los acuerdos (23, 37, 39). El fenómeno de la movilidad de los trabajadores de salud no se presenta de manera aislada. Es difícil que los acuerdos gubernamentales logren los efectos deseados si no se complementan con políticas gubernamentales en materia de salud, inmigración y comercio (32, 35, 36). Si bien el uso de acuerdos bilaterales puede ser una estrategia para subsanar la escasez de trabajadores de salud en un país mediante la contratación internacional, la causa subyacente de estos retos también debe atenderse de manera paralela (19). El seguimiento y la evaluación de los acuerdos bilaterales son necesarios para medir la efectividad en la mejora de los resultados de salud y detectar los problemas clave que requieren atención (30, 39).

Discusión

Las publicaciones disponibles indican que los acuerdos bilaterales y regionales de movilidad de los trabajadores de salud firmados por los gobiernos varían significativamente en cuanto a sus objetivos, forma, contenido y alcance.

Se han utilizado diferentes tipos de acuerdos para facilitar la contratación de trabajadores de salud internacionales con miras a subsanar la escasez de personal; promover la educación y la capacitación de los trabajadores de salud; facilitar la movilidad de estos trabajadores conciliando las diferencias en materia de educación y capacitación, y de reglamentación; aumentar la movilidad regional de los profesionales de la salud como parte de los acuerdos sobre el comercio de servicios; promover la cooperación y el desarrollo en materia de salud; y apoyar la prestación de servicios en zonas desatendidas.

Entre estos objetivos, el debate se centra en gran medida en el uso de acuerdos bilaterales y regionales para atender la contratación y la escasez en los países de destino, y para gestionar mejor la movilidad de los trabajadores de salud. Existe optimismo respecto de

que, si se estructuran correctamente y de manera que reflejen el Código, los acuerdos bilaterales pueden tener efectos positivos en la movilidad, la prestación de servicios de salud y los trabajadores de salud. Con este fin, se han formulado propuestas constructivas y nuevos enfoques para futuros acuerdos, como las alianzas de competencias.

Al mismo tiempo, en esta revisión se encontró una gama de retos en la negociación y ejecución de acuerdos bilaterales y regionales de movilidad de los trabajadores de salud. Por ejemplo, puede ser difícil lograr un arreglo verdaderamente beneficioso para ambas partes, y los países pueden verse ante el reto de asegurar que sus acuerdos sobre la movilidad de estos trabajadores se apliquen en su totalidad. Algunos autores analizan los retos sistémicos, como la forma de compensar el costo que entraña para los sistemas de atención de salud la pérdida de trabajadores de salud, al tiempo que otros se centran en los retos a nivel individual, presentando los tipos de experiencias negativas que pueden tener los trabajadores de salud que se desplazan al extranjero.

Los autores también examinan la necesidad de que haya coordinación para asegurar que las necesidades de atención médica, por un lado, y los servicios y competencias por el otro, sean compatibles; la necesidad de contar con programas para apoyar el éxito de los trabajadores a nivel individual sobre el terreno, incluida la solución de controversias; y la necesidad de regular la movilidad de los trabajadores de salud a través de canales privados y públicos, habida cuenta de las importantes corrientes de trabajadores a través de canales privados de contratación y de la realidad de que dicho desplazamiento no está sujeto a las condiciones de los acuerdos gubernamentales bilaterales.

En esta revisión se encontró evidencia limitada acerca de los beneficios que tienen los acuerdos bilaterales para los sistemas de salud de los países de origen. Múltiples factores pueden contribuir a esto. Ciertos factores se relacionan con las preferencias de los trabajadores de salud a nivel individual, incluidas las razones para desplazarse al extranjero, la elección del país de destino y el canal preferido para el desplazamiento. Otros factores son sistémicos, como los factores de atracción y expulsión que influyen e impulsan la movilidad de los trabajadores de salud. Entre ellos se encuentran las diferencias en materia de ingresos y oportunidades en el extranjero, o incluso la cruda realidad a la que se enfrentan muchos países de origen de que probablemente seguirán perdiendo trabajadores a pesar de haber firmado acuerdos bilaterales para gestionar la movilidad de los trabajadores de salud.

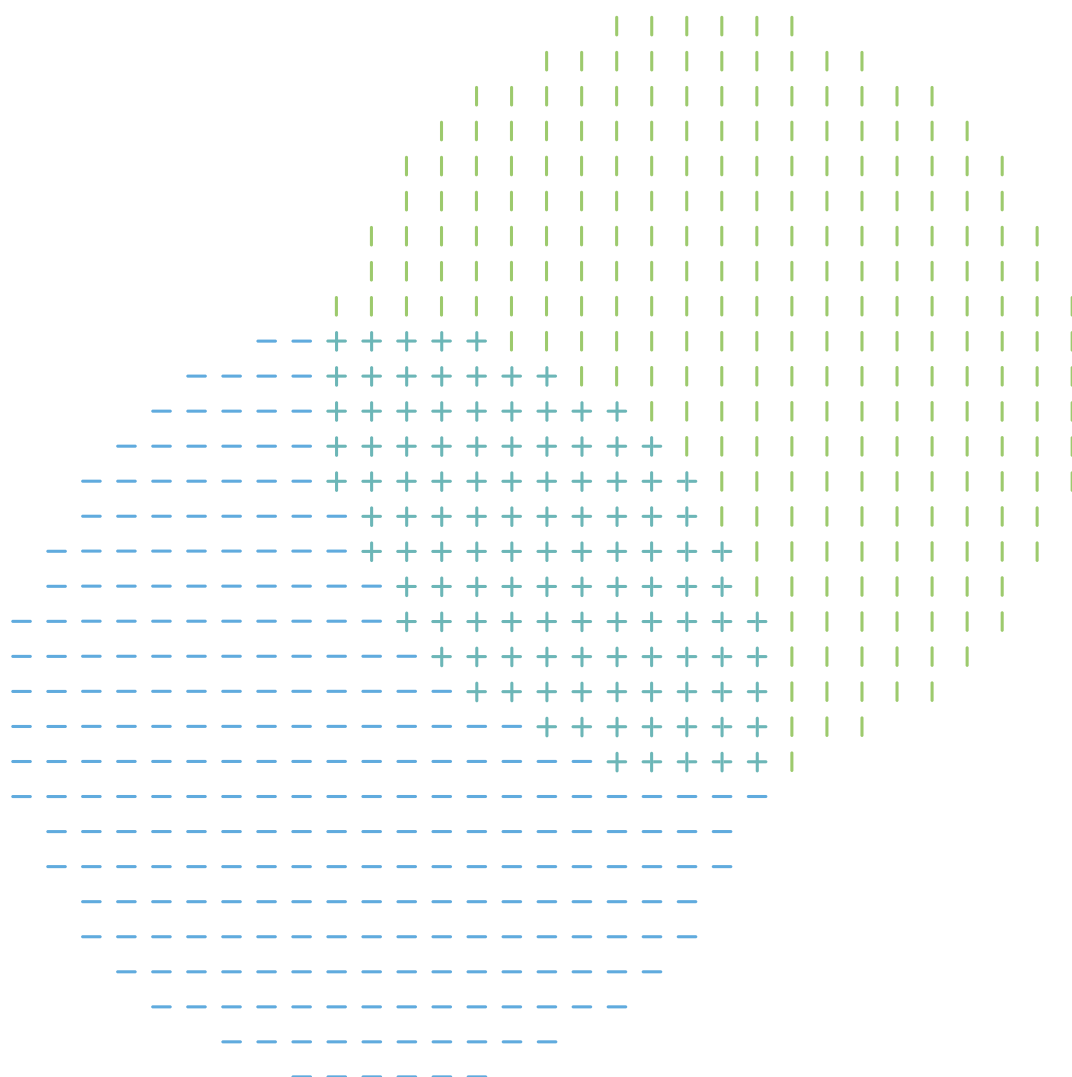
Limitaciones

En la revisión no se encontraron análisis cuantitativos ni evaluaciones formales de esos acuerdos, basados en datos. La falta de evidencia cuantitativa dificulta describir con certeza los efectos de estos acuerdos. Aunque los textos de los acuerdos de algunos países –por ejemplo, Filipinas y el Reino Unido– están a disposición del público, no van acompañados de datos de aplicación ni de informes de evaluación.

En la revisión no se encontró información sobre las actividades de los comités conjuntos mencionados en las publicaciones. Tampoco se encontraron informes de otros organismos oficiales que podrían haber tenido la tarea de dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud o de recopilar datos sobre sus efectos. Es posible que los

comités conjuntos estén haciendo un seguimiento activo de estos acuerdos, pero que su documentación no esté disponible al público. Otra explicación puede ser que los países no estén suficientemente comprometidos con la recopilación y el análisis de datos relativos a los efectos de sus acuerdos bilaterales y regionales de movilidad de estos trabajadores.

Dado lo anterior, no es posible afirmar con certeza qué efectos tienen los acuerdos gubernamentales conocidos sin contar con más información sobre sus antecedentes, contexto, aplicación y evaluación. La investigación primaria podría ayudar a determinar las mejores prácticas, de modo que puedan compartirse entre los Estados Miembros de la OMS y aplicarse a futuros acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.

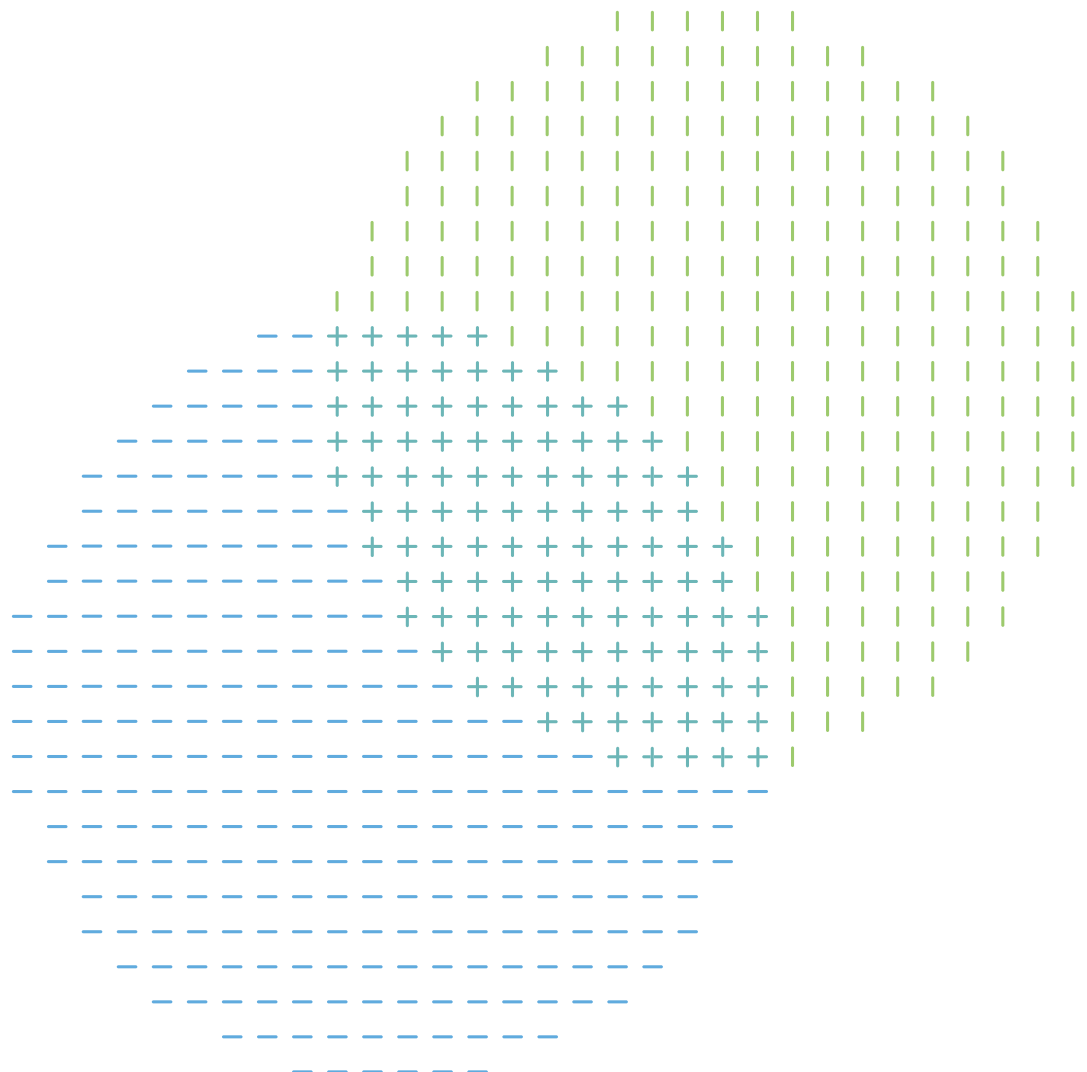


Referencias

1. Fernandez KR. The pandemic as a test case: bilateral labor agreements. En: The global and social consequences of the COVID-19 pandemic. Springer International Publishing (Studies in Global Justice). 2022;1212:331-332 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-97982-9_25, consultado el 22 de febrero del 2023).
2. Code of practice for the international recruitment of health and social care personnel in England (actualizado el 22 de august del 2022). Department of Health & Social Care, GOV.UK; 2022 (<https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-the-international-recruitment-of-health-and-social-care-personnel/code-of-practice-for-the-international-recruitment-of-health-and-social-care-personnel-in-england>, consultado el 22 de febrero del 2023).
3. Dhillon IS, Clark ME, Kapp R. Innovations in cooperation: a guidebook on bilateral agreements to address health worker migration. Washington, D.C.: The Aspen Institute; 2010 (https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/files/content/docs/pubs/Bilateral%20Report_final%20code.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
4. Carzaniga A, Dhillon I, Magdeleine J, Xu L. International health worker mobility and trade in services. WHO-WTO Joint Staff Working Paper. Ginebra: Organización Mundial del Comercio; 2019 (https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201913_e.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).
5. Yakubu K, Durbach A, van Waes A, Mabunda SA, Peiris D, Shanthosh J *et al.* Governance systems for skilled health worker migration, their public value and competing priorities: an interpretive scoping review. Glob Health Action. 2022;15(1):2013600 (<https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2013600>, consultado el 22 de febrero del 2023).
6. Naciones Unidas. Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asamblea General de las Naciones Unidas [documento A/RES/73/195]. Naciones Unidas; 2018 (<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/452/03/pdf/n1845203.pdf>, consultado el 22 de febrero del 2023).
7. Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado) (núm. 97). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1949 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242, consultado el 22 de febrero del 2023).
8. Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisado) (núm. 86). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1949 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312424, consultado el 22 de febrero del 2023).
9. Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) (núm. 143). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1975 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288, consultado el 22 de febrero del 2023).
10. Recomendación sobre los trabajadores migrantes (núm. 151). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1975 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312489, consultado el 22 de febrero del 2023).
11. Principios generales y directrices para la contratación equitativa y Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2019 (<https://www.ilo.org/es/publications/principios-generales-y-directrices-para-la-contratacion-equitativa-y>, consultado el 22 de febrero del 2023).
12. Convenio sobre el personal de enfermería (núm. 149). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1977 (https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312294, consultado el 22 de febrero del 2023).
13. Recomendación sobre el personal de enfermería (núm. 157). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 1977 (https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312495, consultado el 22 de febrero del 2023).
14. Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 2019 (<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373602/PDF/373602eng.pdf.multi.page=31>, consultado el 22 De febrero del 2023).
15. Código de prácticas mundial sobre contratación internacional de personal de salud: tercera ronda de presentación de informes nacionales. En: 72.ª Asamblea Mundial de la Salud [documento A72/23]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328679/A72_23-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=, consultado el 22 de febrero del 2023).
16. Código de prácticas mundial sobre contratación internacional de personal de salud: cuarta ronda de presentación de informes nacionales. En: 75.ª Asamblea Mundial de la Salud [documento A75/14]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_14-sp.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).

17. Cala DC. La Cooperación internacional de Cuba frente a la COVID-19: ampliando la solidaridad. Bol la OPS/OMS en Cuba. 2021;25(1):32-35.
18. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new pact on migration and asylum. Bruselas: Comisión Europea; 2020 (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&format=PDF, consultado el 27 de marzo del 2023).
19. Clemens M y Dempster H. Ethical recruitment of health workers: using bilateral cooperation to fulfill the World Health Organization's Global Code of Practice. CGD Policy Paper 212. Washington, D.C.: Center for Global Development; 2021 (<https://www.cgdev.org/publication/ethical-recruitment-health-workers-using-bilateral-cooperation-fulfill-world-health>, consultado el 22 de febrero del 2023).
20. Abuagla A y Badr E. Challenges to implementation of the WHO Global Code of Practice on International Recruitment of Health Personnel: the case of Sudan. Hum Resour Health. 2016;14(26) (<https://doi.org/10.1186/s12960-016-0117-8>, consultado el 22 de febrero del 2023).
21. Adhikari S, Clemens M, Dempster H, Ekeator NL. A global skill partnership in nursing between Nigeria and the UK. Washington, D.C.: Center for Global Development y Banco Mundial; 2021 (<https://www.cgdev.org/sites/default/files/Global-Skill-Partnership-Nursing-Nigeria-UK.pdf>, consultado el 22 de febrero del 2023).
22. Sustainable recruitment of nurses (Triple Win). Bonn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e International Placement Service of the Federal Employment Agency (ZAV); 2022 (<https://www.giz.de/en/worldwide/41533.html>, consultado el 22 de febrero del 2023).
23. Makulec A. Philippines' bilateral labour arrangements on health-care professional migration: in search of meaning. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2014 (<https://www.ilo.org/publications/philippines-bilateral-labour-arrangements-health-care-professional>, consultado el 22 de febrero del 2023).
24. Efendi F, Mackey TK, Huang M-C, Chen C-M. IJEPa: gray area for health policy and international nurse migration. Nurs Ethics. 2017;24(3):313-328 (<https://doi.org/10.1177/0969733015602052>, consultado el 22 de febrero del 2023).
25. Efendi F, Chen C-M, Nursalam N, Indarwati R, Ulfiana E. Lived experience of Indonesian nurses in Japan: a phenomenological study: Indonesian nurses in Japan. Jpn J Nurs Sci. 2016;13(2):284-293 (<https://doi.org/10.1111/jjns.12108>, consultado el 22 de febrero del 2023).
26. Sato F, Hayakawa K, Kamide K. Investigation of mental health in Indonesian health workers immigrating to Japan under the Economic Partnership Agreement. Nurs Health Sci. 2016;18(3):342-349 (<https://doi.org/10.1111/nhs.12275>, consultado el 22 de febrero del 2023).
27. Yagi N, Mackey TK, Liang BA, Gerlt L. Policy review: Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA) – analysis of a failed nurse migration policy. Int J Nurs Studies. 2014;51(2):243-250 (<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.05.006>, consultado el 22 de febrero del 2023).
28. Takahashi K. Japan's immigration policy and the EPA between the Philippines and Japan. Yamagata University, Faculty of Humanities and Social Sciences; 2018 (<https://www.hs.yamagata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/10TAKAHASHI.pdf>, consultado el 22 de febrero del 2023).
29. Kurniati A, Chen C-M, Efendi F, Ogawa R. A deskilling and challenging journey: the lived experience of Indonesian nurse returnees. Int Nurs Rev. 2017;64(4):494-501 (<https://doi.org/10.1111/inr.12352>, consultado el 22 de febrero del 2023).
30. Yeates N y Pillinger J. International healthcare worker migration in Asia Pacific: international policy responses. Asia Pac Viewp. 2018;59(1):92-106 (<https://doi.org/10.1111/apv.12180>, consultado el 22 de febrero del 2023).
31. Gough I. Surgical competence and mutual recognition in ASEAN countries: editorials. ANZ J Surg. 2013;83(3):99 (<https://doi.org/10.1111/ans.12054>, consultado el 22 de febrero del 2023).
32. Te V, Griffiths R, Law K, Hill PS, Annear PL. The impact of ASEAN economic integration on health worker mobility: a scoping review of the literature. Health Policy Plan. 2018;33(8):957-965 (<https://doi.org/10.1093/heapol/czy071>, consultado el 22 de febrero del 2023).
33. Plotnikova E. The role of bilateral agreements in the regulation of health worker migration. En: Buchan J, Wismar M, Glinos IA, Bremner J (eds). Health professional mobility in a changing Europe: new dynamics, mobile individuals and diverse responses (Vol. II:325-344). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014 (<https://iris.who.int/handle/10665/326372>, consultado el 22 de febrero del 2023).
34. Weber T y Frenzel H. Circular migration of health-care professionals: what do employers in Europe think of it? Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2014 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_335060.pdf, consultado el 22 de febrero del 2023).

35. Blacklock C, Heneghan C, Mant D, Ward AM. Effect of UK policy on medical migration: a time series analysis of physician registration data. *Hum Resour Health*. 2012;10(35) (<https://doi.org/10.1186/1478-4491-10-35>, consultado el 22 de febrero del 2023).
36. De Oliveira APC, Dussault G, Craveiro I. Challenges and strategies to improve the availability and geographic accessibility of physicians in Portugal. *Hum Resour Health*. 2017;15(24) (<https://doi.org/10.1186/s12960-017-0194-3>, consultado el 22 de febrero del 2023).
37. Glinos IA. Health professional mobility in the European Union: exploring the equity and efficiency of free movement. *Health Policy*. 2015;119(12):1529-1536 (<https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.010>, consultado el 22 de febrero del 2023).
38. Hammett D. Physician migration in the Global South between Cuba and South Africa. *Int Migr*. 2014;52(4):41-52 (<https://doi.org/10.1111/imig.12127>, consultado el 22 de febrero del 2023).
39. Asante AD, Negin J, Hall J, Dewdney J, Zwi AB. Analysis of policy implications and challenges of the Cuban health assistance program related to human resources for health in the Pacific. *Hum Resour Health*. 2012;10(10) (<https://doi.org/10.1186/1478-4491-10-10>, consultado el 22 de febrero del 2023).



Anexo 2. Gestión ética de la movilidad internacional de los trabajadores de salud: análisis textual de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Resumen del análisis

Los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud podrían convertirse en una herramienta importante para mejorar el acceso a la atención de salud. Pueden utilizarse para subsanar las brechas de los sistemas de salud, ofrecer oportunidades de capacitación, facilitar el reconocimiento de las calificaciones de los trabajadores de salud extranjeros y asegurar que los trabajadores sean contratados de forma ética y se les ofrezcan condiciones de trabajo adecuadas en el país de destino.

Sobre la base de los más de 150 acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud que se han notificado hasta ahora en el marco del *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud* (“el Código”) desde el 2010, estos acuerdos adoptan muchas formas y reflejan muchos enfoques diferentes. Varían sustancialmente respecto del nivel de detalle de los compromisos, la gestión de la movilidad, la solución y administración de controversias y otros elementos. No existe un modelo único para un acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud.

En este documento los autores describen diferentes acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, a partir de textos presentados a la OMS en el marco del Código. Hacen observaciones iniciales sobre las prácticas que podrían maximizar la contribución de estos acuerdos a la salud pública y al desplazamiento ordenado de los trabajadores de salud a través de las fronteras, y al bienestar de los propios trabajadores.

Los autores recomiendan una mayor transparencia respecto de estos acuerdos y una mayor recopilación de datos, en particular sobre sus efectos una vez aplicados. Sugieren que los ministerios de salud sean participantes, si es que no líderes, en toda negociación de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud para asegurar que estos acuerdos contribuyan a los objetivos más amplios de atención de salud de los países interesados.

Contexto

La movilidad internacional de los trabajadores de salud, que se desplazan de forma permanente o temporal a través de las fronteras nacionales, es cada vez mayor y más compleja. Actualmente, la dependencia sustancial de trabajadores de salud migrantes es evidente en países de distintos grupos de ingresos. También es evidente la demanda cada vez mayor de trabajadores de salud capacitados en el extranjero, lo que es notable en muchos países de ingresos altos (1).

Más que nunca, los trabajadores de salud migrantes aseguran el acceso de la población a los servicios de salud y apoyan las respuestas a las emergencias de salud. Al mismo tiempo, para varios países, la movilidad internacional de los trabajadores de salud puede poner en peligro el logro de estos mismos objetivos.

La necesidad de contar con enfoques que promuevan en la práctica la movilidad ética de los trabajadores de salud internacionales es muy pertinente para los sistemas de salud de todo el mundo. Es especialmente importante en el contexto de la actual pandemia de

COVID-19, como se examinó explícitamente en la 73.^a Asamblea Mundial de la Salud en el 2020 (1).

La urgencia de fortalecer la gobernanza internacional de la movilidad de los trabajadores de salud ha aumentado, tanto dentro como fuera del sector de la salud. De hecho, cada vez se reconoce más que la movilidad internacional de estos trabajadores aporta valor a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el trabajo decente y el crecimiento económico, el desarrollo del capital humano, el comercio internacional y la migración segura, ordenada y regular.

Los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud proporcionan un mecanismo para fortalecer la gestión ética de la movilidad internacional de estos trabajadores. Los gobiernos, cada vez con mayor frecuencia, están negociando este tipo de acuerdos para mejorar la gestión ordenada de la movilidad de los trabajadores de salud a nivel internacional y asegurar su bienestar. Esos acuerdos, ya sea para crear obligaciones jurídicas internacionales o para fomentar un propósito normativo o político más amplio, se están convirtiendo en un pilar de las relaciones internacionales modernas.

Las directrices recientes en materia de políticas en varios países de ingresos altos, incluidos los de la UE y el Reino Unido, apuntan a una intensificación de los acuerdos relativos a la movilidad internacional de los trabajadores de salud.

A modo de ilustración, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE describe explícitamente la sanidad, la atención médica y la agricultura como esferas con escasez de competencias específicas en la UE. La iniciativa Asociaciones para el Talento de la UE, puesta en marcha en junio del 2021, procura reforzar las vías jurídicas y las alianzas internacionales en estas esferas prioritarias para la UE. A principios del 2021, el Reino Unido puso en marcha su enfoque para acelerar la contratación internacional de personal de salud, de conformidad con el Código de la OMS. En la versión actualizada del Código de Prácticas del Reino Unido se definen su intención y su enfoque respecto de la búsqueda de acuerdos mutuamente beneficiosos, en consonancia con las recomendaciones del Código (2). El enfoque del Reino Unido hace explícito que sus acuerdos no exacerbarán la escasez interna y que incluirán apoyo para incrementar la fuerza laboral de salud y fortalecer el sistema de salud del país de origen.

Además, los enfoques nacionales y supranacionales (es decir, de la UE) de los acuerdos sobre la movilidad internacional de los trabajadores de salud están influidos por diversas normas y estándares mundiales. Entre ellos se encuentran el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC y los acuerdos comerciales regionales conexos, los convenios y recomendaciones de la OIT centrados en asegurar los derechos laborales, y normas promulgadas por la UNESCO. Con el aumento de las emergencias de salud y la necesidad asociada de movilidad temporal del personal de salud de emergencia, el papel de las normas y el derecho internacionales humanitarios también es cada vez más importante.

El Código, adoptado por los Estados Miembros de la OMS en el 2010, establece y promueve principios y prácticas para la contratación ética internacional de personal de salud. El Código es la única orientación internacional que se centra específica e integralmente en la movilidad internacional de los trabajadores de salud, ya sea permanente o temporal. Es importante destacar que el Código no prescribe acuerdos sobre la movilidad en el ámbito de la salud. Más bien, proporciona orientación para la elaboración de acuerdos de manera que se puedan asegurar múltiples derechos, incluido el derecho humano a la salud, se puedan obtener beneficios para los sistemas de salud tanto en los países de origen como en los de destino, y se pueda salvaguardar el bienestar de los propios trabajadores de salud.

Además de proporcionar orientación, los informes del Código incluyen la notificación de acuerdos bilaterales relacionados con la movilidad internacional de los trabajadores de salud. Después de tres rondas de presentación de informes nacionales, a partir del 2010, se ha notificado a la OMS la existencia de más de 150 acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Los textos íntegros de algunos de estos acuerdos también se han compartido con la OMS. Además, algunos acuerdos notificados a la OMC, y disponibles en la base de datos del Portal Integrado de Inteligencia Comercial (I-TIP, por su sigla en inglés), también tienen un componente de movilidad de estos trabajadores (3). El análisis de estos textos constituye la base del presente documento (cuadro A2.1).

Cuadro A2.1 Análisis de los acuerdos bilaterales y regionales de migración y movilidad de los trabajadores de salud

Fuentes del texto completo del acuerdo	Número de acuerdos
OMS	31
OMC	7
Total (después de eliminar los duplicados) ^a	37

^a Un acuerdo en el portal de la OMC también estaba disponible en informes sobre la aplicación del Código.

Análisis de la forma y el fondo de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Objetivos, metodología y limitaciones

El objetivo principal de la investigación es informar a los Estados Miembros de la OMS, especialmente a los ministerios de salud y a las partes interesadas competentes, sobre la forma y el fondo de la diversidad de los acuerdos internacionales relacionados con la movilidad de los trabajadores de salud. Al realizar este análisis, buscamos proporcionar una base para la labor futura de la OMS, sus asociados internacionales y otras partes interesadas para fortalecer la gestión ética de la movilidad internacional de los trabajadores de salud, en consonancia con el Código.

En este documento descriptivo se analizan los textos de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, tal como se notifican formalmente a la OMS mediante la presentación de informes en virtud del Código. También incluimos los acuerdos comerciales regionales notificados a la OMC que contienen compromisos en materia de servicios de salud, y hacemos referencia a los compromisos comerciales pertinentes en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC (véanse en el cuadro A2.1 las fuentes de los textos completos de los acuerdos).

Este análisis también utiliza análisis anteriores realizados conjuntamente por la OMC y la OMS respecto del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y los acuerdos comerciales regionales notificados a la OMC.

Los 37 acuerdos examinados para este proyecto de investigación son muy variados en cuanto a sus objetivos, estructura, nivel de detalle, entidades negociadoras, marcos temporales y contexto. Se proporcionaron en diferentes idiomas (español, francés e inglés). Los textos de los acuerdos se evaluaron en función de diversos factores relacionados con el proceso (por ejemplo, ¿participaron los ministerios de salud en las negociaciones?), los efectos individuales

(por ejemplo, ¿qué beneficios se garantizan a los trabajadores de salud en virtud del acuerdo?) y los efectos previstos en los sistemas de atención de salud (por ejemplo, ¿con el acuerdo se mejoró la prestación de atención de salud tanto en el país de origen como en el de destino?). También examinamos la relación entre las disposiciones de cada acuerdo y el Código (por ejemplo, ¿en el texto se menciona el Código?). No tuvimos acceso a ningún dato sobre los efectos de los acuerdos una vez aplicados; no tuvimos acceso a información sobre cómo se elaboraron los acuerdos; y no tuvimos ningún resultado de seguimiento y evaluación formales de los acuerdos. El análisis se basó únicamente en el texto del acuerdo.

Nuestro análisis examina los efectos que podrían preverse de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, de nuevo, a partir de sus textos; sobre, primero, el desplazamiento ordenado de los trabajadores de salud; segundo, el bienestar de los trabajadores de salud que cruzan las fronteras, respecto de sus derechos y condiciones de trabajo; y, tercero, los sistemas de salud de los países implicados.

Si bien pudimos examinar el texto de los 37 acuerdos, la información sobre su contexto y el proceso mediante el cual se negociaron no está disponible al público. Esta es una limitación importante del análisis presentado en este documento. Además, si bien la notificación de los acuerdos en virtud del Código ha mejorado continuamente a lo largo del tiempo, siguen existiendo importantes lagunas en la evidencia sobre los efectos y la ejecución de los acuerdos notificados. Concretamente, varios de los acuerdos examinados son acuerdos marco de alto nivel en los que se establecen intenciones y objetivos, y los detalles programáticos se determinarán más adelante; no tuvimos acceso a información sobre su ejecución.

Hacemos hincapié en la necesidad de que se notifiquen en mayor medida a la OMS no solo los textos íntegros de los acuerdos, sino también información más completa sobre la negociación, la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos una vez en vigor. También señalamos la necesidad de fortalecer la recopilación y el intercambio de datos, en el marco de los acuerdos, entre las partes

y con la OMS, a fin de que las prácticas prometedoras puedan evaluarse y reproducirse de manera más rigurosa en el futuro.

A pesar de estas limitaciones, mediante nuestro examen textual de 37 acuerdos, pudimos establecer una tipología informal de acuerdos relacionados con la movilidad de los trabajadores de salud, detectar prácticas prometedoras y sugerir algunas recomendaciones para el futuro.

Sinopsis de los resultados

Los acuerdos internacionales relacionados con la movilidad de los trabajadores de salud son acuerdos que tienen por objeto apoyar y estimular el desplazamiento transfronterizo del personal de salud. Su objetivo es, en general, subsanar las brechas en los sistemas de atención de salud. Los acuerdos generalmente realizan esto de dos maneras clave:

- subsanar las brechas en competencias y personas en el sistema de atención de salud del país receptor (por ejemplo, cubrir puestos de trabajo, temporales o permanentes, con trabajadores calificados del extranjero); o
- subsanar las brechas en el sistema de atención de salud del país de origen (por ejemplo, capacitación en materia de suministros, educación, innovación, herramientas o tecnologías, apoyo financiero, mejores prácticas de formulación de políticas) mediante la colaboración y la movilidad de las personas físicas.

Ambas estrategias también pueden aplicarse conjuntamente, como se establece en el Código y se reconoce cada vez más en las políticas nacionales y supranacionales (por ejemplo, el Código de Prácticas del Reino Unido, las Asociaciones para el Talento de la UE), así como por parte de los asociados para el desarrollo mundial. En el reciente documento normativo del Center for Global Development, titulado *Ethical recruitment of health workers: using bilateral cooperation to fulfill the World Health Organization's Global Code of Practice* [contratación ética de trabajadores de la salud: uso de la cooperación bilateral para cumplir con el Código de Prácticas Mundial de la Organización Mundial de la Salud], en particular, se destaca cómo se pueden combinar las dos estrategias, centrándose en la puesta en práctica del enfoque de la UE respecto de las Asociaciones para el Talento (4).

Sobre la base de los acuerdos examinados como parte del presente análisis, junto con investigaciones previas de la OMS y la OMC e informes más amplios sobre el Código, podemos observar algunas tendencias emergentes relacionadas con la negociación y ejecución de estos acuerdos:

- Los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud no se limitan a apoyar el desplazamiento de los países de ingresos

bajos y medianos a los países de ingresos altos. La evidencia indica que la movilidad de estos trabajadores, en virtud de los más de 150 acuerdos notificados a la OMS, contribuye a subsanar las brechas en los sistemas de salud a nivel mundial.

- El número de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud notificados a la OMS está aumentando con el tiempo, lo que coincide con la evidencia de un aumento de la movilidad de estos trabajadores, y que indica un aumento de la cooperación por parte de los gobiernos en este ámbito.
- Un logro importante del Código es haber fortalecido la transparencia respecto de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.
- Hay muchos tipos diferentes de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, que se centran en alianzas para la educación, la cooperación en materia de salud, la movilidad laboral o el comercio.
- Las entidades que negociaron los acuerdos eran funcionarios del gobierno federal, así como funcionarios del gobierno regional, que representaban a una variedad de organismos gubernamentales. En general, los negociadores del acuerdo –y si entre ellos había funcionarios del ministerio de salud– dependían del tipo de acuerdo que se celebrara.
- Algunos de los acuerdos más recientes se refieren explícitamente al Código.

Señalamos la importancia de que los ministerios de salud sean, como mínimo, conscientes de los acuerdos que pueden afectar a la prestación de servicios de salud, incluidos los acuerdos que atañen a la movilidad internacional de los trabajadores de salud.

Lo ideal sería que no solo se les informara sobre ellos, sino que desempeñaran un papel activo en la negociación de estos y otros acuerdos que pudieran afectar a la atención de salud. Esto ayuda a asegurar que los acuerdos preserven y mejoren el sistema de salud. Mejor aún, los funcionarios de salud deberían dirigir de manera proactiva y estratégica los esfuerzos para negociar esos acuerdos con otros Estados Miembros de la OMS en el contexto de una estrategia nacional de atención de la salud más amplia, a fin de asegurar la capacitación, las competencias, el personal, los establecimientos y otros elementos necesarios para mejorar la atención de salud. El creciente liderazgo de los ministerios de salud en las conversaciones que antes estaban reservadas para otras partes del gobierno apunta a un papel nuevo y cada vez más importante para los ministerios de salud, lo que la investigación actual respalda.

Descripción de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Para simplificar el proceso de análisis de los diversos textos, clasificamos los 37 acuerdos en siete categorías en función de su tema central general (cuadro A2.2). Incluimos acuerdos en cada categoría sobre la base de un análisis cualitativo de lo que más enfatizaba el texto. Esta categorización está diseñada para facilitar la comparación de los textos de este estudio.

A continuación se presenta una descripción general de nuestros hallazgos, en la que se explican los acuerdos por categoría. Subrayamos que existe alguna superposición en la categorización. Al mismo tiempo, creemos que la propia categorización pone de manifiesto importantes distinciones en los procedimientos y las disposiciones sustanciales de los acuerdos examinados.

Cuadro A2.2 Categorías de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Tema central de los acuerdos: categorías		
1	Acuerdos con énfasis en subsanar las brechas en la fuerza laboral en los países de destino y proteger los derechos de los trabajadores de salud migrantes	12
2	Acuerdos de cooperación en materia de salud	7
3	Acuerdos sobre el comercio de servicios	7
4	Acuerdos para la capacitación a corto plazo de los trabajadores de salud	4
5	Acuerdos para el apoyo filantrópico y técnico	3
6	Acuerdos sobre el reconocimiento de calificaciones	3
7	Acuerdos para establecer programas de capacitación de calidad en el extranjero	1

Categoría 1: Acuerdos con énfasis en subsanar las brechas en la fuerza laboral en los países de destino y proteger los derechos de los trabajadores de salud migrantes

Analizamos 12 acuerdos que se centran específicamente en el trato y la contratación de trabajadores de salud migrantes. Muchos de estos acuerdos establecen marcos, normas y procedimientos para estos procesos, antes y después de la llegada al país de destino. Los acuerdos tienen una serie de títulos, entre ellos “acuerdo general”, “declaración conjunta de intenciones” y “memorando de entendimiento”.

La mayoría de los acuerdos, independientemente de su título, parecen ser equivalentes a tratados. Sin embargo, algunos acuerdos declaran explícitamente que no son jurídicamente vinculantes. Nuestra impresión es que estos acuerdos implican que también se puede contratar a trabajadores de salud extranjeros fuera del acuerdo. Por lo tanto, es posible que los acuerdos proporcionen una reserva de trabajadores superior a la que normalmente existiría, para facilitar la contratación de candidatos calificados del extranjero.

Los acuerdos de esta categoría suelen ser “acuerdos marco” que establecen principios básicos y que deben complementarse con arreglos más específicos elaborados posteriormente. Al respecto, algunos de

los acuerdos piden específicamente la creación de un órgano dedicado a supervisar su ejecución, hacer el seguimiento de sus efectos, proponer modificaciones y otras acciones necesarias para la ejecución del tratado. Se denominan “comités bilaterales conjuntos”, “grupos de trabajo conjuntos” o “comités consultivos conjuntos”. En ninguno de los acuerdos pudimos confirmar que estos órganos se hubieran establecido realmente, y no tuvimos acceso a los registros de las actividades sobre las deliberaciones o decisiones adoptadas por dichos órganos. Además, muchos de los acuerdos no establecen un comité y no está claro cómo se pueden subsanar las deficiencias de esos acuerdos a lo largo del tiempo.

Por lo general, estos acuerdos no implican a los ministerios de salud en sus negociaciones, sino a entidades gubernamentales centradas en el empleo. Algunos ejemplos son la Agencia de Empleo en el Extranjero de Filipinas; la Dirección del Trabajo de Noruega; la Agencia Federal de Empleo de Alemania; el Ministerio de Asuntos de Refugiados, Inmigración e Integración de Dinamarca; el Ministerio de Asuntos Indios de Ultramar de la India; el Ministerio de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos; y la Secretaría de Trabajo y Empleo de Filipinas. Los organismos correspondientes de los países negociadores no se relacionan necesariamente entre sí; por ejemplo, un departamento de trabajo puede negociar con la autoridad del otro país respecto de la capacitación superior y el empleo.

En algunos acuerdos, se asigna explícitamente a los empleadores del sector privado una función definida y, por lo general, estos son responsables de cubrir los gastos de contratación, como las entrevistas en persona o los pagos a las autoridades del país de origen que apoyan la selección y contratación de candidatos. En otros acuerdos, el enfoque exclusivo del acuerdo es la contratación en el sector de la salud pública, o no se mencionan explícitamente las entidades del sector privado. Los organismos de envío se mencionan periódicamente en estos acuerdos.

Estos acuerdos tienden a tener como objetivo explícito subsanar las brechas en el sistema de atención de salud del país receptor, al mismo tiempo que promueven el bienestar de los trabajadores, brindándoles oportunidades de empleo y capacitación y asegurando una remuneración y condiciones de trabajo justas y adecuadas. Varios acuerdos mencionan específicamente la necesidad de traer trabajadores calificados al país receptor para subsanar las brechas. Uno de los acuerdos tiene como objetivo establecer “recursos humanos sostenibles” para la salud. El comunicado de prensa que acompaña a un acuerdo diferente cita la necesidad de hasta un millón de trabajadores en el país receptor en los próximos cinco años. En otro acuerdo se especifica, entre sus objetivos, el establecimiento de un marco a largo plazo para la contratación de profesionales de la salud extranjeros a fin de subsanar las brechas en el sistema nacional de atención de salud (“contratación sostenible”); y en otro acuerdo se hace referencia explícitamente al apoyo del país de origen para atender las competencias relacionadas con la salud y responder a la escasez de personal en los territorios receptores.

Junto con el deseo de crear una contratación sostenible, el bienestar de los trabajadores ocupa un lugar central en los acuerdos de esta categoría. En estos acuerdos se especifican expectativas en cuanto al trato justo y las prácticas de contratación adecuadas para los trabajadores. En algunos de ellos se establecen los procedimientos prácticos que deben seguirse para poner en contacto a los trabajadores calificados con los posibles empleadores y guiar a ambas partes durante todo el proceso de selección de los trabajadores, los procesos de contratación, los trámites administrativos y la firma de un contrato para comenzar a trabajar en el país receptor.

Las protecciones de los trabajadores establecidas en los acuerdos generalmente se centran en el derecho a recibir un contrato por adelantado, condiciones de trabajo justas, incluida una remuneración adecuada, apoyo para entender las condiciones del contrato, apoyo para prepararse a trabajar en el país receptor y oportunidades de capacitación. La recepción y comprensión de un contrato de trabajo antes de ocupar un puesto en el país receptor es una cuestión fundamental que se menciona en varios acuerdos. Por ejemplo, en un acuerdo se establece que lo convenido no solo tratará de facilitar el desplazamiento de los trabajadores, sino que también

brindará ciertas protecciones, en particular un contrato laboral para todos los trabajadores que llegan, verificado y autenticado por el ministerio de trabajo del país receptor, y basado en un contrato estándar que será elaborado por ese ministerio para su uso por parte de los trabajadores de salud extranjeros. Otro acuerdo hace hincapié en la necesidad de que los organismos de envío no solo otorguen contratos de trabajo a los trabajadores por adelantado, sino que también se aseguren de que los trabajadores entiendan las condiciones de empleo en el país receptor. Además, en otros acuerdos se deja claro que los trabajadores de salud procedentes del extranjero deben recibir el mismo salario y las mismas condiciones que los contratados localmente.

Al tiempo que en algunos acuerdos se enumeran principios y algunos reglamentos para la contratación de trabajadores de salud, en otros se establecen procedimientos específicos, estableciendo así un sistema de creación de alianzas. Los tipos de sistemas establecidos son en gran medida los mismos en todos los acuerdos que adoptan este enfoque. Por lo general, dos gobiernos facilitan el contacto entre los organismos de envío o los propios candidatos calificados y los empleadores del sector privado que podrían estar interesados en contratarlos. En algunos acuerdos se prevén procedimientos de trabajo más detallados. Un acuerdo faculta a un organismo público del país receptor a seleccionar a los empleadores autorizados a contratar en virtud del acuerdo, y a un organismo público del país de origen de los trabajadores a seleccionar a los organismos de envío calificados; a partir de entonces, los empleadores del país receptor se comunican directamente con esos organismos. Asimismo, los países receptores pueden comprometerse en los acuerdos a facilitar los trámites de inmigración.

Garantizar las calificaciones de los trabajadores es una parte importante para asegurar que los sistemas de salud de los países receptores se beneficien de la movilidad de los trabajadores de salud. Sin embargo, la confirmación de las calificaciones no es un asunto sencillo, y todos los acuerdos tratan este tema de una manera ligeramente diferente. La mayoría de los acuerdos de esta categoría mencionan al menos la necesidad de asegurar que los trabajadores que llegan estén debidamente calificados. Otros, sin embargo, no mencionan las calificaciones en absoluto. Un acuerdo hace referencia a “trabajadores calificados” a lo largo de todo el acuerdo e incluye un compromiso del país de origen de “preseleccionar” a los candidatos a fin de asegurarse de que estén calificados, pero deja los detalles para más adelante.

Varios acuerdos mencionan requisitos específicos que ayudan a asegurar que los trabajadores que se contratan en el extranjero estén calificados. Entre ellos cabe mencionar: un título o una prueba de calificaciones formales, haber ejercido la profesión durante un número mínimo de años, un certificado de acreditación recientemente expedido y la documentación de viaje adecuada. Varios acuerdos también exigen que los

trabajadores de salud aprueben un examen médico antes de poder trabajar en el país receptor.

Uno de los acuerdos de esta categoría se centra en las calificaciones y tiene el objetivo declarado de proporcionar una base para un eventual acuerdo de reconocimiento mutuo entre los dos países. Esto implica un nivel bastante profundo de armonización.

En algunos acuerdos de esta categoría se alude a la capacitación, en particular en relación con los cursos de idiomas para mejorar las posibilidades de éxito de los trabajadores de salud en el país receptor. A veces también se ofrece formación sobre las condiciones locales del país receptor. Un acuerdo que examinamos establece un período de capacitación durante el cual los profesionales de enfermería extranjeros pueden trabajar hasta un año como auxiliares de enfermería antes de tomar un examen de calificación para ser reconocidos como profesionales de enfermería completamente calificados.

En un acuerdo de esta categoría se refiere a la “colaboración” en la formación profesional, así como en las pruebas y la certificación, pero sin dar más detalles; no pudimos encontrar más información sobre las medidas prácticas adoptadas para cumplir esos compromisos. En otro acuerdo se establece que las partes crearán alianzas entre las instituciones educativas y de atención de salud de los dos países para aumentar la oferta de recursos humanos para la salud competentes, además de elaborar mecanismos para el desarrollo sostenible de los recursos humanos para la salud. Los objetivos de este acuerdo hacen referencia a la necesidad de contar con apoyo para facilitar la reintegración de los trabajadores de salud en el país de origen, presuntamente a fin de asegurar que las competencias adquiridas durante la asignación en el extranjero puedan aplicarse para mejorar el sistema de atención de salud del país de origen mediante la migración circular.

El establecimiento de programas de capacitación en el país de origen está explícitamente previsto en algunos acuerdos. Su objetivo parece ser la creación de sistemas sostenibles para mejorar las competencias de los trabajadores de salud en el país de origen, en general, tal vez para compensar la migración de trabajadores calificados al país receptor. En uno de los acuerdos se prevé que el financiamiento beneficie a programas de capacitación de jóvenes en el país de origen. En virtud de este acuerdo, el sector privado asumiría el compromiso de asignar fondos para este fin. Los compromisos, sin embargo, son imprecisos. Cuando se prevé este tipo de arreglos en los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, los compromisos se establecen generalmente en el lenguaje de los mejores esfuerzos y no como compromisos específicos.

En la mayoría de los casos, en los acuerdos no se examina la forma de mantener el nivel de atención de salud en el país de origen. Esto parece indicar que

los beneficios previstos en esta categoría de acuerdos pueden estar relacionados en gran medida con las oportunidades económicas y de empleo y desarrollo de competencias para los trabajadores que emigran. Es de esperar que, una vez que regresen a su país, esto mejore la base de competencias de los trabajadores de salud, pero el vínculo no es directo. Esto podría depender de las políticas de reintegración del país de origen, que influirían en la medida en que el aprendizaje y la experiencia adquiridos en el extranjero se aplican al regreso del trabajador. En los casos en que no se produciría la migración circular y de retorno, no está claro cómo se beneficiaría el país de origen, aparte de que posiblemente se beneficie mediante las remesas.

En cuanto a los acuerdos financieros, en algunos se imponen tarifas de tramitación para la contratación de trabajadores de salud. Estas son pagaderas por los empleadores o por el gobierno del país receptor tras la contratación satisfactoria de estos trabajadores. Además, algunos países de origen exigen que los empleadores o los gobiernos de los países receptores hagan contribuciones a un fondo nacional en beneficio de los trabajadores.

En cuanto a los elementos administrativos de los tratados, la mayoría de los acuerdos detallan cómo se resolverán las controversias, junto con otras cuestiones. Las controversias que surjan en el marco de los acuerdos se resuelven por lo general mediante negociaciones por vía diplomática y generalmente los acuerdos pueden modificarse o rescindirse mediante comunicación escrita de las partes. No tenemos información sobre si los acuerdos que examinamos fueron modificados, si surgieron controversias o cómo se resolvieron las controversias.

Muchos de los acuerdos se renuevan automáticamente después del período inicial durante el cual están en vigor (que varía entre dos y cinco años), pero algunos deben ser renovados explícitamente por las partes a fin de que sigan en vigor. Hay muy poca información disponible en línea sobre si los acuerdos se han renovado a lo largo del tiempo. Cuando los acuerdos se renuevan automáticamente, esto puede crear seguridad jurídica y, por lo tanto, proporcionar un marco a largo plazo que promueva la seguridad jurídica para los gobiernos, los trabajadores y los empleadores.

La mayoría de los acuerdos de esta categoría no prevén la recopilación, el análisis ni el intercambio de datos sobre la ejecución y los efectos del acuerdo. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, en un acuerdo se refiere explícitamente en sus objetivos a la recopilación e intercambio de información sobre la movilidad de los trabajadores de salud entre los países. En un segundo acuerdo se prevé el intercambio de información sobre asuntos de políticas respecto del desarrollo del personal de atención de salud. En un tercer acuerdo se prevé el intercambio de información sobre los contratos propuestos y firmados, sin perjuicio de ciertas disposiciones que protegen la privacidad de las personas.

El tipo de migración que se prevé en este tipo de acuerdo es generalmente circular, aunque algunos acuerdos prevén explícitamente que los trabajadores soliciten la residencia permanente después de algunos años. Estos son la excepción a la norma. La mayoría de los acuerdos de esta categoría respaldan implícitamente la migración circular y unos cuantos la respaldan explícitamente. Uno de los acuerdos de esta categoría establece la intención del país de origen de ayudar al gobierno del país receptor a apoyar a los trabajadores que se desplazan allí “de forma temporal o permanente”, y elaborar y ejecutar programas que contribuyan a su asentamiento y al éxito final del mercado laboral.

Por último, dos acuerdos establecen arreglos que no están presentes en los otros acuerdos de esta categoría, a saber, una cláusula de transparencia relativa a la intención de una u otra de las partes de negociar un arreglo similar con otro país, disposiciones que exigen el trato de nación más favorecida en caso de que se celebren tales acuerdos con otros países, cláusulas de privacidad relativas al manejo de la información sobre trabajadores a nivel individual, y cláusulas de confidencialidad que sobreviven al propio acuerdo. El trato de nación más favorecida entraña el compromiso de dar a la otra parte el mejor trato dado a terceros países en virtud de otros acuerdos similares; dicho trato es una característica habitual de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales.

Categoría 2: Acuerdos de cooperación en materia de salud

Los acuerdos en la categoría de cooperación en materia de salud para beneficio mutuo generalmente adoptan la forma de acuerdos marco que establecen los objetivos generales de la cooperación entre las partes, además de determinar esferas de cooperación cuyo alcance y número pueden ser amplios. Estos incluyen ámbitos como la capacitación y oportunidades de trabajo temporal, la reforma del sector hospitalario, la cooperación entre hospitales, la investigación y el desarrollo, intervenciones de emergencia, la adquisición de medicamentos y equipo, campañas de vacunación, intercambio de información, entre otros. Se analizó el texto de siete acuerdos de esta categoría.

Se prevé, entonces, que las esferas de cooperación en el marco de los acuerdos se definan y apliquen en mayor medida a través de acuerdos complementarios, por ejemplo, mediante comités establecidos para tales efectos.

Por ejemplo, en un acuerdo de esta categoría se prevé la creación de un grupo de trabajo para desarrollar más los detalles de la cooperación y supervisar la aplicación del memorando de entendimiento. Se especifica que el grupo de trabajo se reunirá en las fechas o a intervalos apropiados que las partes decidan de mutuo acuerdo.

Una característica principal de este tipo de acuerdos es que la cooperación entre las partes debe proporcionar

beneficios mutuos e iguales a ambas partes. Un acuerdo busca establecer una amplia cooperación interministerial e interinstitucional entre ambos países en la esfera de la salud mediante la mancomunación de recursos técnicos, científicos, financieros y humanos con el objetivo final de mejorar la calidad y el alcance de los recursos humanos, materiales y de infraestructura implicados en la atención de salud, la educación y capacitación médicas y la investigación en ambos países. En otro acuerdo de esta categoría se establece un marco para promover, desarrollar e incrementar la cooperación en la esfera de la salud dentro de sus respectivas jurisdicciones explorando las posibilidades de cooperación sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. Otro acuerdo tiene por objeto mejorar las competencias clínicas y técnicas y analizar las mejores prácticas en la prestación de servicios de salud en ambos países.

Dado el enfoque en los beneficios mutuos en este tipo de acuerdos, aunque los arreglos financieros no se tratan en detalle, esperamos que cada parte cubra los gastos relacionados con su participación en las actividades derivadas del acuerdo.

A partir de sus textos, percibimos que los ministerios de salud están implicados como principales órganos de negociación de estos acuerdos, y que la recopilación de datos y el intercambio de información son elementos importantes de cooperación.

También consideramos probable que los acuerdos de esta categoría promuevan la migración circular de los trabajadores de salud. Sin embargo, basando nuestro análisis solo en el texto, no podemos estar seguros.

Respecto de las cuestiones administrativas, la mayoría de los contratos tienen una vida media de cinco años, y tienen cláusulas de terminación que requieren un preaviso por escrito de tres a seis meses. Las disposiciones sobre la solución de controversias se centran en soluciones amistosas, a las que se llega mediante consultas y negociaciones entre las partes a través de canales diplomáticos.

Categoría 3: Acuerdos sobre el comercio de servicios

Examinamos siete acuerdos de esta categoría. El marco del comercio de servicios es un mecanismo importante para la movilidad internacional de los trabajadores de salud. Los acuerdos comerciales regionales son acuerdos negociados entre dos o más países o economías. La función de estos acuerdos en el marco del comercio de servicios es cada vez más destacada, ya que son más fáciles de concertar que las conversaciones multilaterales y pueden dar lugar a disposiciones y compromisos más profundos. Existe una diversidad considerable en la forma y el contenido de los acuerdos comerciales regionales. En un trabajo analítico anterior realizado por la OMS y la OMC se proporciona información valiosa sobre la magnitud y la diversidad de los compromisos o disposiciones relacionados con

la movilidad internacional de los trabajadores de salud, incluidos en los acuerdos comerciales regionales (véase el recuadro A2.1).

Un mensaje clave del examen de los acuerdos sobre el comercio de servicios es que estos son una vía importante para la movilidad internacional de los trabajadores de salud; y los compromisos y disposiciones de los acuerdos comerciales regionales en esta esfera son más numerosos y profundos que los de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Además, los acuerdos comerciales regionales tienen una flexibilidad considerable para fomentar los principios éticos consagrados en el Código (véase el recuadro A2.1).

Categoría 4: Acuerdos para la capacitación a corto plazo de los trabajadores de salud

Examinamos cuatro acuerdos de esta categoría. Estos implican a entidades, por lo general dentro del sistema de salud pública, de los países receptores que imparten capacitación y educación adaptadas a las necesidades de los trabajadores de salud de los países de origen. Si bien los trabajadores de salud que migran a los países receptores también pueden desempeñar otras funciones durante su estancia, se hace hincapié en los programas de capacitación establecidos en el acuerdo.

Los acuerdos de esta categoría suelen aprovechar los mecanismos existentes que ya están establecidos en los países receptores. Proporcionan el marco y los objetivos

globales de la cooperación prevista con terceros países, así como los requisitos y las consideraciones de financiamiento según el nivel de desarrollo del país asociado.

Nos basamos en un acuerdo como el principal estudio de casos que ilustra cómo pueden funcionar los acuerdos de esta categoría. El objetivo declarado del acuerdo en cuestión es permitir que el personal en formación extranjero tenga acceso a experiencias y capacitación clínicas que no puede obtener en su propio país, con miras a aumentar y mejorar la capacitación y el aprendizaje médicos de las personas y, a medio y largo plazo, los servicios de salud en sus propios países.

El acuerdo está explícitamente diseñado de modo que sea mutuamente beneficioso para ambos países. Prevé la contratación temporal de personal médico del país de origen para que trabaje en el sistema de salud del país receptor y reciba una capacitación superior a la que recibiría en su país, beneficiando así a ambos países.

El país de destino se beneficia de los trabajadores de salud calificados, mientras que los profesionales extranjeros se benefician de la capacitación en el empleo, y el sistema de atención de salud del país de origen se beneficia del eventual retorno de profesionales más calificados.

Sobre la base únicamente del texto, este acuerdo se estableció de conformidad con los códigos internacionales sobre contratación, capacitación y educación de los trabajadores de salud, incluido el

Recuadro A2.1 Movilidad internacional de los trabajadores de salud y el comercio de servicios

Se examinaron 95 acuerdos comerciales regionales en la base de datos de servicios del Portal Integrado de Inteligencia Comercial (I-TIP, por su sigla en inglés) de la OMC para buscar compromisos que facilitaran la movilidad internacional temporal de los trabajadores de salud. Algunas de las conclusiones clave incluyen:

- Los compromisos y las disposiciones relativos a la movilidad internacional de los trabajadores de salud son más prominentes y a menudo más firmes en los acuerdos comerciales regionales que en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
- Los acuerdos comerciales regionales pueden limitar y diferenciar el alcance (es decir, respecto de especialistas, tamaño de los establecimientos).
- Algunos acuerdos comerciales regionales incluyen condiciones de concesión de licencias y de reconocimiento de calificaciones.
- Los acuerdos comerciales regionales también pueden especificar limitaciones cuantitativas a la entrada de trabajadores extranjeros sobre la base de pruebas de mercado laboral.
- En algunos acuerdos comerciales regionales se distinguen disposiciones con acceso preferencial a misiones humanitarias o benéficas.
- Algunos acuerdos comerciales regionales proporcionan detalles sobre el proceso de admisión de trabajadores de salud del país de origen, incluidos los requisitos lingüísticos y la capacitación con una institución designada en el país de destino para la preparación para los exámenes a fin de obtener la autorización para ejercer.
- Los acuerdos comerciales regionales pueden incluir asistencia técnica y apoyo financiero al país de origen.

Código. Por lo tanto, el acuerdo parece abordar –o al menos tener en cuenta– la necesidad de mantener el nivel de atención de salud tanto en el país de origen como en el de destino.

Un principio básico del programa de capacitación establecido en virtud de este acuerdo es que no dará lugar a una reducción de la capacidad o la calidad de la capacitación de ningún programa nacional de capacitación para especialistas y que responderá a las necesidades clínicas de los participantes, definidas por el servicio de salud de su país de origen. En ese sentido, los países beneficiarios desempeñan un papel importante en la detección de las brechas y necesidades existentes en sus sistemas de salud, y luego envían al personal en formación al país de destino para que se capaciten con el fin de subsanar esas brechas.

El acuerdo no tiene por objeto que los profesionales de la salud extranjeros se establezcan en el país receptor; de hecho, la migración circular se cita como uno de los objetivos del acuerdo.

El texto del acuerdo no especifica cómo se protegerán el bienestar y los derechos de los trabajadores de salud participantes durante su capacitación en el extranjero. El documento marco se limita a decir que los participantes serán empleados y remunerados directamente por el empleador de servicios de salud competente en el país receptor y de conformidad con las condiciones relativas a esa función. Nuestra impresión es que esto aseguraría la igualdad de trato del personal en formación extranjero y nacional en el marco del mismo programa, incluso si el acuerdo no aborda este asunto directamente. A juzgar por el texto del acuerdo, parece que el personal médico visitante tiene los mismos derechos que el personal médico local.

El acuerdo promueve además la migración ordenada de los trabajadores de salud, prometiendo establecer enlaces, según sea necesario, con las agencias estatales en materia regulatoria, migratoria y de registro médico.

Las calificaciones se abordan en el acuerdo. El país receptor es responsable en última instancia de aceptar a los participantes sobre la base de sus reconocimientos especializados y calificaciones, y de la recomendación del país de origen. En el acuerdo se prevé el reconocimiento por parte del país de origen de la capacitación adquirida en el extranjero, al regreso del profesional de la salud.

El acuerdo no es explícito respecto de las cuestiones administrativas. El período normal del acuerdo, según el texto, parece ser de dos años y la prórroga o renovación no es automática. Sobre la base del análisis textual únicamente, no se prevé ninguna cláusula específica para la modificación del acuerdo, la terminación anticipada o la solución de controversias.

Categoría 5: Acuerdos para el apoyo filantrópico y técnico

Los acuerdos de esta categoría se caracterizan, en términos generales, por el hecho de que una de las partes presta apoyo a la otra en caso de escasez en materia de atención de salud o situaciones de emergencia. Examinamos tres acuerdos de esta categoría.

En algunos casos, los países que proporcionan el apoyo han establecido arreglos para poner a disposición trabajadores de salud y, posiblemente, otros tipos de apoyo en situaciones específicas en las que los países asociados necesitan estos recursos. Por ejemplo, en virtud de un acuerdo, el país que envía trabajadores de salud se compromete a ayudar al país receptor a responder a determinadas necesidades de personal de salud, compartiendo sus experiencias y conocimientos y promoviendo la cooperación con el país beneficiario, al tiempo que facilita contactos significativos entre los jóvenes de los países. Además, algunos países han establecido brigadas médicas con el objetivo de brindar apoyo a los sistemas de salud de otros países con escasez de personal o necesidades específicas.

La relación entre el proveedor y el país beneficiario es, en la mayoría de los casos, muy clara. Por ejemplo, en un acuerdo se afirma que su asistencia técnica y profesional contribuirá a fortalecer más el sistema de salud de su población.

Incluso en los casos en que un país actúa como proveedor y otro como beneficiario, en algunos de ellos el acuerdo se presenta como un acuerdo mutuamente beneficioso. Este es el caso de un acuerdo en el que se afirma que ambas partes se dan cuenta de la necesidad de promover la cooperación sobre la base de beneficios mutuos.

Como se señaló, algunos de estos acuerdos establecen mecanismos preexistentes en el país de origen, con recursos presupuestarios ya asignados o al menos determinados antes de que surjan situaciones de necesidad. Por lo tanto, es probable que los acuerdos mantengan el nivel de atención de salud en los países de origen y, al mismo tiempo, mejoren dicha atención en el país receptor. Estos acuerdos parecen reflejar una evaluación clara de las necesidades de los países receptores.

Estos acuerdos contienen disposiciones bastante específicas sobre temas como salario, alojamiento, gastos de viaje y transporte, atención de salud y gastos de repatriación, entre otros. Dado el carácter cuasifilantrópico de estos acuerdos, normalmente es el país de origen el responsable de los sueldos y subsidios proporcionados a los trabajadores de salud, así como de los gastos de viaje desde el país de origen hasta el país receptor. Por lo general, el país receptor es responsable de proporcionar alojamiento y transporte dentro del país, así como de asegurar la atención de salud del personal de salud visitante.

Un acuerdo establece claramente que el país de origen es responsable del pago de subsidios para la manutención de cada voluntario que presta servicios en el país receptor, mientras que el país receptor es responsable de otras cuestiones, como proporcionar atención médica gratuita a cada voluntario en las instituciones públicas de salud y de pagar subsidios adecuados por turnos y guardias a los profesionales de enfermería y medicina voluntarios, respectivamente, cuando sus servicios se utilicen más allá del horario de 40 horas semanales. Si los servicios se utilizan fuera del horario de 40 horas semanales, el profesional voluntario será remunerado con la misma tarifa que el homólogo local.

Los acuerdos de esta categoría avalan el desplazamiento temporal de trabajadores por un período definido. Se prevé que los trabajadores de salud regresen al país de origen una vez finalizadas sus actividades o al expirar el acuerdo. Al mismo tiempo, en la mayoría de los acuerdos de hecho se prevé la posibilidad de que los trabajadores de salud exploren oportunidades de empleo de carácter más permanente en los países receptores, con ciertas condiciones. En un acuerdo de esta categoría se establece que el país receptor puede ofrecer empleo a cualquiera de los profesionales voluntarios al término de su contratación en virtud del presente acuerdo, siempre que dicho profesional regrese [al país de origen] para cumplir los trámites de desvinculación. Otro acuerdo hace referencia a la posibilidad de que los trabajadores permanezcan en el país, a la espera de la aprobación del país de origen y de que la persona cumpla los requisitos de inmigración del país receptor.

Varios acuerdos de esta categoría abordan explícitamente la facilitación de los procedimientos de inmigración para asegurar que el desplazamiento temporal del personal de salud sea ordenado y de conformidad con las leyes y reglamentos del país receptor. En uno de esos acuerdos, el país receptor asume explícitamente el costo y la tramitación de los visados de entrada, estancia y salida requeridos en los países de tránsito y otros documentos, permisos, aranceles e impuestos de viaje requeridos por la ley. En virtud de otro acuerdo, el país receptor proporciona al profesional voluntario, de forma gratuita, el permiso de trabajo pertinente de dos años que le permitirá trabajar legalmente allí. Entre estos acuerdos, las calificaciones de los trabajadores se analizan de forma sistemática, aunque no en detalle.

Esto puede efectuarse mediante el reconocimiento de las calificaciones de los países de origen como equivalentes a las de los países receptores. En algunos de estos acuerdos, el país de origen es responsable de asegurar que todos los trabajadores de salud enviados al país receptor tengan las calificaciones necesarias para ejercer en las instituciones de salud donde serán colocados. En algunos acuerdos, las calificaciones del país receptor se aplican a los trabajadores

extranjeros sobre la base de los mismos procedimientos administrativos que se aplican a las contrataciones locales. Por ejemplo, en un acuerdo se establece que los profesionales de la salud contratados en virtud de este memorando de entendimiento obtienen el registro necesario requerido antes de prestar cualquier servicio de salud cubierto por dicho memorando; y cumplen las leyes y reglamentos pertinentes.

Entre los objetivos generales de los acuerdos de esta categoría, la capacitación y la educación del personal de salud local se citan con frecuencia como acciones importantes que deben emprenderse para apoyar la mejora de los sistemas de atención de salud en los países receptores. Sin embargo, en los acuerdos no se suelen dar detalles sobre la forma ni el contenido exactos de la capacitación. La mayoría de ellos dejan esto como una acción implícita que ocurre como parte de las actividades del personal de salud mientras está estacionado en el país receptor. En el caso de un acuerdo, el país de origen acepta la capacitación a corto plazo de los profesionales de medicina del país receptor e incluso cubre los gastos correspondientes.

Todos los acuerdos de esta categoría fueron negociados por los ministerios de salud. No está claro si otras partes interesadas participaron en las negociaciones, ya que esto no se menciona explícitamente en el texto de los acuerdos. Suponemos que los organismos de inmigración y aduanas habrían sido al menos consultados sobre los compromisos relacionados con la inmigración, dado que estos se mencionan en algunos acuerdos. También suponemos que se habría consultado con entidades como hospitales y asociaciones que desempeñarían un papel importante en la ejecución de los acuerdos; sin embargo, dado que examinamos solo el texto, no estamos seguros.

Las cuestiones administrativas (renovación, modificación de los acuerdos, solución de controversias) son básicamente las mismas que se señalan en la primera categoría de acuerdos, que se centran en los derechos de los trabajadores.

Categoría 6: Acuerdos sobre el reconocimiento de calificaciones

Evaluamos tres acuerdos destinados a armonizar las políticas regionales o a promover la liberalización del comercio de servicios para la atención de salud. Los acuerdos examinados se celebraron con los auspicios de un bloque comercial regional. Su objetivo principal era fomentar la prestación de servicios de atención de salud por parte de extranjeros, facilitando el reconocimiento mutuo de las calificaciones de los trabajadores. Los acuerdos de reconocimiento mutuo examinados abarcan al personal de enfermería, medicina y odontología. Si bien tratan sobre las calificaciones, en realidad no crean los canales para el desplazamiento de los trabajadores de salud.

Los acuerdos tienen por objeto, cada uno dentro de su esfera de actividad particular (personal de enfermería, medicina, odontología), facilitar la movilidad de los profesionales, intercambiar información y conocimientos especializados sobre normas y calificaciones, y ofrecer oportunidades para el desarrollo de capacidades y la capacitación de los trabajadores de salud. Cada acuerdo establece objetivos de liberalización del comercio desde el principio, como intensificar la cooperación en materia de servicios a fin de mejorar la eficiencia y la competitividad, la diversificación de la capacidad de producción y la oferta y distribución de servicios dentro y fuera de la región; disminuir las restricciones al comercio de servicios, liberalizar el comercio de servicios entre los países de la región. Los acuerdos aplican específicamente el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios para subsanar las brechas relativas a las disciplinas establecidas en ellos.

Si bien los acuerdos son firmados por las autoridades comerciales e industriales, mencionan el papel clave de las autoridades de salud en su aplicación. En los acuerdos se establecen comités conjuntos de coordinación que se encargan de solucionar las controversias de manera amistosa y de subsanar las deficiencias de los acuerdos a medida que estos se aplican. Sobre la base de los textos pertinentes, los comités deben reunirse periódicamente para facilitar la aplicación de los acuerdos, hacer el seguimiento de la aplicación e intercambiar información, examinar programas de creación de capacidades y alentar la adopción y la armonización de normas y procedimientos. La mención en los textos de la “armonización” indica un firme compromiso de promover la movilidad de los trabajadores de salud en el marco de estos acuerdos, al resolver un elemento esencial para el éxito de la movilidad: el reconocimiento de las calificaciones. Los acuerdos tratan sobre parte del marco necesario para la liberalización de la prestación de servicios de salud por parte de personas físicas, y los comités elaboran los detalles posteriormente. No hay información disponible al público sobre el establecimiento, la composición, las actividades y los efectos de dichos comités.

Supusimos que, dado que no había ningún plazo limitado para que los acuerdos siguieran en vigor, estos debían seguir vigentes de manera perpetua hasta que las partes decidieran lo contrario. No está claro en los acuerdos si el desplazamiento previsto es de carácter circular o a largo plazo. Asimismo, en lo que respecta a la administración de los acuerdos, las controversias que no puedan solucionarse de manera amistosa pueden someterse al protocolo regional para su solución dentro del bloque comercial.

Como era de esperar, las calificaciones se tratan con cierto detalle en el marco de estos acuerdos regionales. Los acuerdos individuales establecen los requisitos para categorías específicas de profesionales de la salud, como los de enfermería, medicina y odontología.

En el acuerdo de enfermería se establece que se requiere contar con una licencia válida del país de origen, además de tres años de experiencia laboral, el cumplimiento de los requisitos de desarrollo profesional, un certificado de acreditación, el cumplimiento de otros requisitos del país receptor, como el registro local y un examen médico. El acuerdo establece que los profesionales de enfermería deben poder ejercer en el idioma del país receptor.

En lo relativo al acuerdo de odontología, los profesionales de odontología “extranjeros” (de otros países del bloque comercial regional) deben solicitar el registro. A fin de ser elegible para ejercer en el país receptor, estos deben cumplir con requisitos, que incluyen demostrar una certificación reconocida por el país de origen y el país receptor, haber practicado durante cinco años, poseer un certificado de acreditación del país de origen, tener un registro vigente para ejercer en el país de origen y cumplir con los requisitos de desarrollo profesional continuo del país de origen. Cabe destacar que este acuerdo establece que quienes cumplan los requisitos serán reconocidos como calificados para ejercer la odontología en el país receptor. Se trata de un firme compromiso para facilitar el desplazamiento de trabajadores calificados dentro de la región. El acuerdo de odontología tiene como objetivo explícito el acuerdo de reconocimiento mutuo de las calificaciones a lo largo del tiempo. Este es similar al acuerdo de profesionales médicos, mientras que el acuerdo de enfermería difiere ligeramente, pues tiene un menor grado de compromiso con el reconocimiento mutuo.

Como suele ocurrir con los acuerdos celebrados con los auspicios de la liberalización comercial, estos acuerdos contienen varias excepciones y limitaciones. Por ejemplo, existe la posibilidad de retrasar la aplicación de los acuerdos. Además, contienen una salvaguarda al reconocer explícitamente que las autoridades reguladoras médicas de los países receptores son responsables de la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y el bienestar de la comunidad y, por lo tanto, pueden adoptar decisiones que anulen las disposiciones del acuerdo de armonización. En particular, el acuerdo relativo al desplazamiento de profesionales de odontología hace referencia expresa al “derecho a regular”. Además, los artículos de “exención mutua” del acuerdo de profesionales de odontología permiten a los países receptores imponer requisitos adicionales a los solicitantes de otros países, para asegurarse de que estos estén calificados para ejercer la odontología. El acuerdo de profesionales médicos, relacionado con la movilidad del personal de medicina, menciona específicamente el derecho de las autoridades competentes a registrar a los profesionales extranjeros para que ejerzan, o a negarse a ello.

Categoría 7: Acuerdos para establecer programas de capacitación de calidad en el extranjero

En esta categoría, solo examinamos un acuerdo. El objetivo de este acuerdo es mejorar el sistema educativo de los trabajadores de salud en el país de origen, de modo que esté en consonancia con los requisitos para el empleo en el país receptor, al mismo tiempo que brinda oportunidades de empleo para los trabajadores de salud capacitados del país de origen. Si bien algunos de los acuerdos que hacen hincapié en los derechos laborales, descritos más arriba, se comprometen a impartir capacitación a los trabajadores de salud en el país de origen, esta última categoría de acuerdo hace de este un principio central del arreglo, además de brindar oportunidades de empleo y capacitación en el país receptor para los trabajadores calificados que completen su educación en el país de origen. Al igual que con los acuerdos de migración laboral que subsanan las brechas en la fuerza laboral de salud del país de destino y enfatizan los derechos de los trabajadores, en este acuerdo se establecen disposiciones que protegen los derechos del personal de salud migrante.

Los respectivos ministerios de salud, así como las facultades de medicina y farmacia y otras instituciones educacionales, participan en la negociación y ejecución de este acuerdo, que se renueva automáticamente de forma continua. Este acuerdo prevé el intercambio de datos y análisis. Los arreglos financieros entrañan transferencias en especie y financieras del país receptor, pero estas no se detallan explícitamente en relación con todos los aspectos del acuerdo.

Se trata de un breve acuerdo principal con detalles que se presentan en un anexo, en el que se expone el plan de aplicación durante el período 2015-2022. El texto hace referencia a la estrategia de desarrollo del sistema de salud del país de origen, incluidas las partes relacionadas con la capacitación de recursos humanos. Esto indica que el acuerdo se negoció en el contexto de una estrategia más amplia de prestación de servicios de salud para el país de origen. Este acuerdo se basa en los esfuerzos anteriores del país de origen encaminados a mejorar sus programas de capacitación de trabajadores de salud nacionales, incluso mediante la colaboración con expertos extranjeros.

El acuerdo bilateral se centra en la capacitación de los trabajadores de salud y la gestión de la migración al país receptor; proporciona capacitación en el empleo, lo que también contribuye a una mejor prestación de servicios de salud en ese país. El acuerdo facilita la colaboración entre expertos, docentes, instituciones académicas y hospitales para mejorar la capacitación de los trabajadores de salud en el país de origen. También prevé el intercambio de docentes entre los dos países. En última instancia, el acuerdo tiene como objetivo elevar los niveles de la capacitación preuniversitaria,

universitaria y posuniversitaria en materia de educación para la salud, a fin de armonizarlos con los niveles del país de destino. Esto se hace mediante la aplicación de planes de estudios mejorados (que abarcan tanto la teoría como la práctica) para seis tipos diferentes de calificaciones (enfermería, partería, técnicas de laboratorio, farmacéutica, técnicas de prótesis dentales, enfermería epidemiológica higienista). El país de destino se compromete, en virtud del acuerdo, a contratar a trabajadores de salud calificados del país de origen, específicamente los capacitados en el marco de los programas que se elaborarán como resultado de este acuerdo. Las calificaciones se tratan con cierto detalle en este acuerdo, que parte del supuesto de que la capacitación en el país de origen significa que el trabajador de salud cumple los requisitos de calificación para trabajar en el país de destino. El acuerdo prevé tanto la migración circular como la migración a largo plazo.

Las disposiciones de este acuerdo prevén la contratación en diferentes circunstancias. Una opción es la contratación de profesionales de enfermería que hayan cumplido tres años de trabajo en su país antes de migrar; la educación más tres años de trabajo en una institución médica pública de hospitalización o de prestación de servicios ambulatorios en su país de origen les permite ser considerados para ir al país receptor en virtud de este acuerdo, y no hay cláusula de retorno en esta situación. Además, los recién graduados son elegibles en el futuro para ir al país receptor a fin de recibir capacitación, sin ninguna cláusula de retorno, siempre y cuando se gradúen de una institución en el país de origen y trabajen durante tres años en el sistema público de salud antes de ir al país receptor.

El acuerdo establece varias opciones para la capacitación y la migración, algunas de las cuales exigen el retorno. Por ejemplo, los trabajadores de salud del país de origen que todavía están completando su capacitación pueden recibir formación en el servicio en el país receptor, pero deben regresar a su país después de un período de capacitación determinado.

Algunos de los enfoques establecidos en el acuerdo están explícitamente dirigidos a fortalecer el sistema de salud en el país de origen. Por ejemplo, un programa prevé la emigración con una cláusula de retorno; los graduados calificados de la escuela secundaria pueden obtener capacitación en el extranjero durante tres años, pero deben aceptar regresar a su país para trabajar durante dos años. En el marco de este programa, los institutos de capacitación de trabajadores de salud del país de origen colaboran con los organismos homólogos del país receptor para impartir capacitación inicial en el país de origen a los graduados de la enseñanza secundaria, y el gobierno del país receptor paga cuatro meses de dicha capacitación. El programa incluye capacitación en idiomas. A esto le sigue la oportunidad para que los mejores estudiantes trabajen en el extranjero en el país receptor durante tres años. Si los

estudiantes no son seleccionados tras este programa para recibir una capacitación adicional en el extranjero, pueden continuar su capacitación en su país y pagar el resto de la matrícula.

Parámetros para el análisis

Como se señaló anteriormente, respecto de las descripciones y el análisis presentados en este documento, nos basamos en gran medida en los textos de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud que se proporcionaron a la OMS en virtud del Código. Sobre esta base, tratamos de determinar los objetivos y las necesidades de los países que negocian los acuerdos, así como los efectos probables en sus respectivos sistemas de atención de salud y en los propios trabajadores de salud. Tuvimos poca información sobre las medidas adoptadas para aplicar realmente los acuerdos o sobre los contextos en los que estos se negociaron.

Retos

Nuestro enfoque, por razones obvias, tiene limitaciones sustanciales. Es esencial que nuestra labor de descripción del contenido de los acuerdos se complemente con un análisis de los efectos prácticos de estos acuerdos. Esto requiere una mayor recopilación y evaluación de datos a medida que se aplican los acuerdos.

En particular, fue difícil determinar cómo encajaban los acuerdos en las estrategias más amplias de los países para mejorar sus sistemas de atención de salud. Sencillamente, no tuvimos acceso a la información sobre cómo encajaban los acuerdos en los planes nacionales de salud de los países. Esta consonancia con los planes y estrategias nacionales a más largo plazo es, en nuestra opinión, un factor decisivo para el éxito de esos acuerdos.

Tal vez lo más difícil fue determinar qué país se beneficiaría de cada acuerdo y de qué manera. No tenemos conocimiento de datos públicos disponibles sobre los efectos de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud en los sistemas de atención de salud de los países de origen y destino.

Un elemento de esto podría ser la migración circular, que está implícitamente respaldada por la mayoría de los acuerdos, pero que solo se menciona explícitamente en algunos de ellos. No tuvimos acceso a datos sobre el número de trabajadores que realmente regresan a su país de conformidad con los acuerdos examinados. Supusimos que, en los casos en que se produce la migración circular, esto significaría que el sistema de atención de salud del país de origen se beneficiaría del acuerdo, ya que los trabajadores llevarían a su país competencias y capacitación adicionales. Sin embargo, en realidad el retorno de las competencias al sistema de salud del país de origen es incierto.

Cabe esperar que los trabajadores de salud, como cualquier persona, busquen las mejores oportunidades para ellos y sus familias, y es posible que no regresen a su país en todos los casos. Además, el reasentamiento permanente es posible en virtud de ciertos acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. La cuestión de si la migración circular debe ser la norma en estos acuerdos merece más atención y estudio.

Subrayamos la falta de información disponible al público sobre los acuerdos, incluido respecto de cuestiones administrativas básicas, como si se han establecido comités y si se renovaron los acuerdos. Además de dar a conocer los textos de los acuerdos, para que los Estados Miembros y otras partes interesadas puedan conocerlos mejor, recomendamos que la OMS procure mejorar la presentación de informes y la recopilación de datos en el marco del Código.

Por último, observamos que el género no se aborda directamente en ninguno de los acuerdos examinados. Si bien los textos pueden parecer neutros en cuanto al género, cabe esperar que los acuerdos afecten de manera diferente a hombres y mujeres en el mundo real. Esto se reconoce ampliamente en relación con los acuerdos comerciales, por ejemplo. Los efectos en materia de género de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud merecen especial atención, dado que, dependiendo de la categoría del profesional de la salud, muchos son mujeres.

Prácticas prometedoras

Sobre la base de nuestra evaluación de los textos en relación con las tres esferas mencionadas anteriormente en el documento, pudimos detectar algunas prácticas que podrían ser prometedoras: primero, la contribución a la movilidad ordenada de los trabajadores de salud; segundo, la protección del bienestar de los trabajadores; y, tercero, la preservación o mejora de los sistemas de atención de salud en ambos países.

Para dar más claridad y certeza jurídica, junto con una movilidad ordenada de los trabajadores de salud a largo plazo, sugerimos que las siguientes pueden ser prácticas prometedoras emergentes:

- Ciertos acuerdos contienen disposiciones detalladas que pueden mejorar la seguridad jurídica.
- Algunos acuerdos se renuevan automáticamente, lo que puede mejorar la seguridad jurídica.
- La claridad sobre el tipo de migración, ya sea circular o permanente, puede ayudar a ambos países a integrar el acuerdo en estrategias más amplias de atención de salud.
- Los compromisos explícitos en lugar del discurso de los mejores esfuerzos pueden generar certidumbre y podrían aumentar las posibilidades de que se cumplan las obligaciones.

- Muchos acuerdos establecen un órgano de seguimiento para hacer un seguimiento de los progresos, detectar retos y sugerir formas de solventarlos, como también para respaldar una cooperación más amplia.
- Las iniciativas marco globales existentes pueden servir de base para acordar programas con los distintos países.

Para asegurar los derechos y el bienestar de los trabajadores de salud:

- Algunos acuerdos aseguran que los contratos se adjudiquen por adelantado y proporcionen contratos estándar.
- Algunos acuerdos se comprometen a que haya igualdad de condiciones para los trabajadores de salud extranjeros y nacionales.
- En el país receptor, los trabajadores tienen oportunidades de capacitación, incluida la capacitación en idiomas, en virtud de algunos acuerdos.
- En algunos casos, las entidades del país receptor, y no las personas, deben cubrir el costo de la contratación.
- La claridad sobre los procedimientos de visado y el apoyo que se ofrece para obtener visados o permisos de trabajo son útiles.
- En algunos acuerdos se prevén disposiciones detalladas para la integración en el país receptor, incluido el establecimiento de fondos de bienestar para los trabajadores.

Para asegurar que ambos sistemas de salud se beneficien del acuerdo:

- En algunos acuerdos se describe el fortalecimiento de la colaboración a largo plazo como parte de los acuerdos establecidos.
- Las calificaciones se tratan en detalle en algunos acuerdos, lo que ayuda a asegurar que los trabajadores calificados se integren en el sistema de salud del país receptor.
- Los ministerios de salud participan en la negociación y ejecución de ciertos acuerdos, si no lideran de hecho el proceso, para asegurar la consonancia con las necesidades y los objetivos de salud.
- Las entidades del país receptor, en virtud de algunos acuerdos, deben cubrir los gastos de contratación.
- Los compromisos tangibles de financiar o mejorar la capacitación en el país de origen hacen que sea más probable que se cumplan; estos compromisos son preferibles a los compromisos de “mejores esfuerzos”.
- Algunos acuerdos contienen disposiciones para el seguimiento y la recopilación y el intercambio de datos.

Conclusiones

Hay muchos tipos diferentes de acuerdos que pueden afectar a la movilidad de los trabajadores de salud y, a su vez, los sistemas de atención de salud. Sobre la base del análisis de los textos de los 37 acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud compartidos con la OMS en virtud del Código, junto con otros acuerdos notificados a la OMC, nuestra opinión es que los Estados Miembros pueden utilizar diferentes formatos y tipos de acuerdos para lograr sus objetivos. En otras palabras, no existe un enfoque único que sea el mejor para negociar un acuerdo de movilidad de estos trabajadores.

Lo ideal sería que se autorizara a la OMS a publicar los textos de los acuerdos, junto con los análisis, de modo que los Estados Miembros pudieran disponer de la información que necesitan para aplicar estratégicamente estos acuerdos.

Estos acuerdos parecen estar impulsando la movilidad de los trabajadores de salud en diversas direcciones y para subsanar una variedad de brechas en los sistemas de atención de salud, que van desde las brechas de personal hasta las de competencias, desde las necesidades de innovación hasta el despliegue de nuevas tecnologías, y desde el apoyo filantrópico hasta la creación de nueva infraestructura de atención de salud con la ayuda de expertos externos. De nuevo, no existe ningún formato ideal para estos acuerdos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y la elección idónea dependerá de los objetivos y el contexto de los países negociadores. Cada caso es único.

El Código parece haber influido positivamente en el contenido y la transparencia de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Como se señaló anteriormente, varios de los acuerdos hacen referencia explícita al Código y otros están en consonancia con sus disposiciones y espíritu sin mencionarlo explícitamente. Algunos Estados Miembros de la OMS han sido particularmente activos en la negociación de acuerdos sobre la movilidad de estos trabajadores, y sus experiencias serán valiosas para otros países. Esperamos que en los próximos años los Estados Miembros de la OMS se beneficien de las experiencias de sus homólogos en el uso estratégico de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud para impulsar los sistemas de atención de salud y la capacitación del personal.

Consideramos que las siguientes medidas de la OMS podrían ayudar a aprovechar lo que ya se ha logrado en virtud del Código:

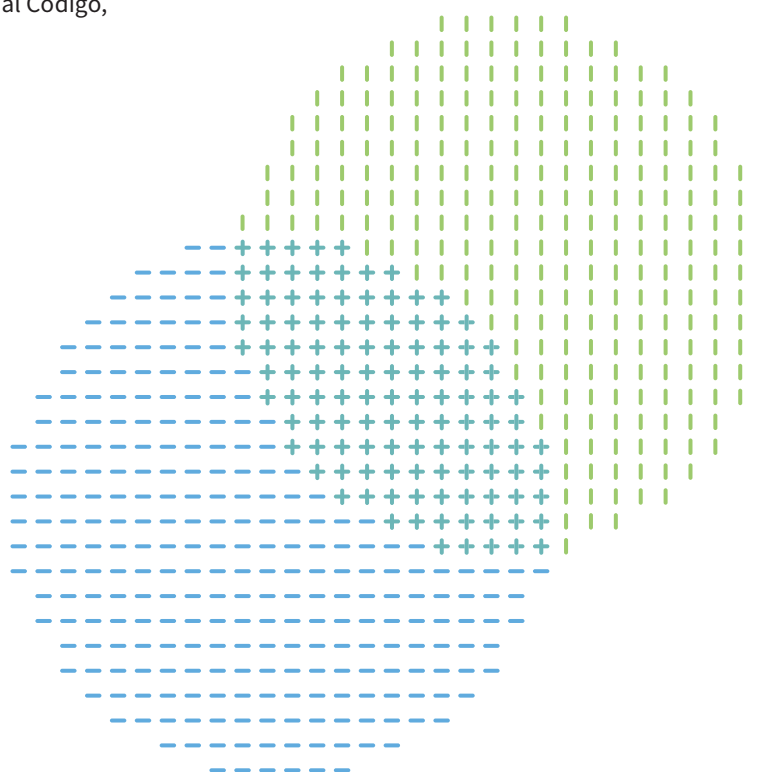
- **Habilitar a los ministerios de salud para que participen en las conversaciones sobre la movilidad de los trabajadores de salud:** nuestra investigación reveló que los ministerios de salud no siempre se implicaron en la negociación y ejecución de los acuerdos que afectaban al sistema de atención de salud y a la fuerza laboral, en particular

de salud. A fin de asegurar que los problemas en materia de salud pública se integren en estos acuerdos, aunque no sean el centro de atención, los ministerios de salud deben estar informados y bien preparados para implicarse. La OMS podría sensibilizar a los ministerios de salud acerca de estos acuerdos, incluidos los concertados con los auspicios de alianzas económicas, y fomentar la capacidad, según proceda.

- **Abogar por el Código:** sugerimos que la OMS siga creando conciencia sobre el Código y las prácticas prometedoras emergentes en relación con su aplicación. En los últimos 10 años, el Código ha contribuido a aumentar considerablemente la transparencia respecto de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Ha alentado la notificación de más de 150 acuerdos regionales y bilaterales que afectan a la movilidad, y la puesta en común de 37 textos completos. Además, hay indicios claros de que los Estados Miembros tienen en cuenta el Código a la hora de definir sus compromisos relativos a la movilidad de los trabajadores de salud; algunos acuerdos incluso hacen referencia directa al Código y a sus principios. A este respecto citamos la reciente decisión del Reino Unido de vincular explícitamente su política de contratación internacional al Código, incluida la *Lista de la OMS para el apoyo y la salvaguardia del personal de salud* del 2020.
- **Mejorar la recopilación y el análisis de datos:** deben fortalecerse la recopilación y el análisis de datos sobre la movilidad de los trabajadores de salud y los acuerdos pertinentes. La OMS podría considerar la posibilidad de elaborar modelos para la presentación de informes con arreglo al Código,

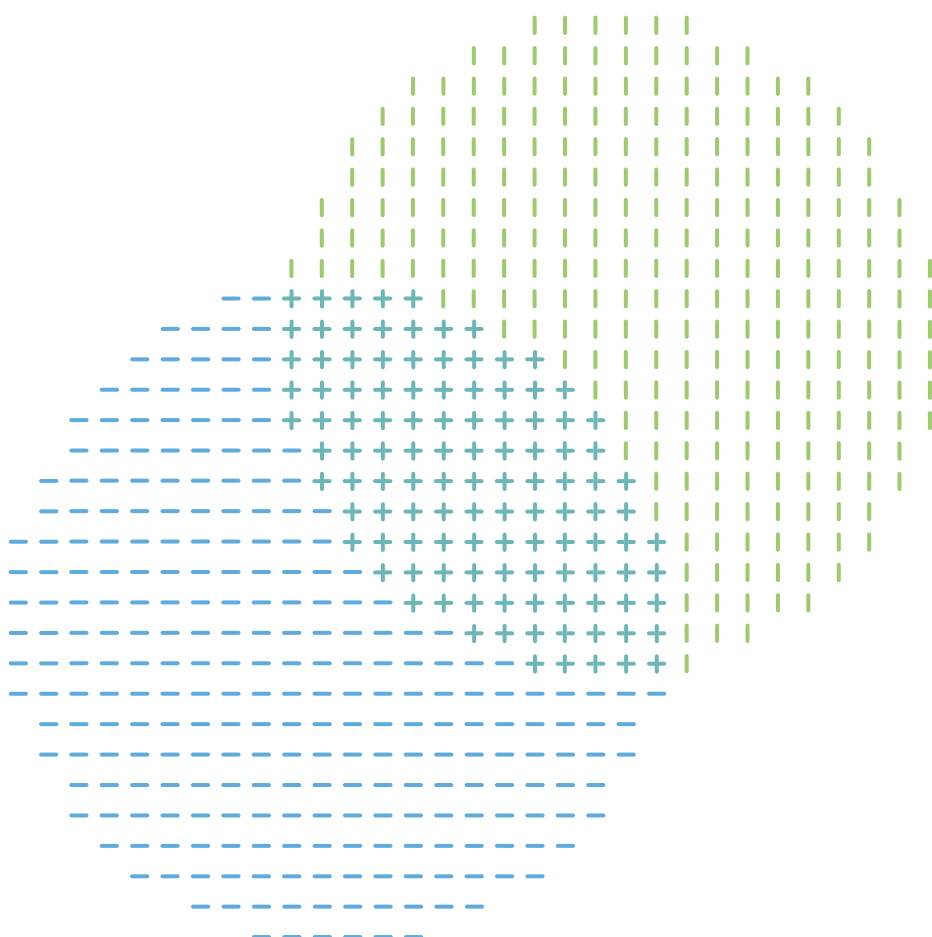
a fin de asegurar que se reúna la información más pertinente sobre los acuerdos existentes, su aplicación y sus efectos a lo largo del tiempo. La OMS debería colaborar con otras organizaciones intergubernamentales y partes interesadas para analizar los efectos de los acuerdos y apoyar a otros (en particular a los Estados Miembros) en el seguimiento de esos efectos. Para aumentar aún más la concientización, sugerimos una serie de estudios de casos que ilustran la experiencia de los Estados Miembros en la planificación, negociación y ejecución de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.

- **Proporcionar asistencia técnica de la OMS:** la OMS podría considerar la posibilidad de apoyar a los países en la negociación de acuerdos que se refieran a la movilidad de los trabajadores de salud. Las orientaciones y las publicaciones pueden ser útiles para promulgar las mejores prácticas. Además, la OMS podría ayudar a los Estados Miembros a determinar cómo encajan los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud en sus estrategias nacionales de salud. Si bien esto puede requerir muchos recursos, respaldamos la creación de capacidades y la asistencia técnica específicas que se llevarán a cabo junto con los asociados.



Referencias

1. Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (documento A73/9). Informe del Grupo consultivo de expertos de la OMS encargado de examinar la pertinencia y eficacia del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, mayo del 2020. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_9-sp.pdf, consultado el 20 de marzo del 2023).
2. United Kingdom Code of Practice for the International Recruitment of Health and Social Care Personnel. GOV.UK; 2022 (<https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-the-international-recruitment-of-health-and-social-care-personnel/code-of-practice-for-the-international-recruitment-of-health-and-social-care-personnel-in-england#agency-list>, consultado el 20 de marzo del 2023).
3. International health worker mobility and trade in services. WHO-WTO Joint Staff Working Paper. Ginebra: Organización Mundial del Comercio; 2019 (https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201913_e.pdf, consultado el 20 de marzo del 2023).
4. Ethical recruitment of health workers: using bilateral cooperation to fulfill the World Health Organization's Global Code of Practice. Center for Global Development policy paper. Washington, D.C.: Center for Global Development; 2021 (<https://www.cgdev.org/publication/ethical-recruitmenthealth-workers-using-bilateral-cooperation-fulfillworld-health>, consultado el 20 de marzo del 2023).



Anexo 3. Entrevistas con partes interesadas clave: acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud

Antecedentes

Como parte de la labor de la OMS para apoyar la implementación del *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud* (“el Código”), esta investigación tuvo como objetivo buscar, describir y estudiar las prácticas prometedoras de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud para contribuir al desplazamiento ordenado de trabajadores de salud, la mejora de los sistemas de atención de salud de los países de origen y destino, y el bienestar de los propios trabajadores de salud.

Se llevó a cabo una serie de entrevistas a fondo con las partes interesadas a fin de comprender el proceso y las prácticas de la negociación, la aplicación y el seguimiento de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud y sus efectos en los sistemas de salud de los países participantes y en el bienestar de dichos trabajadores.

Método

Los interesados que participaron directamente en la elaboración o aplicación de los acuerdos sobre la

movilidad de los trabajadores de salud se seleccionaron inicialmente mediante una pequeña muestra de conveniencia, seguida de un muestreo de bola de nieve.

Se realizó un total de 22 entrevistas con las partes interesadas. Entre los entrevistados había expertos de diferentes entidades públicas de los países de origen y destino, así como de organismos sindicales y consultivos (cuadro A3.1). También se incluyó a trabajadores de salud migrantes.

Las entrevistas se llevaron a cabo entre noviembre del 2021 y enero del 2022 a través de Zoom, con el consentimiento verbal de los participantes de que su identidad permanecería confidencial. Cada entrevista se centró en diferentes aspectos de la negociación y aplicación de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, siguiendo una guía de entrevista, de acuerdo con la experiencia y los antecedentes de las personas entrevistadas.

Se efectuó un análisis de contenido de las notas de la entrevista para estudiar la manera en que surgieron los acuerdos, la consonancia de los textos del acuerdo con la aplicación, y los logros, retos y enseñanzas extraídas durante la aplicación de los acuerdos.

Cuadro A3.1 Entrevistas con las partes interesadas

Región de la OMS	Sector	Sexo	Total de entrevistas con las partes interesadas
África (3)	Salud (incluye salud y comercio) (10)	Mujeres (10)	22
Américas (1)	Relaciones exteriores (1)	Hombres (12)	
Asia Sudoriental (2)	Trabajo (3)		
Europa (5)	Sindicato (1)		
Mediterráneo Oriental (3)	Trabajadores de salud migrantes (3)		
Pacífico Occidental (6)	Órgano consultivo (2)		
Mundial (2)	Regulación (2)		

Resultados

Las entrevistas permitieron detectar ciertos factores que apoyan la negociación de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud que contribuyen al desplazamiento ordenado, la mejora de la atención de salud y el bienestar de los trabajadores, junto con los retos que deben afrontarse. En algunos casos, los factores que han facilitado la negociación de los acuerdos no se pueden reproducir fácilmente (aprovechamiento de las relaciones personales). En otros casos, se pueden determinar y establecer factores de apoyo (un proceso creado para llevar a cabo las negociaciones). Los entrevistados también expresaron sus opiniones sobre la forma en que la OMS puede ayudar a las partes interesadas a intercambiar información y aprender unos de otros.

Esta investigación señaló la importancia de que los ministerios de salud, como mínimo, estén informados respecto de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud e, idealmente, se impliquen en su negociación o la lideren. Esta participación podría ayudar a asegurar que los acuerdos contribuyan a mejorar la atención de salud en todo el mundo, particularmente en los países de origen. En muchas de las entrevistas no quedó claro cómo los países de origen pueden beneficiarse de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, ya que están perdiendo este tipo de trabajadores capacitados que, por lo general, no se prevé que regresen a su país.

Los 22 entrevistados aclararon el proceso de negociación y aplicación de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, lo que contribuyó a una mejor comprensión de lo que había sido posible sobre la base del análisis textual solo. A continuación, se presentan las principales conclusiones clave de las entrevistas en tres grandes temas (contenido y procesos de los acuerdos bilaterales, retos, implicaciones normativas y el papel de la OMS) con algunas citas ilustrativas.

Elaboración de acuerdos bilaterales

La mayoría de los entrevistados confirmaron que los acuerdos que habían negociado y aplicado habían sido respetados de buena fe. Proporcionaron información esencial sobre lo que funciona bien a la hora de poner en marcha y aplicar acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Señalaron una serie de factores que pueden respaldar la elaboración de arreglos sólidos de movilidad de los trabajadores de salud:

- Una evaluación de las necesidades realizada antes de la negociación, respecto de las necesidades del personal de salud y del sistema de atención de salud, puede confirmar la justificación del establecimiento del acuerdo y ayudar a evitar situaciones en las que se contrate a trabajadores de

salud de países donde estos son escasos. Lo ideal es que el análisis se lleve a cabo antes de anunciar las negociaciones.

- La integración del acuerdo en un conjunto más amplio de objetivos, iniciativas o visiones para la relación entre los países puede ayudar a asegurar el apoyo al acuerdo de la movilidad de los trabajadores de salud, así como la consonancia entre el acuerdo y la relación general entre los países negociadores.

“Sabíamos desde el principio cuáles eran los factores sociales, económicos y de otro tipo con los que teníamos que lidiar, y contar con apoyo para afrontarlos fue algo bueno. Además, los contactos y los marcos para interactuar con esos países... los acuerdos sobre salud fueron en realidad una continuación de las relaciones históricas con ellos.”

- El apoyo político de alto nivel al arreglo en ambos países puede ayudar a mantener el impulso a medida que se negocia, aplica e, idealmente, se hace el seguimiento y se evalúa el acuerdo.
- Un marco para gestionar la negociación y la ejecución puede ayudar a asegurar un proceso coherente y eficiente para establecer el acuerdo y luego aplicarlo. Un marco de negociación debe prever la recopilación y el análisis de datos al comienzo del proceso, como se ha mencionado anteriormente.

“Los acuerdos funcionan cuando hay objetivos compartidos, un deseo de trabajar juntos, una visión compartida. Siempre queremos que sean liderados por los países de ingresos más bajos y que provengan de estos países. Que se basen en sus necesidades, no en las nuestras. Cuando el propio país ha expresado esa necesidad o ese deseo de concertar un acuerdo con nosotros, daremos el paso y trabajaremos con ellos. El país debe tener claras sus necesidades para que podamos responder. Necesidad clara, capacidad de apoyo clara, compromiso compartido.”

- Las relaciones personales entre las partes negociadoras se pueden aprovechar para hacer avanzar el proyecto. Este fue el caso en relación con algunos acuerdos examinados. Por razones obvias, no es posible presentar esto como algo que se pueda reproducir a propósito. Sin embargo, varios entrevistados mencionaron esto como un elemento facilitador.
- La implicación comprometida de personas concretas que dedican tiempo y esfuerzos para hacer realidad el arreglo sobre la movilidad de los trabajadores de salud puede marcar una diferencia significativa en el avance de las negociaciones. Al mismo tiempo, no es sostenible que estos esfuerzos dependan de personas extraordinariamente comprometidas. Un esfuerzo de equipo puede proporcionar más sostenibilidad.

- Las consultas intergubernamentales pueden ayudar a generar posiciones coherentes para cada país negociador (en materia de salud, industria, trabajo, comercio, relaciones exteriores). Muchos entrevistados subrayaron la importancia de los procesos interinstitucionales para recabar aportaciones y asegurar que los acuerdos reflejaran las prioridades de los diferentes organismos, en la medida de lo posible.
 - Muchos entrevistados también señalaron que la amplia participación de las partes interesadas era esencial para elaborar un acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud (organismos profesionales, empleadores, organizaciones no gubernamentales, trabajadores locales y organismos públicos). Se reconoció que las consultas con todas las partes interesadas competentes fortalecían no solo el acuerdo, sino también el apoyo a su aplicación a lo largo del tiempo.
 - Las medidas para abordar los elementos humanos de la movilidad de los trabajadores de salud deben priorizarse adecuadamente. Con la expresión “elemento humano”, los entrevistados se referían a aspectos como asegurar que los trabajadores migrantes se sintieran en su casa en el país de destino, que pudieran interactuar con otros de su propio país y tener un sentido de comunidad, y que recibieran apoyo para aprender el idioma y las costumbres locales, etc.
 - Es importante realizar una gestión adecuada del reconocimiento de las calificaciones para asegurar que las oportunidades disponibles para los trabajadores migrantes se ajusten a su experiencia y capacitación. Varios entrevistados señalaron que el reconocimiento y la gestión de las calificaciones eran una condición necesaria, pero no suficiente, para un arreglo satisfactorio sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Lo ideal sería que los dos países compararan sus sistemas de educación y capacitación respecto de las categorías de trabajadores de salud, describieran las diferencias y propusieran formas de compensar esas diferencias para facilitar el desplazamiento.
 - Algunos declararon que prever y manejar de forma eficaz las preocupaciones de los grupos que podrían oponerse al acuerdo era una forma importante de allanar el camino hacia un arreglo satisfactorio sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Por ejemplo, el personal médico local puede considerar que el personal médico migrante está menos capacitado debido a las diferencias en la educación y la capacitación de su país de origen. El manejo de esta situación puede ayudar a asegurar una buena experiencia para el personal médico migrante y mejorar los resultados del acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud.
 - Se hizo hincapié en que los expertos en salud pública, particularmente los expertos en sistemas de salud, deben estar presentes en la mesa de negociaciones de cada país, para estimar los efectos de las diferentes propuestas en los sistemas de salud y los trabajadores.
 - Un mecanismo para que las partes consulten, actualicen el acuerdo y subsanen de alguna manera las deficiencias a medida que se aplica el acuerdo puede ayudar a velar por que el acuerdo se actualice según sea necesario, a fin de asegurar que siga respondiendo a las necesidades de todas las partes. Los entrevistados mencionaron como práctica positiva tener comités conjuntos que celebran reuniones anualmente, precedidas de debates interinstitucionales sobre los acuerdos y su desempeño, para hacer aportaciones a la reunión del comité conjunto.
 - Un plan detallado para la ejecución y gestión del acuerdo, elaborado a lo largo del tiempo y que refleje la experiencia y el contexto del mundo real, puede ayudar a asegurar que el acuerdo se aplique de manera que sea congruente con los objetivos e intenciones de las partes que lo negociaron.
 - La flexibilidad para ajustar el acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud a lo largo del tiempo puede ayudar a que este sea un acuerdo vivo y adaptable a las circunstancias y necesidades cambiantes.
 - La recopilación de datos y la evaluación del desempeño del acuerdo son importantes para que ambas partes comprendan los efectos del acuerdo en los sistemas de atención de salud, la migración y el bienestar de los trabajadores, de modo que puedan ajustar el acuerdo o el enfoque según sea necesario.
- “De hecho, analizamos, junto con el país asociado, el mercado laboral en el país de origen, pero nos basamos en los datos que se nos proporcionan. Esto significa que no podemos garantizar un análisis completo de los efectos en el país asociado. Los datos son muy diferentes de un país a otro.”*
- Las inversiones en capacitación relativa a la atención de salud u otro tipo de compensación para el país de origen pueden ayudar a asegurar que la movilidad de los trabajadores no socave los sistemas de atención de salud de los países de origen. Una idea que surgió durante las entrevistas fue que los países de destino aceptaran solo a los recién graduados y luego invirtieran en su capacitación adicional una vez que el trabajador llegara al país de destino; esto podría ayudar a evitar la salida de trabajadores de salud más expertos, al tiempo que disminuye el riesgo de que los programas de capacitación establecidos por los países de destino en los países de origen no cuenten con fondos suficientes.

Retos

Los entrevistados también plantearon retos y problemas que debían atenderse para que los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud brindaran los máximos beneficios para los países de origen y destino, y para los trabajadores.

Algo que no quedó claro en las entrevistas fue cómo se preservaba y mejoraba el sistema de atención de salud en el país de origen como resultado del arreglo. Este y otros retos deben analizarse y se deben encontrar soluciones posibles para que los países que participan en negociaciones o en la aplicación de los acuerdos existentes las consideren.

- Debido a que es “demasiado pronto”, gran parte de la negociación y ejecución de estos acuerdos implica un aprendizaje práctico. Uno de los entrevistados señaló que “no existe un manual” para que los acuerdos y su ejecución sean idóneos.
- A veces, la política puede reemplazar el proceso de negociación habitual, al tomarse atajos en los procesos habituales y posiblemente socavando con ello el acuerdo resultante. Cuando los apretones de manos entre los líderes políticos dan como resultado un compromiso para negociar un acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud antes de que se pueda llevar a cabo el análisis necesario del mercado laboral y del sistema de atención de salud, el acuerdo al que se ha llegado puede ser subóptimo.
- Cuando el avance de las conversaciones sobre la movilidad de los trabajadores de salud se basa en el compromiso o las relaciones personales, puede ser difícil mantener la gestión del arreglo sobre la movilidad de estos trabajadores. Del mismo modo, no es factible esperar que se genere esta dinámica en todas las situaciones.
- Ampliar la aplicación de los acuerdos para lograr el máximo efecto positivo puede ser un reto. Se observó que un acuerdo de capacitación circular puede no ser suficiente para remediar la salida masiva de trabajadores de salud de un país determinado. Además, se señaló que un acuerdo para capacitar a una docena de profesionales de medicina y luego devolverlos a su país de origen para que ejerzan su profesión, si bien es sin duda un esfuerzo prometedor, puede que no mejore significativamente el sistema de atención de salud del país de origen, en especial si no se exige que estos profesionales permanezcan en el país de origen o si hay salidas de un número mucho mayor de dichos profesionales.
- Cabe suponer que sean negativas las repercusiones en los sistemas de atención de salud de los países en los que muchos trabajadores de salud se desplazan al extranjero, ya sea en virtud de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud u otros canales. Algunos entrevistados se preguntaron si las remesas u otras prestaciones podían compensar los posibles efectos negativos que tenían las salidas de trabajadores de salud en los países de origen. Ninguno de los entrevistados tuvo una respuesta definitiva sobre cómo se podría aprovechar la movilidad de estos trabajadores en el extranjero para mejorar el sistema de salud en el país de origen.

“Hay una pandemia, pero también tenemos escasez de personal de enfermería. Por lo tanto, el país receptor obtiene algo, pero el país de origen pierde algo. Nuestro sistema de salud se ve afectado negativamente.”

“Habíamos invertido en la capacitación de estas personas y básicamente nos las robaron, las ‘reclutaron’; debería haber algún tipo de apoyo como mínimo para nosotros y para recuperar el dinero que gastamos en la capacitación. Pero nadie lo proporcionó. Cuando hablamos con los países de destino sobre esto, nos dicen ‘tenemos buenos salarios, así que la gente de su país viene y está bien aquí’. Si no es la gente de su país la que viene, vendrá de otros lugares.”

- A menudo no hay evaluaciones de necesidades, principios rectores ni objetivos que acompañen a la negociación de un acuerdo. Esta falta de datos puede dificultar la orientación adecuada del acuerdo para asegurar que se evite producir efectos negativos en los sistemas de atención de salud.
- Son muchos los elementos que deben trabajar de consuno para crear un acuerdo sólido sobre la movilidad de los trabajadores de salud; negociar un acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud que funcione bien es una tarea compleja. Por ejemplo, un buen acuerdo de reconocimiento mutuo puede facilitar las corrientes de trabajadores de salud, pero por sí solo no puede crear espacio para la inmigración y la colocación reales. Para ello también es necesario el compromiso de recibir a estos trabajadores y crear las condiciones adecuadas para que puedan obtener un empleo.
- Las percepciones acerca de los trabajadores extranjeros pueden necesitar una gestión a nivel nacional, a fin de asegurar que sus calificaciones sean reconocidas y respetadas adecuadamente, y esto puede ser difícil.
- Se deben gestionar diferentes conjuntos de intereses en todos los organismos públicos y grupos de partes interesadas, y en un contexto global. Según algunos de los entrevistados, recopilar y sopesar adecuadamente las aportaciones de las partes interesadas, e integrarlas en las negociaciones, puede ser un proceso complejo y lento. También puede requerir el establecimiento de nuevos canales para la colaboración con grupos de partes interesadas.
- Los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud se refieren a personas, por lo que los países deben tener en cuenta esa realidad a la hora de establecer acuerdos sobre la movilidad de estos

trabajadores. A veces esto se pasa por alto. Un entrevistado subrayó que “los trabajadores de salud no son mercancía”.

- Tiende a haber una falta de perspectiva de género en estos acuerdos, a pesar de que los servicios de atención de salud pueden ser una esfera de la prestación de servicios fuertemente basada en el género. Los entrevistados señalaron que el análisis de cuestiones como la desigualdad de la remuneración entre hombres y mujeres, la licencia de maternidad y la reunificación familiar podrían ayudar a asegurar que los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud se estructuren de manera que los hombres y las mujeres puedan beneficiarse por igual.
- Los entrevistados mencionaron la necesidad de recopilar datos y evaluar el desempeño de los acuerdos a lo largo del tiempo. La mayoría de los países no registran el número de trabajadores de salud que se desplazan al extranjero, y es posible que pierdan el rastro de sus desplazamientos a lo largo del tiempo. En este momento, los países no realizan evaluaciones de los efectos que tienen los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud en la prestación y los sistemas de atención de salud.

“La evaluación de estos acuerdos plantea un gran reto. ¿Qué ha ocurrido? y ¿podemos comunicarlo? ¿Cuántos vinieron, dónde se capacitaron, cuáles fueron los efectos en su experiencia a nivel individual, se marcharon o se quedaron? Pero, ¿es realista esperar que se pueda hacer un seguimiento de estas personas durante muchos años? Además, ¿cómo se miden a lo largo del tiempo los efectos transformadores en los sistemas de salud de los países implicados? No creo que realmente podamos evaluar eso.”

- La migración circular no es factible ni razonable en todos los casos, por diferentes razones. Esto puede influir en los efectos que tienen los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud en los sistemas de atención de salud, especialmente en los países de origen que pierden trabajadores calificados. Esto podría compensarse facilitando el desplazamiento al extranjero solo para los recién graduados.

“Si yo pudiera cambiar algo, sería que solo contrataran a profesionales de enfermería recién licenciados. Actualmente se están llevando a profesionales de enfermería capacitados y experimentados. Debemos capacitar constantemente al nuevo personal y esto afecta a la calidad de la atención. Solo porque somos un país más pobre, ¿deberíamos asumir esta carga adicional de volver a capacitar constantemente a nuestro personal y, también, que nuestra gente sea atendida por profesionales de enfermería menos experimentados?”

- Algunos entrevistados señalaron que puede ser difícil para los trabajadores de salud migrantes integrar en su trabajo a su regreso el aprendizaje obtenido durante su permanencia en el extranjero. Esto puede deberse a la resistencia por parte de los colegas a cambiar la forma en que siempre se han hecho las cosas, a la falta de equipo o de procesos pertinentes, o a otros factores.
- Algunos entrevistados afirmaron que puede ser difícil evaluar los efectos de los acuerdos en los sistemas de atención de salud y en el bienestar de los trabajadores, lo que apunta a la necesidad de disponer de criterios y metodologías para la evaluación. En este momento, ninguna organización parece estar elaborando esas metodologías.
- Compartir información sobre experiencias y aprendizajes positivos y negativos es difícil porque actualmente no existe ninguna plataforma para ello, y tal vez la OMS pueda ayudar al respecto. Muchos expresaron interés en aprender de los funcionarios de los países que desde hace mucho tiempo han contado con arreglos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.

“No se puede simplemente buscar en Google estos acuerdos relativos a los trabajadores de salud, ni las experiencias ni el aprendizaje asociados a ellos. Ni siquiera se puede encontrar el texto de los acuerdos. Cuando nuestro gobierno se interesó en concertar un acuerdo bilateral, fue difícil conseguir información para prepararnos y comenzar. Por lo que recurrí a mis relaciones personales.”

- Algunos entrevistados señalaron que el Código no es vinculante y que tal vez se justificarían los esfuerzos por avanzar en ese sentido.

Implicaciones normativas y papel de la OMS

La mayoría de los entrevistados observaron que las orientaciones de la OMS sobre cómo preparar, negociar y aplicar de manera óptima los diferentes tipos de acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud podrían ser útiles para los Estados Miembros. Los entrevistados formularon sugerencias sobre qué tipo de plataforma u otra iniciativa podría ser más útil respecto de permitir el intercambio de ideas y experiencias, incluido lo siguiente:

- Se consideró que el primer paso necesario era que la OMS estableciera un repositorio de textos y otro tipo de documentación. Los entrevistados describieron esto como algo “fácil” de hacer, pero no tan útil por sí solo.
- Un repositorio con información detallada o asesoramiento sobre los pasos a seguir en la etapa previa a la negociación, la de negociación y la posterior a la negociación podría brindar

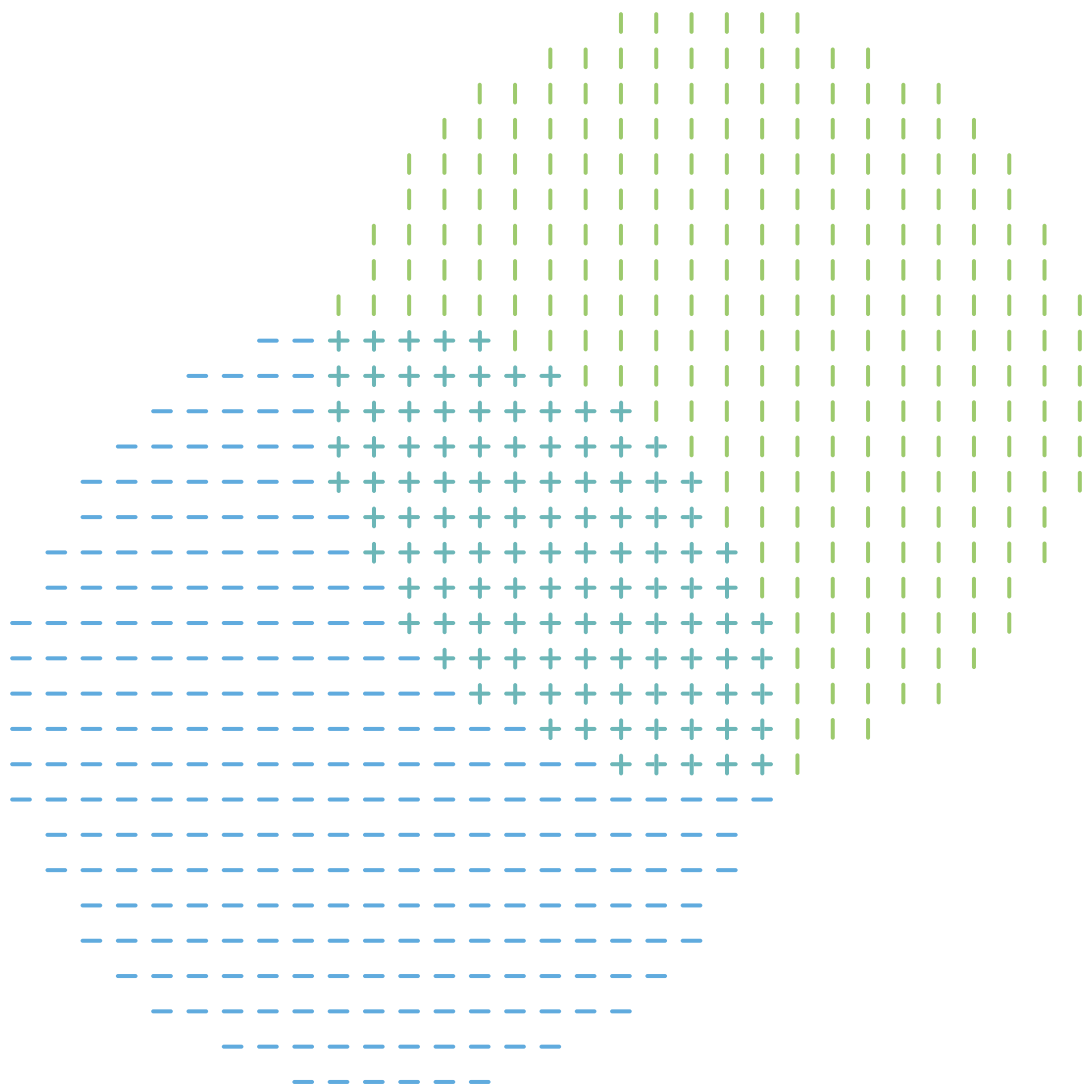
- información útil para los Estados Miembros de la OMS. El repositorio podría incluir textos de acuerdos, junto con estudios de casos sobre cómo se negociaron y aplicaron esos acuerdos. Eventualmente, podría contener información sobre metodologías para evaluar los efectos de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud en los sistemas de atención de salud, en el desplazamiento de estos trabajadores y en su bienestar.
- La mayoría de los entrevistados consideraron útil la creación de una comunidad de práctica –una comunidad de vida o una red con participación regular–. Muchos señalaron que la OMS debería asumir la función de posibilitar esas interacciones.
 - También se dio prioridad a los intercambios periódicos entre los Estados Miembros sobre sus experiencias y acuerdos, a fin de poder formular preguntas y obtener información más detallada. Muchos entrevistados señalaron que la OMS debería crear oportunidades para este tipo de participación.
 - Se consideró importante que se presentaran más informes sobre los textos a la OMS, a fin de ampliar los conocimientos relativos a los acuerdos y la transparencia.
 - También se consideró importante que se presentaran más datos e información sobre la aplicación de los acuerdos, ya que hay poca información disponible al público sobre lo sucedido después de las negociaciones. En este sentido, recaería en los países la responsabilidad de presentar información que abarque algo más que el texto de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, con el estímulo y el apoyo de la OMS.
 - Se consideró que faltaba un análisis sobre los efectos de los acuerdos en los trabajadores y la atención de salud –una verdadera evaluación– y, en este caso, los entrevistados vieron un papel claro para la OMS en la labor con expertos en el desarrollo y el fomento de la sensibilización sobre metodologías para realizar dicho análisis.
 - Los estudios de casos relativos a los arreglos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, a fin de proporcionar un panorama de cómo se pusieron en marcha y cómo funcionan, podrían ser útiles para informar a los Estados Miembros de la OMS acerca de prácticas prometedoras. La OMS podría solicitarlos a los gobiernos que tienen amplia experiencia en la negociación y aplicación de acuerdos sobre la movilidad de dichos trabajadores.
 - Los entrevistados señalaron la necesidad de que se realizara un análisis exhaustivo de los diferentes acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud, su desempeño a lo largo del tiempo y sus efectos. Se indicó que la OMS podría encomendar la realización de esos estudios a fondo.
 - También se consideró útil una explicación de cada tipo de práctica prometedoras y de la forma en que se aplicaba en la práctica, y los entrevistados señalaron que tal vez la OMS podría elaborar este tipo de informes. Además del material escrito, algunos de los entrevistados recomendaron que la OMS organizara seminarios y otras actividades de colaboración con académicos, expertos y profesionales para sensibilizar a los Estados Miembros respecto de cómo se ven y funcionan en la práctica los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud.
 - Se sugirió que la OMS adoptara un perfil más destacado para trabajar con miras a mejorar el funcionamiento del Código y el respeto hacia este.
 - La OMS podría facilitar un diálogo con países comparables para asegurarse de que todos funcionen sobre la misma base en relación con los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Esto podría ayudar a asegurar enfoques similares en pro del desarrollo y la salud entre los países de destino clave.
 - La OMS podría elaborar principios para orientar en cuanto a aspectos específicos de la negociación, la aplicación y la evaluación de los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud. Asimismo, integrar una perspectiva y un análisis de género en la labor, junto con grupos con experiencia que trabajan para dismantelar las brechas de género en la prestación de servicios de atención de salud.

Conclusiones

Sobre la base de las entrevistas a fondo, hay algunas medidas que los entrevistados recomendaron que los organismos públicos tomaran para asegurar que los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud sean coherentes con los objetivos de atención de salud en los países de origen y destino y apoyen dichos objetivos, y que se atiendan adecuadamente los intereses de los propios trabajadores. Este enfoque podría incluir lo siguiente:

- Realizar, antes de las negociaciones, una evaluación de las necesidades desde la perspectiva laboral y de la atención de salud.
- Hacer que el ministerio de salud lidere las negociaciones, como también la aplicación y el seguimiento. Como mínimo, el ministerio de salud debería ser parte del equipo que negocia el acuerdo.
- Comprometerse a asegurar que el acuerdo esté en consonancia con el Código y haga referencia al Código específicamente en el texto del acuerdo.
- Adoptar un enfoque que abarque todo el gobierno, con consultas con todos los organismos públicos antes y durante las negociaciones, y durante la aplicación y la evaluación.
- Adoptar un enfoque que abarque todo el país, incluida la colaboración de forma continua con múltiples partes interesadas competentes, incluidos los grupos que podrían oponerse al arreglo sobre la movilidad de los trabajadores de salud.
- Aislar las negociaciones de la influencia política, en la medida de lo posible, mediante la aplicación de un proceso de negociación sobre los acuerdos sobre la movilidad de los trabajadores de salud y su seguimiento.
- Determinar maneras de facilitar la llegada, el registro, la capacitación y la integración de los trabajadores e incluir esto en el acuerdo, a fin de tener en cuenta el “elemento humano” de la movilidad de los trabajadores de salud.
- Crear canales para brindar apoyo personal y profesional a los trabajadores, junto con posibles procedimientos de solución de controversias para todos los trabajadores que vengan del extranjero. Asegurar la igualdad de trato ante la ley para los trabajadores de salud extranjeros y los trabajadores locales en situaciones similares.
- Considerar la posibilidad de exigir a las agencias privadas de contratación que cumplan las normas establecidas en el acuerdo de movilidad de los trabajadores de salud, a fin de asegurar la coherencia, independientemente del canal a través del cual el trabajador ingrese al país.
- Determinar un enfoque adecuado para el reconocimiento de las calificaciones, basado en una evaluación objetiva de los sistemas de capacitación y educación de los países de origen y destino, junto con medidas para superar las diferencias existentes entre ellos.
- Asumir compromisos claros y detallados para mejorar la capacitación en el país de origen a fin de compensar la salida de trabajadores de salud calificados, o acordar que el país de destino solo pueda contratar a nuevos graduados y luego capacitarlos a su llegada para que se especialicen más.
- Crear un proceso para subsanar las deficiencias del acuerdo a lo largo del tiempo, con reuniones periódicas de un comité conjunto u otro mecanismo. Incluir, en la preparación de estas reuniones, amplias consultas interinstitucionales y con partes interesadas.
- Establecer un proceso para la recopilación de datos sobre el acuerdo y proporcionar una evaluación de sus efectos en los sistemas de atención de salud, el bienestar de los trabajadores y el desplazamiento de los trabajadores.

Anexo 4. Otros instrumentos internacionales: principales disposiciones relativas a la migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud



Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud	Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular	Instrumentos de la OIT	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC	Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Calificaciones relativas a la Educación Superior
<i>Igualdad de trato con los trabajadores de salud nacionales</i> - Los agentes de salud migrantes deberían ser contratados, ascendidos y remunerados de conformidad con criterios objetivos tales como el nivel de calificación, los años de experiencia y el grado de responsabilidad profesional, sobre la base de la igualdad de trato con el personal de salud formado en el país. - Con sujeción a las leyes pertinentes, los agentes de salud migrantes deberían tener los mismos derechos y responsabilidades en el plano jurídico respecto de las condiciones de empleo y trabajo, y oportunidades e incentivos para fortalecer su formación, sus calificaciones y su desarrollo profesionales, sobre la base de la igualdad de trato con el personal de salud formado en el país. <i>Autosuficiencia respecto del personal de salud</i> - Los Estados Miembros deberían esforzarse por satisfacer sus necesidades de personal de salud utilizando en lo posible sus propios recursos humanos de salud y tomar medidas eficaces para formar, conservar y sostener agentes de salud adaptados a la situación específica de cada país, en particular en las zonas más necesitadas.	El Pacto Mundial es un acuerdo negociado a nivel intergubernamental, preparado con los auspicios de las Naciones Unidas, que abarca todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral. Se trata de un documento no vinculante que respeta el derecho soberano de los Estados a determinar quién entra y quién permanece en su territorio y demuestra su compromiso con la cooperación internacional en materia de migración. El Pacto Mundial se enmarca de manera coherente con el Objetivo 10.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que los Estados Miembros se comprometieron a cooperar a nivel internacional para facilitar una migración segura, ordenada y regular. <i>El Pacto Mundial está diseñado para:</i> - apoyar la cooperación internacional en la gobernanza de la migración internacional; - proporcionar una gama completa de opciones para los Estados, entre las cuales puedan seleccionar opciones normativas para abordar algunos de los problemas más apremiantes en torno a la migración internacional; y - dar a los Estados el espacio y la flexibilidad para llevar a cabo la aplicación sobre la base de sus propias realidades y capacidades en materia de migración. - Las acciones en el marco de los 23 objetivos del Pacto Mundial que son relevantes para los acuerdos	Migración laboral internacional <i>Instrumentos vinculantes</i> - Todas las normas internacionales de trabajo, a menos que se indique lo contrario, son aplicables a los trabajadores migrantes. Estas normas incluyen los diez convenios fundamentales de la OIT descritos en la <i>Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo</i> de 1998, en su forma enmendada por la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2022; las normas de la OIT sobre los trabajadores migrantes, las normas de aplicación general, como las relativas a la protección de los salarios y a la seguridad y salud en el trabajo, así como los convenios de gobernanza relativos a la inspección del trabajo, la política del empleo y la consulta tripartita; e instrumentos que contienen disposiciones específicas sobre los trabajadores migrantes, como el <i>Convenio sobre las agencias de empleo privadas</i>, 1997 (núm. 181), el <i>Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos</i>, 2011 (núm. 189) y los instrumentos sobre seguridad social y sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. <i>Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado)</i>, 1949 (núm. 97), el <i>Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias)</i>, 1975 (núm. 143), y las recomendaciones correspondientes, la núm. 86 y la núm. 151.	<i>Trato nacional</i> - En los sectores inscritos en su lista y con las condiciones y salvedades que en ella puedan consignarse, cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares. <i>Reglamentación nacional</i> - Con objeto de asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios, el Consejo del Comercio de Servicios, por medio de los órganos apropiados que establezca, elaborará las disciplinas necesarias. - Dichas disciplinas tendrán la finalidad de garantizar que esas prescripciones, entre otras cosas: a) se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de suministrar el servicio; b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; c) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por sí una restricción al suministro del servicio. En los sectores en los	<i>Principios para el reconocimiento de las calificaciones relativas a la educación superior</i> - El reconocimiento de las calificaciones debería ser transparente, justo, oportuno y no discriminatorio, de conformidad con las normas y los reglamentos de cada Estado Parte, y debería serasequible. - Las decisiones de reconocimiento se basan en la confianza, criterios claros y procedimientos justos, transparentes y no discriminatorios, y subrayan la importancia crucial del acceso equitativo a la educación superior como bien público que puede conducir a oportunidades de empleo. - Las decisiones de reconocimiento se basan en información adecuada, fiable, accesible y actualizada sobre los sistemas, las instituciones, los programas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior que haya sido impartida por conducto de las autoridades competentes de los Estados Partes, los centros nacionales de información oficiales o entidades similares. - Las autoridades competentes en materia de reconocimiento que realizan evaluaciones para el reconocimiento efectuarán esta labor de buena fe, aportando razones claras para sus decisiones, y contarán con mecanismos para apelar las decisiones de reconocimiento.

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud	Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular	Instrumentos de la OIT	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC	Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Calificaciones relativas a la Educación Superior
<i>Fortalecimiento de los sistemas de salud</i> - Los Estados Miembros deberían plantearse la adopción y aplicación de medidas eficaces destinadas a fortalecer los sistemas de salud, efectuar un seguimiento continuo del mercado laboral del sector y coordinar entre sí a todas las partes interesadas a fin de formar y conservar duraderamente una fuerza de trabajo en el sector de salud capaz de responder a las necesidades de salud de la población y adoptar un enfoque multisectorial para abordar esas cuestiones en sus políticas nacionales en materia de salud y desarrollo. - Los Estados Miembros deberían plantearse el fortalecimiento de las instituciones educativas a fin de ampliar la formación de profesionales de la salud, así como la elaboración de planes de	(cont.) de migración de los trabajadores de salud incluyen, entre otras cosas, compromisos para: - Promover y mejorar la cooperación y el diálogo sistemáticos a nivel bilateral, regional e internacional para intercambiar información sobre las tendencias relacionadas con la migración. - Formular acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales sobre la movilidad laboral basados en los derechos humanos y con perspectiva de género que incluyan condiciones específicas de empleo para cada sector. - Examinar y revisar las opciones y vías existentes para la migración regular, con miras a optimizar la correspondencia entre la oferta y la demanda de aptitudes en los mercados de trabajo y abordar las realidades demográficas y los desafíos y oportunidades del desarrollo. - Ampliar las opciones disponibles para la movilidad académica, incluso mediante acuerdos bilaterales y multilaterales que faciliten los intercambios académicos, como las becas para estudiantes y profesionales universitarios, las plazas de profesor visitante, los programas conjuntos de capacitación y las oportunidades de investigación internacionales.	<i>Instrumentos no vinculantes</i> - La OIT tiene dos recomendaciones específicas sobre los migrantes: la <i>Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisado)</i>, 1949 (núm. 86), que contiene en un anexo un modelo de acuerdo sobre las migraciones temporales y permanentes de trabajadores, con inclusión de la migración de refugiados y personas desplazadas; y la <i>Recomendación sobre los trabajadores migrantes</i>, 1975 (núm. 151). - Las recomendaciones de la OIT, si bien no son vinculantes, proporcionan orientación sobre cómo debe aplicarse un convenio en particular, o pueden ser un instrumento independiente que proporciona orientación detallada sobre ciertas cuestiones en el mundo del trabajo. - El <i>Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales</i> (2006) contiene principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos, con el objetivo de ayudar a los gobiernos, los interlocutores sociales y partes interesadas en sus esfuerzos por regular la migración laboral y proteger a los trabajadores migrantes. - Los <i>Principios generales y directrices para la contratación equitativa y Definición de las comisiones de contratación y gastos conexos</i> de la OIT (2019) tienen por objeto	(cont.) que se contraigan compromisos específicos respecto de los servicios profesionales, cada Miembro establecerá procedimientos adecuados para verificar la competencia de los profesionales de otros Miembros. <i>Reconocimiento</i> - A los efectos del cumplimiento, en todo o en parte, de sus normas o criterios para la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los mismos, los Miembros podrán reconocer la educación o experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o certificados otorgados en un determinado país. Ese reconocimiento, que podrá efectuarse mediante armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión o podrá ser otorgado de forma autónoma. - Ningún Miembro otorgará el reconocimiento de manera que constituya un medio de discriminación entre países en la aplicación de sus normas o criterios para la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los mismos, o una restricción encubierta al comercio de servicios.	- Los solicitantes de reconocimiento de sus calificaciones proporcionan de buena fe información y documentación adecuada y precisa sobre las calificaciones que han obtenido y tienen derecho a apelar la decisión. <i>Obligaciones de los Estados partes en la Convención</i> - Cada Estado Parte reconocerá las calificaciones de educación superior conferidas en otro Estado Parte, a menos que se pueda demostrar que existen diferencias sustanciales entre la calificación cuyo reconocimiento se solicita y la calificación correspondiente en el Estado Parte donde se solicita el reconocimiento. - Como alternativa, bastará con que un Estado Parte permita al titular de una calificación de educación superior expedida en otro Estado Parte obtener una evaluación de dicha calificación, a solicitud del titular. - Cada Estado Parte podrá supeditar el reconocimiento de las calificaciones de educación superior obtenidas mediante educación transfronteriza o instituciones educativas extranjeras que operen en su jurisdicción a los requisitos específicos de las leyes o los reglamentos del Estado Parte, o de la unidad constitutiva de este, o a acuerdos específicos concertados con el Estado Parte de origen de dichas instituciones.

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud	Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular	Instrumentos de la OIT	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC	Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Calificaciones relativas a la Educación Superior
(cont.) estudios innovadores que sirvan para satisfacer las necesidades actuales en el terreno de la salud. - Los Estados Miembros deberían plantearse la adopción de medidas para corregir los desequilibrios en la distribución geográfica del personal de salud y para favorecer su permanencia en las zonas desatendidas mediante, por ejemplo, la aplicación de actividades educativas, incentivos económicos, medidas normativas y apoyo social y profesional. - Se alienta a los Estados Miembros a establecer o fortalecer y mantener sistemas de información sobre el personal de salud, incluida la migración de personal de salud y su impacto en los sistemas de salud y reunir, analizar y transformar los datos en políticas y planes eficaces en relación con el personal de salud. <i>Migración y movilidad ordenadas</i> - Los Estados Miembros deberían mantener un registro actualizado de todos los contratistas autorizados por las autoridades competentes para desempeñar actividades en su territorio y, en lo posible, alentar y promover buenas prácticas entre las agencias de contratación de personal, utilizando únicamente a aquellas que se atengan a los principios rectores del Código. - Se alienta a los Estados Miembros a que observen y determinen la magnitud de la contratación internacional activa de personal de	Invertir en programas que aceleren el cumplimiento por los Estados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el propósito de eliminar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, por ejemplo, mediante la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud y el saneamiento, la educación, el crecimiento económico inclusivo, la infraestructura, el desarrollo urbano y rural, la creación de empleo, el trabajo decente, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación y adaptación frente al cambio climático, las medidas para abordar los efectos socioeconómicos de todas las formas de violencia, la no discriminación, el estado de derecho y la buena gobernanza, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, así como creando y manteniendo sociedades pacíficas e inclusivas con instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	(cont.) promover y garantizar una contratación justa. La definición de las comisiones de contratación y gastos conexos indica que a los trabajadores no se les cobrará directa o indirectamente, total o parcialmente, ninguna comisión ni gasto conexo relacionado con su contratación. Salud <i>Instrumentos vinculantes</i> El documento C149 – el <i>Convenio de la OIT sobre el personal de enfermería</i>, 1977 (núm. 149) y su recomendación núm. 157 describen normas laborales clave, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo del personal de enfermería. En particular, el párrafo 62 de la recomendación núm. 157 se refiere a los acuerdos bilaterales o multilaterales para: A. armonizar la instrucción y la formación que capacitan para el ejercicio de la profesión, sin menoscabo de las normas; B. fijar las condiciones para el reconocimiento mutuo de las calificaciones adquiridas en el extranjero; C. armonizar las condiciones para autorizar el ejercicio de la profesión. El párrafo 66 establece lo siguiente: El personal de enfermería extranjero debería poseer el nivel de calificaciones que la autoridad competente considere adecuado para ocupar los puestos	<i>Nación más favorecida</i> - Con respecto a toda medida abarcada por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, cada Miembro otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cualquier otro país. - Los acuerdos comerciales regionales que cumplen los requisitos del artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios pueden apartarse de la obligación relativa a la nación más favorecida del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. - Al pasar a ser Miembros de la OMC, en algunas economías se han aplicado exenciones de la obligación relativa a la nación más favorecida para determinados sectores o modos de suministro. <i>Límite cuantitativo a la entrada de personas físicas que prestan servicios, incluso en función de la necesidad</i> - En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las medidas que ningún Miembro mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su territorio, a menos que en su lista se especifique lo contrario, incluyen limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse	- Cada Estado Parte establecerá sistemas transparentes para la descripción completa de las calificaciones y los resultados del aprendizaje obtenidos en su territorio. - Cada Estado Parte, en la medida de lo posible sobre la base de su situación y estructura constitucionales, legislativas y reglamentarias, establecerá un sistema objetivo y fiable de aprobación, reconocimiento y aseguramiento de la calidad de sus instituciones de educación superior, a fin de fomentar la confianza en su sistema de educación superior.

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud	Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular	Instrumentos de la OIT	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC	Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Calificaciones relativas a la Educación Superior
(cont.) salud de los países con una escasez crítica de dicho personal, y que evalúen la amplitud y los efectos de la migración circular. • Los agentes de salud deberían tener la posibilidad de evaluar los beneficios y los riesgos asociados a los empleos, y de tomar decisiones oportunas y fundamentadas. • El personal de salud debería adoptar una actitud franca y transparente en relación con cualquier obligación contractual que pueda tener y cooperar con los organismos reguladores y las autoridades nacionales en interés de los pacientes, los sistemas de salud y las sociedades en general. <i>Apoyo a los países en desarrollo</i> • Los acuerdos bilaterales, regionales o multinacionales sobre migración y movilidad de los trabajadores de salud deberían tomar en consideración las necesidades de los países en desarrollo mediante la adopción de medidas apropiadas que podrán incluir lo siguiente: prestación de asistencia técnica eficaz y adecuada, apoyo a la conservación del personal de salud, reconocimiento social y profesional del personal de salud, apoyo a la formación en los países de origen que se adapte al perfil de morbilidad en esos países,		(cont.) disponibles y cumplir cualquier otra condición exigida para el ejercicio de la profesión en el país de empleo; el personal extranjero que participe en programas de intercambio organizados podrá ser exento de esta última obligación. 2. El empleador debería asegurarse de que el personal de enfermería extranjero posee un adecuado conocimiento del idioma para el puesto que va a ocupar. 3. A equivalencia de calificaciones, el personal extranjero debería disfrutar de condiciones de empleo tan favorables como las del personal nacional en puestos que impliquen los mismos deberes y responsabilidades.	(cont.) en un determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. <i>Apoyo a los países en desarrollo</i> • Se facilitará la creciente participación de los países en desarrollo Miembros en el comercio mundial mediante compromisos específicos negociados por los diferentes Miembros en relación con: a) el fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad, mediante, entre otras cosas, el acceso a la tecnología en condiciones comerciales; b) la mejora de su acceso a los canales de distribución y las redes de información; y c) la liberalización del acceso a los mercados en sectores y modos de suministro de interés para sus exportaciones.	

Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud	Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular	Instrumentos de la OIT	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC	Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Calificaciones relativas a la Educación Superior
(cont.) hermanamientos de centros de salud, apoyo a la creación de capacidad en la elaboración de marcos reglamentarios adecuados, acceso a formación especializada, transferencia de tecnología y de conocimientos, y apoyo a la migración de retorno, ya sea temporal o permanente. - Se alienta a las organizaciones y organismos donantes internacionales, las instituciones financieras y de desarrollo y demás organizaciones competentes a que presten el apoyo técnico y financiero para ayudar a aplicar el Código y apoyar el fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo. <i>Sostenibilidad de la fuerza laboral en los países de origen</i> - En la medida de lo posible, los empleadores y los contratistas deberían tener presentes y considerar las responsabilidades legales pendientes del personal de salud con el sistema de salud de su propio país, por ejemplo, un contrato de servicio justo y razonable, y abstenerse de contratarlo. - Se alienta a los países de destino a colaborar con los países de origen para mantener y fomentar el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos de salud según corresponda y desalentar la contratación activa de personal de salud procedente de países en desarrollo que sufren una grave escasez de trabajadores de salud.				

La migración y la movilidad internacionales de los trabajadores de salud han aumentado en volumen y complejidad en las últimas décadas. Si no se gestiona adecuadamente, la migración de trabajadores de salud de países de ingresos bajos y medianos puede agravar la escasez y debilitar los sistemas de salud de estos países, aumentando las desigualdades. Esto, a su vez, puede amenazar la seguridad sanitaria internacional, con graves repercusiones para las economías y las sociedades de todo el mundo. Entre las distintas vías para el desplazamiento de los trabajadores de salud, los acuerdos entre gobiernos encierran un importante potencial para garantizar que los trabajadores de salud y los sistemas de salud de los países participantes se beneficien de la migración y la movilidad de estos trabajadores.

Esta guía es una herramienta para mejorar la capacidad de los agentes estatales implicados en el desarrollo, la negociación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos relacionados con la migración y la movilidad del personal sanitario internacional, manteniendo en primer plano las prioridades del sistema sanitario, en consonancia con las disposiciones del Código de prácticas mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contratación internacional de personal de salud. Las consideraciones políticas de este documento se aplican a todos los acuerdos entre gobiernos que se centren, tengan un componente o puedan tener un impacto en la migración y la movilidad del personal de salud.

Las orientaciones sobre acuerdos bilaterales en materia de migración y movilidad del personal de salud han sido elaboradas por la OMS y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, junto con la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del programa Trabajar por la Salud.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

